

2º Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas 2025

Índice

Introdução.....	3
1. Demonstrativo de cumprimento, pela União, da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde	5
2. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira até o 2º Quadrimestre de 2025	7
2.1. Execução Orçamentária da Despesa por Secretaria/Unidade.....	9
2.2. Execução Orçamentária da Despesa – Grandes grupos	21
2.3. Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso	26
2.4. Execução Orçamentária da Despesa dos Hospitais Próprios / Institutos no RJ.....	27
2.5. Saldo Financeiro nas Contas Bancárias do Ministério da Saúde	29
2.6. Execução de Restos a Pagar.....	32
2.7. Acompanhamento Mensal da Receita Própria e Vinculada em 2025	37
3. Desembolso Financeiro no 2º Quadrimestre de 2025	38
3.1 Transferências Fundo a Fundo por Bloco, Programa, Região e UF – Pagamentos Totais Efetuados (inclusive RAP)	38
3.2. Transferências a Estados, Municípios e Distrito Federal – Modalidade de Aplicação.....	40
4. Oferta e Produção de Serviços – Rede Própria, GHC e Institutos	41
5. Resultados dos Objetivos da PAS – 2º Quadrimestre de 2025	42
Objetivo 1. Fortalecer a atenção primária, ampliando a cobertura da Estratégia Saúde da Família e da Saúde Bucal, com vistas à universalização do acesso, à abrangência do cuidado integral, à promoção da saúde, à prevenção de doenças e agravos e à redução de desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais. ..	42
Objetivo 2. Ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.	56
Objetivo 3. Reduzir e controlar doenças e agravos passíveis de prevenção e controle, com enfoque na superação das desigualdades de acesso, regionais, sociais, de raça/etnia e gênero.....	71
Objetivo 4. Promover o desenvolvimento científico e tecnológico para produção, inovação e avaliação em saúde a fim de atender a população de forma equitativa, sustentável, acessível, considerando a sociobiodiversidade territorial e contribuindo para a prosperidade econômica, social e redução da dependência de insumos para a saúde.	81
Objetivo 5. Ampliar o acesso da população aos medicamentos, insumos estratégicos e serviços farmacêuticos, qualificando a assistência farmacêutica, articulada à pesquisa, à inovação e à produção nacional, regulação, com qualidade e uso adequado no Sistema Único de Saúde, reduzindo as iniquidades.	90
Objetivo 6. Promover e qualificar a oferta de ações e serviços de saúde e saneamento ambiental, considerando os diferentes contextos étnico-culturais da população indígena, em articulação e fortalecimento dos saberes e práticas tradicionais.	98
Objetivo 7. Aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.	104
ANEXO	117
Anexo I – Atividades de Auditoria Interna do SUS – 2º Quadrimestre de 2025.....	118

Introdução

O presente Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC) visa apresentar o desempenho do Ministério da Saúde (MS) referente ao segundo quadrimestre de 2025, com dados acumulados de janeiro a agosto.

O instrumento é detalhado de acordo com o art. 36 da Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, e foi formatado com base na Programação Anual de Saúde (PAS) de 2025, que apresenta a execução anual prevista das metas que compõem o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2024-2027. Foram incorporadas, ademais, as sugestões pertinentes apresentadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio da Resolução n.º 741, de 22 de fevereiro de 2024, que aprova o PNS 2024-2027.

Além disso, a estruturação do PNS 2024-2027 levou em consideração as orientações estratégicas definidas pelo CNS e as linhas diretrizes e propostas construídas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em julho de 2023, conforme formalizado pela Resolução CNS n.º 715, de 20 de julho de 2023. Definidas essas diretrizes, o MS despendeu esforços para estabelecer os objetivos, as metas e os indicadores, permitindo a aferição do grau de alcance dos resultados pretendidos.

Destaca-se, também, a compatibilização realizada entre os objetivos estratégicos que norteiam a gestão federal do SUS e os respectivos instrumentos de planejamento (PNS e PAS) com os objetivos, as metas e as iniciativas que constam no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 e as ações da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Tais instrumentos subsidiam a atuação governamental e propiciam a transparência da gestão, potencializando o planejamento, o monitoramento e a avaliação do gasto público em saúde.

Neste sentido, este RQPC contempla as alterações realizadas no PNS 2024-2027 e na PAS 2025 em decorrência da revisão do PPA 2024-2027 para o ano de 2025, garantindo assim o alinhamento entre os instrumentos federais de planejamento. A partir das orientações da Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), órgão responsável por coordenar a atualização do Plano Plurianual, e considerando o processo de monitoramento e avaliação do Plano, as áreas técnicas do Ministério da Saúde indicaram as alterações pertinentes ao PPA, que passaram a integrar também o PNS e a PAS 2025 e, consequentemente, o 2º RQPC 2025.

Os dados que permitem a análise dos resultados acumulados no segundo quadrimestre de 2025 foram extraídos dos sistemas oficiais de informações em saúde. A alimentação dessas bases de dados conta com a participação tanto dos profissionais das secretarias de saúde dos entes federados quanto dos profissionais deste Ministério.

Cabe mencionar que, em alguns casos, o alcance das metas não depende exclusivamente da atuação da gestão federal do SUS, dependendo conjuntamente do esforço realizado pelos demais entes federados (estados, Distrito Federal e municípios).

A prestação de contas dos resultados obtidos permite a atuação do controle social e das instâncias bipartite e tripartite. Possibilita ainda a avaliação das ações em curso, a fim de identificar oportunidades de melhoria. Portanto, o desempenho observado até o final do quadrimestre em tela deve ser avaliado de modo a propiciar a reflexão sobre a participação federal na implementação das políticas de saúde e na obtenção dos resultados alcançados, considerando o modelo de gestão descentralizado do SUS.

A forma como estão sistematizadas as informações do presente relatório busca expor o desempenho das principais linhas de atuação inscritas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) do MPO e no Sistema de Planejamento e Monitoramento (Siplam) do MS, bem como guarda coerência com as peças orçamentárias e prestações de contas dirigidas ao Congresso Nacional e aos órgãos de controle da administração pública.

Este RQPC está organizado, além desta Introdução, em cinco seções e um anexo:

- A Seção 1 traz um demonstrativo que evidencia o cumprimento do mínimo constitucional do financiamento da União das ações e serviços públicos de saúde;
- A Seção 2 apresenta a execução orçamentária e financeira dos recursos federais em geral, destacando neste documento, além das unidades hospitalares próprias, a execução orçamentária da despesa por Secretaria/Unidade do Ministério;
- A Seção 3 apresenta a execução financeira por meio das transferências fundo a fundo a estados e municípios, segundo os grandes blocos de financiamento e modalidades de aplicação;

- A Seção 4 quantifica a produção no âmbito federal de bens, insumos e serviços de saúde, com destaque para a rede própria de hospitais federais; e

- A Seção 5 permite a formulação de uma análise situacional dos objetivos estratégicos por meio da comparação dos resultados atingidos no segundo quadrimestre de 2025, relacionando-os com a meta anual proposta na PAS 2025 e em outras programações da Pasta.

No anexo 1 são apresentados os resultados das atividades de auditoria interna do SUS realizadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) de janeiro a agosto de 2025.

1. Demonstrativo de cumprimento, pela União, da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a saúde é um direito de todos e uma responsabilidade do Estado, criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantiu, conforme o disposto no inciso I do § 2º do art. 198, a existência de limites mínimos orçamentários a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

De acordo com o preceito constitucional vigente, a União deve aplicar em ASPS, no mínimo, 15% da receita corrente líquida (RCL) apurada no exercício financeiro.

A forma de cálculo do limite mínimo a ser aplicado em ASPS sofreu alterações ao longo do tempo, mas, desde 2024, voltou a ser calculado com base na receita corrente líquida, após sete anos sob uma regra que restringia a ampliação das despesas do Poder Executivo Federal como um todo, comumente chamada de “Teto de Gastos”, amparada por força da Emenda Constitucional n.º 95, de 2016. Com a promulgação da EC n.º 126/2022, a EC 95/2006 foi revogada e, na sequência, foi instituído o novo arcabouço fiscal, por meio da Lei Complementar n.º 200/2023.

O orçamento federal para 2025 foi estabelecido pela Lei n.º 15.121, de 10 de abril de 2025 (LOA 2025). Para a saúde, a dotação orçamentária aprovada para ASPS foi de R\$ 232,8 bilhões, sendo que o limite mínimo estimado para 2025 é de 232,3 bilhões, montante equivalente aos 15% da RCL.

Este Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas introduz, primeiramente, o Quadro 1, a seguir, que parte da estimativa de Receita Corrente Líquida, usada como parâmetro para a elaboração do PLOA 2025, à qual se aplica o percentual de 15% para se chegar ao montante mínimo, denominado como Piso 2025.

Contudo, como a Constituição define que o piso da saúde deve ser contabilizado com base na RCL efetivamente apurada no exercício, ele fica sujeito a reestimativas que vão se atualizando ao longo do ano e só pode ser conhecido definitivamente após o encerramento do exercício.

Quadro 1 – Cálculo da Aplicação Mínima em ASPS

(em R\$ milhões)

ITEM	EC 86/2015
RCL Estimada	1.545.864
Percentual	15%
Mínimo ASPS	231.880

Fonte: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) – STN.

A apuração e comprovação da aplicação de recursos em ações e serviços de saúde pública tem sido realizada a cada exercício e registrada na forma de histórico. O quadro 2 agrega a informação da aplicação mínima constitucional em saúde atualmente prevista para 2025, juntamente à apresentação do histórico de aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), que foram, a todo tempo, superiores ao piso constitucional, desde 2017. Há de se acrescentar que a Lei Complementar n.º 200, de 30 de agosto de 2023, em consonância com o art. 6º da Emenda Constitucional n.º 126, de 21 de dezembro de 2022, instituiu o novo “*regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico*”. Como consequência, foram revogados artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterando o parâmetro para cálculo da aplicação mínima em ASPS a partir de 2024, que voltou a ser regido pela EC 86/2015.

Quadro 2 – Histórico do Cálculo da Aplicação Mínima Constitucional em Saúde

(em R\$ bilhões)

ITEM	RCL/PISO APURADO (EC 95/2016)	RCL/PISO APURADO (EC 113/2021)	RCL/PISO APURADO (EC 86/2015)	APLICAÇÃO EM ASPS	APLICAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO	DESPESAS ASPS NÃO COMPUTADAS PARA O PISO ⁽¹⁾	TOTAL ACIMA DO PISO
RCL 2017	727,3	727,3		-	-	-	-
Piso 2017 (15% da RCL)	109,1	109,1		114,7	5,6	0,6	6,2
Piso 2018 (Piso 2017 + IPCA 3,0% ⁽²⁾)	112,4	112,4		116,8	4,4	0,6	5
Piso 2019 (Piso 2018 + IPCA 4,39% ⁽³⁾)	117,3	117,3		122,3	5	1,5	6,5
Piso 2020 (Piso 2019 + IPCA 3,37% ⁽⁴⁾)	121,2	121,3		161	39,7	1,4	41,1
Piso 2021 (Piso 2020 + IPCA 4,52% ⁽⁵⁾)		127		179,1	52,1	1,8	53,9
Piso 2022 (Piso 2021 + IPCA 10,06% ⁽⁶⁾)		139,8		151,9	12,1	1,3	13,4
Piso 2023 (Piso 2022 + IPCA 5,79% ⁽⁷⁾)		147,9		179,8	31,9	2,6	34,5
Piso 2024 (15% da RCL ⁽⁸⁾)			214,5	215,9	1,4	2,5	3,9
Piso 2025 (15% da RCL ⁽⁹⁾)			231,9	150,5	-81,4	0	-81,4

(*1) Reposição de Restos a Pagar Cancelados e Royalties do Petróleo somente até 2021.

(*2) Acumulado de julho de 2016 a junho de 2017. (*7) Acumulado de janeiro a dezembro de 2022 (PARECER SEI N.º 7/2024/MF da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).

(*3) Acumulado de julho de 2017 a junho de 2018.

(*4) Acumulado de julho de 2018 a junho de 2019.

(*5) Acumulado de janeiro a dezembro de 2020 (EC n.º 113/2021).

(*6) Acumulado de janeiro a dezembro de 2021.

(*7) Acumulado de janeiro a dezembro de 2022 (PARECER SEI N.º 7/2024/MF da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).

(*8) Acumulado de janeiro a dezembro de 2024.

(*9) Acumulado de janeiro a agosto de 2025.

Fonte: Tesouro Gerencial (20/8/2025).

A apuração da aplicação em ASPS segue ocorrendo de acordo com previsão do artigo 24 da Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012. Ao final do segundo quadrimestre de 2025, a União já empenhou R\$ 150,5 bilhões em ASPS.

Sobre a tramitação do PLOA 2025 aprovado no Congresso Nacional, é importante apontar as seguintes alterações ocorridas em despesas ASPS, que por fim, representou ampliação da dotação ASPS em R\$ 4,2 bilhões:

- Redução das dotações para despesas Discricionárias e do PAC ASPS do MS, no valor de R\$ 1.872,8 milhões;
- Reclassificação das dotações destinadas à Anvisa no PLOA, de ASPS para não ASPS, em R\$ 747,4 milhões;
- No PLOA 2025, foram reservados R\$ 19.477,2 milhões para emendas obrigatórias. Entretanto, na LOA foram aprovados R\$ 13.138,9 milhões para emendas individuais (RP6) e R\$ 7.312,6 milhões para emendas de bancada (RP7), totalizando R\$ 20.451,5 milhões, o que correspondeu a um aumento de R\$ 974 milhões (5%) do montante de dotações de emendas obrigatórias ASPS;
- Não havia previsão de recursos para emendas de comissão no PLOA 2025, mas o Congresso incluiu na LOA o correspondente a R\$ 5.866,8 milhões em emendas desse tipo (RP8);
- Por fim, houve a inclusão na LOA 2025, durante o trâmite legislativo, de dotações discricionárias no montante de R\$ 4.313,4 milhões, sendo R\$ 313,4 milhões em RP2 (primário discricionário) e R\$ 4.000,0 milhões em RP3 (PAC). Tais recursos foram utilizados para recompor, via crédito, dotações diminuídas pelo Congresso: R\$ 1.498,5 milhões redirecionados para a saúde indígena (ação 20YP) e R\$ 2.600,2 milhões para o Programa Mais Médicos (ação 21BG). Estas duas políticas tiveram suas dotações recompostas integralmente. Adicionalmente, R\$ 214,7 milhões foram destinados à recomposição parcial de ações do PAC e para publicidade de utilidade pública.

O quadro 3, a seguir, tem como objetivo demonstrar, considerando a execução parcial neste exercício, a apuração do piso constitucional da aplicação mínima em ASPS. Partindo do piso calculado a partir do preceito constitucional, passando pela dotação inicial, dada com a sanção da Lei Orçamentária Anual 2025, seguida da respectiva dotação atualizada até o fechamento do segundo quadrimestre.

Quadro 3 - Posição final da análise do cumprimento do Piso em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS – 2º Quadrimestre de 2025

		(em milhares)
(A)	Receita Corrente Líquida (RCL) 2025	1.545.864.058
(B)	Piso Mínimo ASPS 15% RCL	231.879.609
(C)	Dotação atualizada ASPS 2025	232.801.274
(D)	Total empenhado ASPS 2025	150.454.347
(E)	Reposição de RAP cancelado	0
(F) = (D) – (E)	Despesas empenhadas computadas para o mínimo em 2025	150.454.347
(G) = (F) – (B)	Situação de cumprimento do piso	-81.425.262

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Destaca-se que as despesas a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não foram computadas para apuração do piso constitucional na Lei Orçamentária para 2025, seguindo o entendimento já aplicado anteriormente pelo Congresso Nacional durante, sob o argumento da mudança do enquadramento das despesas após a sanção da Lei n.º 13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a autonomia de gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras.

2. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira até o 2º Quadrimestre de 2025

A despesa autorizada ao Ministério da Saúde (Órgão 36000) em 2025 foi definida pela Lei n.º 15.121, de 10 de abril de 2025, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro (Lei Orçamentária Anual – LOA 2025). A dotação inicial (ASPS e não-ASPS) foi fixada em R\$ 246,5 bilhões, sendo que o valor atualizado ao fim do 2º quadrimestre correspondeu a R\$ 247,7 bilhões.

Sob a ótica exclusivamente das emendas orçamentárias, do montante atualizado de R\$ 247,7 bilhões, R\$ 20,6 bilhões são atinentes a emendas parlamentares individuais e de bancada de execução obrigatória, reconhecidas por identificador de resultado primário RP 6 e RP 7, respectivamente. As dotações autorizadas pela LOA 2025 contam ainda com R\$ 5,9 bilhões em emendas de comissão (RP 8).

Nos quadros a seguir são detalhadas, em diferentes modos de organização e níveis de agregação, informações sobre a previsão e execução de receitas e despesas atribuídas ao Ministério da Saúde na Lei Orçamentária Anual para 2025 e seus créditos adicionais, considerado o período de referência de janeiro a agosto.

Quadro 4 - Execução Orçamentária e Financeira – 2º Quadrimestre de 2025 - Despesas ASPS e Não ASPS

(em R\$1)

ITEM	EXECUTADO EM 2024	PLoa 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL MS	231.865.128.582,92	241.579.043.751	246.557.970.224	247.698.130.474	163.132.864.419	138.468.259.618	134.267.710.467	84.565.266.055	65,86%	55,90%	34,14%
TOTAL ASPS	218.396.742.125,31	228.320.506.890	232.518.875.482	232.801.274.484	150.454.346.898	129.365.325.316	126.204.923.994	82.346.927.586	64,63%	55,57%	35,37%
PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ASPS	8.315.729.740,44	9.200.090.546	8.702.452.286	9.177.599.249	8.007.035.321	5.818.635.237	5.301.452.786	1.170.563.928	87,25%	63,40%	12,75%
PESSOAL - ATIVO	7.610.839.262,21	8.396.512.042	7.918.260.891	8.352.078.860	7.282.426.407	5.287.514.290	4.824.119.363	1.069.652.453	87,19%	63,31%	12,81%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	704.890.478,23	803.578.504	784.191.395	825.520.389	724.608.914	531.120.947	477.333.423	100.911.475	87,78%	64,34%	12,22%
SUB TOTAL - OCC – ASPS	210.081.012.384,87	219.120.416.344	223.816.423.196	223.623.675.235	142.447.311.578	123.546.690.079	120.903.471.208	81.176.363.657	63,70%	55,25%	36,30%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	185.147.904.239,52	199.068.747.366	196.938.281.222	196.585.257.661	131.092.135.157	116.107.434.770	113.474.591.475	65.493.122.504	66,68%	59,06%	33,32%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		19.608.338.200	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA FISCAL		131.179.002	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA FINANCEIRA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA ESPECÍFICA		19.477.159.198	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	141.123.214,41	443.330.778	431.229.081	452.422.352	441.182.890	441.182.879	441.182.879	11.239.462	97,52%	97,52%	2,48%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.499.329,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EMENDAS ASPS - ASPS	24.789.485.601,45	0	26.315.733.891	26.436.836.120	10.913.993.531	6.998.072.430	6.987.696.854	15.522.842.589	41,28%	26,47%	58,72%
EMENDA BANCADA DISCRICIONÁRIA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EMENDA INDIVIDUAL	13.276.880.491,45	0	13.136.289.146	13.136.289.146	10.913.993.531	6.998.072.430	6.987.696.854	2.222.295.615	83,08%	53,27%	16,92%
EMENDA BANCADA	3.728.153.323,00	0	7.312.611.412	7.433.713.641	0	0	0	7.433.713.641	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA COMISSÃO	7.784.451.787,00	0	5.866.833.333	5.866.833.333	0	0	0	5.866.833.333	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL NÃO ASPS	13.468.386.457,61	13.258.536.861	14.039.094.742	14.896.855.990	12.678.517.521	9.102.934.301	8.062.786.473	2.218.338.469	85,11%	61,11%	14,89%
PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - NÃO ASPS	12.387.187.491,02	12.017.480.412	12.515.118.672	13.527.194.513	12.327.409.035	8.814.023.354	7.778.806.003	1.199.785.478	91,13%	65,16%	8,87%
PESSOAL - ATIVO	638.640.572,59	203.787.836	682.038.987	755.796.826	554.596.385	476.058.177	407.234.927	201.200.441	73,38%	62,99%	26,62%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	11.414.728.456,33	11.510.196.666	11.510.196.666	12.438.042.607	11.455.484.139	8.091.066.325	7.153.302.743	982.558.468	92,10%	65,05%	7,90%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	333.818.462,10	303.495.910	322.883.019	333.355.080	317.328.510	246.898.852	218.268.333	16.026.570	95,19%	74,06%	4,81%
SUBTOTAL - OCC - NÃO ASPS	1.081.198.966,59	1.241.056.449	1.523.976.070	1.369.661.477	351.108.486	288.910.947	283.980.470	1.018.552.991	25,63%	21,09%	74,37%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	1.075.187.541,11	774.414.726	1.012.078.714	886.306.017	278.317.040	216.995.865	212.075.117	607.988.977	31,40%	24,48%	68,60%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		38.900.005	38.900.005	38.900.005	0	0	0	38.900.005	0,00%	0,00%	100,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA FISCAL		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA FINANCEIRA		38.900.005	38.900.005	38.900.005	0	0	0	38.900.005	0,00%	0,00%	100,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA ESPECÍFICA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	341.286,00	54.823.652	66.925.349	68.965.387	68.965.381	68.965.381	68.965.381	6	100,00%	100,00%	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.711.396,92	372.918.066	403.500.000	372.918.066	3.826.065	2.949.701	2.939.973	369.092.001	1,03%	0,79%	98,97%
EMENDAS ASPS - NÃO ASPS	2.958.742,56	0	2.572.002	2.572.002	0	0	0	2.572.002	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA BANCADA DISCRICIONÁRIA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EMENDA INDIVIDUAL	1.630.000,00	0	2.572.002	2.572.002	0	0	0	2.572.002	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA BANCADA		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EMENDA COMISSÃO	1.328.742,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025).

2.1. Execução Orçamentária da Despesa por Secretaria/Unidade

Quadro 5 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Consolidado por Secretaria/Unidade

(em R\$1)

UNIDADE		EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
SE	SECRETARIA EXECUTIVA	15.979.110.615	36.291.034.800	16.714.231.898	17.517.651.335	15.599.272.678	10.909.982.644	9.740.156.808	1.918.378.657	89,05%	62,28%	10,95%
SAES	SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	98.721.865.891	86.633.729.952	104.210.766.106	99.907.894.917	60.823.259.692	55.648.145.476	55.312.405.016	39.084.635.225	60,88%	55,70%	39,12%
SAPS	SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	48.767.176.600	42.568.928.447	54.793.093.911	54.751.740.267	33.573.037.061	31.423.170.694	31.353.676.241	21.178.703.206	61,32%	57,39%	38,68%
SECTICS	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPLEXO DA SAÚDE	20.120.729.175	25.801.035.358	24.732.657.689	22.947.590.744	17.775.125.709	11.542.440.091	10.531.241.429	5.172.465.035	77,46%	50,30%	22,54%
SEIDIGI	SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL	885.762.588	1.213.010.000	1.173.878.174	1.249.314.649	297.299.702	190.149.161	163.201.722	952.014.947	23,80%	15,22%	76,20%
SESAI	SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA	3.081.019.570	2.919.400.000	1.463.565.097	3.164.249.443	2.083.123.902	1.898.333.294	1.834.403.580	1.081.125.541	65,83%	59,99%	34,17%
SGTES	SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE	12.552.620.943	18.134.736.768	15.540.119.149	18.506.266.412	10.247.728.461	10.077.593.019	9.770.955.538	8.258.537.951	55,37%	54,46%	44,63%
SVSA	SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	12.281.850.972	12.988.571.420	13.054.407.837	13.266.429.108	9.528.104.783	6.308.205.259	6.122.885.440	3.738.324.325	71,82%	47,55%	28,18%
FIOCRUZ	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	9.822.839.612	8.734.524.917	8.575.619.223	9.545.910.464	8.218.742.922	6.366.604.309	5.638.358.354	1.327.167.542	86,10%	66,69%	13,90%
FUNASA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	2.149.878.092	2.785.535.841	2.786.535.842	2.919.648.260	2.346.642.068	1.654.500.209	1.525.124.300	573.006.192	80,37%	56,67%	19,63%
GHC	GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO	2.298.389.240	2.127.857.988	2.101.835.104	2.411.540.052	1.638.828.821	1.590.121.232	1.511.561.992	772.711.231	67,96%	65,94%	32,04%
TOTAL		226.661.243.298,63	240.198.365.491	245.146.710.030	246.188.235.651	162.131.165.799	137.609.245.386	133.503.970.420	84.057.069.852	65,86%	55,90%	34,14%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)
*Observação: Não inclui Anvisa e ANS

Quadro 6 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria Executiva (SE)

(em R\$1)

SE	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	15.979.110.615	36.291.034.800	16.714.231.898	17.517.651.335	15.599.272.678	10.909.982.644	9.740.156.808	1.918.378.657	89,05%	62,28%	10,95%
PESSOAL - ATIVO	4.758.348.703	5.045.098.757	5.045.098.757	5.090.763.795	4.757.875.313	3.193.247.444	2.909.962.665	332.888.482	93,46%	62,73%	6,54%
09HB	698.573.389	719.047.797	719.047.797	748.043.128	698.434.235	459.299.445	459.299.445	49.608.893	93,37%	61,40%	6,63%
20TP	4.059.775.314	4.326.050.960	4.326.050.960	4.342.720.667	4.059.441.078	2.733.947.999	2.450.663.219	283.279.589	93,48%	62,95%	6,52%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	784.780.797	845.045.270	845.045.270	829.247.147	773.973.612	555.814.158	488.489.871	55.273.535	93,33%	67,03%	6,67%
0536	5.920.931	6.109.574	6.109.574	6.109.574	6.109.574	4.243.122	3.712.377	0	100,00%	69,45%	0,00%
2004	239.201.028	230.434.680	230.434.680	230.434.680	230.434.680	180.231.405	158.376.744	0	100,00%	78,21%	0,00%
212B	539.658.838	608.501.016	608.501.016	592.702.893	537.429.358	371.339.631	326.400.750	55.273.535	90,67%	62,65%	9,33%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	9.208.729.070	9.273.823.173	9.273.823.173	10.044.895.595	9.208.293.685	6.531.499.909	5.775.211.667	836.601.910	91,67%	65,02%	8,33%
0056	0	13.000	13.000	13.000	0	0	0	13.000	0,00%	0,00%	100,00%
0181	9.208.729.070	9.273.810.173	9.273.810.173	10.044.882.595	9.208.293.685	6.531.499.909	5.775.211.667	836.588.910	91,67%	65,02%	8,33%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	1.227.252.045	1.518.729.400	1.418.985.696	1.403.485.696	859.130.068	629.421.133	566.492.606	544.355.628	61,21%	44,85%	38,79%
15WP	9.027.718	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
163M	7.074.224	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
166C	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
2000	467.336.531	722.500.000	697.500.000	647.500.000	305.725.142	254.576.365	219.412.333	341.774.858	47,22%	39,32%	52,78%
2016	28.513.927	31.000.000	31.000.000	33.500.000	26.979.423	25.520.448	25.508.172	6.520.577	80,54%	76,18%	19,46%
20AB	272.976.000	273.000.000	273.000.000	273.000.000	247.228.284	164.824.856	164.824.856	25.771.716	90,56%	60,38%	9,44%
20QG	7.465.202	7.300.000	7.300.000	7.300.000	1.266.896	901.678	901.678	6.033.104	17,35%	12,35%	82,65%
20YQ	17.357.800	10.629.400	10.629.400	10.629.400	0	0	0	10.629.400	0,00%	0,00%	100,00%
216H	3.685.578	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.683.998	2.674.811	2.313.765	816.002	76,69%	76,42%	23,31%
218U	19.690.972	20.000.000	20.000.000	20.000.000	13.333.333	13.333.333	13.333.333	6.666.667	66,67%	66,67%	33,33%
21EC	23.444.778	26.000.000	26.000.000	26.000.000	18.147.120	16.013.306	9.512.744	7.852.880	69,80%	61,59%	30,20%
21GZ	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0,00%	0,00%	100,00%
2B52	29.410.371	31.000.000	31.000.000	31.000.000	28.565.017	16.825.817	10.855.127	2.434.983	92,15%	54,28%	7,85%
4572	6.475.878	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.004.849	3.433.576	1.726.950	495.151	91,00%	62,43%	9,00%
4641	278.204.043	286.300.000	211.300.000	246.300.000	171.799.908	106.385.009	97.380.389	74.500.092	69,75%	43,19%	30,25%
6182	7.950.588	27.600.000	27.600.000	27.600.000	6.826.413	2.730.987	2.654.176	20.773.587	24,73%	9,89%	75,27%
8287	32.065.066	40.000.000	40.000.000	37.500.000	19.258.756	13.019.495	9.012.694	18.241.244	51,36%	34,72%	48,64%
8708	10.524.356	12.000.000	14.000.000	12.000.000	4.528.033	3.386.456	3.384.419	7.471.967	37,73%	28,22%	62,27%
8715	6.049.015	19.700.000	17.956.296	19.456.296	7.782.896	5.794.996	5.671.969	11.673.400	40,00%	29,78%	60,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA ESPECÍFICA	0	19.477.159.198	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0208	0	19.477.159.198	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA CONTIGÊNCIA FISCAL	0	131.179.002	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%
0201	0	131.179.002	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA INDIVIDUAL	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0,00%	0,00%	100,00%
4641	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 7 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES)

(em R\$ 1)

SAES	EXECUTADO EM 2024	POA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	98.721.865.891	86.633.729.952	104.210.766.106	99.907.894.917	60.823.259.692	55.648.145.476	55.312.405.016	39.084.635.225	60,88%	55,70%	39,12%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	85.376.210.830	86.633.729.952	90.371.988.021	86.170.953.307	55.720.941.738	52.770.659.925	52.434.919.465	30.450.011.569	64,66%	61,24%	35,34%
00QB	3.169.878	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00	0,00	100,00%
0220	18.714	23.000	23.000	23.000	23.000	21.454	21.454	0	100,00%	93,28%	0,00%
125H	13.438.798	133.000.000	60.527.290	52.599.046	0	0	0	52.599.046	0,00%	0,00%	100,00%
15EG	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
15W2	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20AI	37.393.450	44.000.000	44.000.000	44.000.000	26.289.100	25.870.830	25.870.830	17.710.900	59,75%	58,80%	40,25%
20QJ	5.994.569	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000	57.044	57.044	9.850.000	1,50%	0,57%	98,50%
20SP	19.749.099	48.000.000	48.000.000	46.000.000	22.785.740	20.231.393	17.557.952	23.214.260	49,53%	43,98%	50,47%
20YQ	86.905.290	80.000.000	80.000.000	132.000.000	99.707.510	91.783.956	70.727.957	32.292.490	75,54%	69,53%	24,46%
21CD	32.959.508	150.600.000	150.600.000	115.350.000	64.374.398	35.518.434	12.496.556	50.975.602	55,81%	30,79%	44,19%
21D9	52.471.959	70.000.000	47.754.621	60.000.000	8.400.000	0	0	51.600.000	14,00%	0,00%	86,00%
21DX	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
2E90	0	0	94.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4295	1.639.999.830	1.707.000.000	1.707.000.000	1.707.000.000	1.370.716.526	671.383.659	577.346.439	336.283.474	80,30%	39,33%	19,70%
6148	1.368.831.560	1.460.000.000	1.499.101.849	1.460.000.000	1.095.000.000	973.333.333	973.333.333	365.000.000	75,00%	66,67%	25,00%
6217	866.743.172	893.450.000	893.450.000	893.450.000	467.888.499	414.505.776	392.253.967	425.561.501	52,37%	46,39%	47,63%
6516	8.321.771	14.000.000	14.000.000	11.000.000	4.299.899	0	0	6.700.101	39,09%	0,00%	60,91%
8535	4.411.090.878	3.395.257.300	7.095.131.609	3.031.131.609	119.566.797	7.744.606	7.744.606	2.911.564.812	3,94%	0,26%	96,06%
8585	75.983.344.044	77.736.399.652	77.736.399.652	77.736.399.652	51.853.961.205	50.040.670.199	49.904.815.079	25.882.438.447	66,70%	64,37%	33,30%
8721	2.800.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8755	115.545.610	150.000.000	150.000.000	150.000.000	93.385.562	65.334.666	60.016.646	56.614.438	62,26%	43,56%	37,74%
8758	481.676.611	469.000.000	469.000.000	469.000.000	346.524.366	298.538.752	277.364.902	122.475.634	73,89%	63,65%	26,11%
8759	245.756.090	237.000.000	237.000.000	237.000.000	147.869.135	125.665.823	115.312.699	89.130.865	62,39%	53,02%	37,61%
EMENDA INDIVIDUAL	6.236.421.031	0	6.525.100.360	6.525.100.360	5.102.317.954	2.877.485.551	2.877.485.551	1.422.782.406	78,20%	44,10%	21,80%
21CD	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0,00%	0,00%	100,00%
21D9	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2E90	5.095.708.466	0	5.314.497.567	5.314.497.567	4.943.788.246	2.864.386.205	2.864.386.205	370.709.321	93,02%	53,90%	6,98%
6148	12.400.000	0	8.200.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0,00%	0,00%	100,00%
8535	1.106.165.429	0	1.196.042.793	1.196.042.793	158.529.708	13.099.346	13.099.346	1.037.513.085	13,25%	1,10%	86,75%
8755	11.013.165	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0,00%	0,00%	100,00%
8758	10.734.003	0	4.160.000	4.160.000	0	0	0	4.160.000	0,00%	0,00%	100,00%
8759	199.968	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA BANCADA	2.436.744.299	0	4.650.177.725	4.548.341.250	0	0	0	4.548.341.250	0,00%	0,00%	100,00%
2E90	2.278.295.616	0	4.324.541.571	4.248.952.102	0	0	0	4.248.952.102	0,00%	0,00%	100,00%
8535	154.875.403	0	325.636.154	299.389.148	0	0	0	299.389.148	0,00%	0,00%	100,00%
8758	3.573.280	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EMENDA COMISSÃO	4.672.489.731	0	2.663.500.000	2.663.500.000	0	0	0	2.663.500.000	0,00%	0,00%	100,00%
2E90	4.549.118.913	0	2.593.500.000	2.593.500.000	0	0	0	2.593.500.000	0,00%	0,00%	100,00%
8535	123.370.818	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 8 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)

(em R\$ 1)

SAPS	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	48.767.176.600	42.568.928.447	54.793.093.911	54.751.740.267	33.573.037.061	31.423.170.694	31.353.676.241	21.178.703.206	61,32%	57,39%	38,68%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	37.594.937.251	42.568.928.447	42.683.245.386	42.418.953.038	27.779.161.666	27.312.459.815	27.243.465.362	14.639.791.372	65,49%	64,39%	34,51%
00UC	9.898.991.144	10.685.000.000	10.685.000.000	10.685.000.000	6.609.359.856	6.609.359.856	6.609.359.856	4.075.640.144	61,86%	61,86%	38,14%
20QH	153.499.520	170.000.000	170.000.000	170.000.000	1.867.941	1.265.378	265.378	168.132.059	1,10%	0,74%	98,90%
20YQ	134.862.181	178.104.102	178.104.102	178.104.102	63.271.185	62.430.237	37.947.819	114.832.917	35,52%	35,05%	64,48%
217U	49.434.000	62.300.000	62.300.000	62.300.000	27.564.000	27.564.000	27.564.000	34.736.000	44,24%	44,24%	55,76%
219A	24.268.555.347	26.712.036.417	26.712.036.417	26.712.036.417	17.870.982.766	17.741.233.635	17.741.158.140	8.841.053.651	66,90%	66,42%	33,10%
21CE	309.322.167	512.000.000	514.000.000	492.000.000	217.835.506	68.258.173	31.383.656	274.164.494	44,28%	13,87%	55,72%
21DX	1.117.121.374	1.137.855.228	1.137.855.228	714.340.176	698.822.844	698.822.844	698.822.844	15.517.332	97,83%	97,83%	2,17%
2E89	0	0	116.316.939	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4324	20.454.336	31.000.000	31.000.000	31.000.000	9.135.054	7.657.983	1.095.961	21.864.946	29,47%	24,70%	70,53%
8581	1.642.697.182	3.080.632.700	3.076.632.700	3.374.172.343	2.280.322.513	2.095.867.708	2.095.867.708	1.093.849.830	67,58%	62,12%	32,42%
EMENDA INDIVIDUAL	6.779.461.772	0	6.297.081.505	6.297.081.505	5.793.875.395	4.110.710.879	4.110.210.879	503.206.110	92,01%	65,28%	7,99%
20YL	330.000	0	2.172.001	2.172.001	0	0	0	2.172.001	0,00%	0,00%	100,00%
217U	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0,00%	0,00%	100,00%
21CE	1.306.792	0	4.540.000	4.540.000	0	0	0	4.540.000	0,00%	0,00%	100,00%
2E89	6.136.412.447	0	5.658.248.303	5.658.248.303	5.399.490.490	4.040.336.717	4.039.836.717	258.757.813	95,43%	71,41%	4,57%
4324	1.499.085	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8581	639.913.448	0	631.721.201	631.721.201	394.384.905	70.374.162	70.374.162	237.336.296	62,43%	11,14%	37,57%
EMENDA BANCADA	1.280.815.521	0	2.609.433.687	2.832.372.391	0	0	0	2.832.372.391	0,00%	0,00%	100,00%
2E89	1.280.615.531	0	2.573.679.895	2.795.503.505	0	0	0	2.795.503.505	0,00%	0,00%	100,00%
8581	199.990	0	35.753.792	36.868.886	0	0	0	36.868.886	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA COMISSÃO	3.111.962.056	0	3.203.333.333	3.203.333.333	0	0	0	3.203.333.333	0,00%	0,00%	100,00%
2E89	3.033.035.642	0	3.133.333.333	3.133.333.333	0	0	0	3.133.333.333	0,00%	0,00%	100,00%
8581	78.926.414	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 9 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (SECTICS)

(em R\$ 1)

SECTICS	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	20.120.729.175	25.801.035.358	24.732.657.689	22.947.590.744	17.775.125.709	11.542.440.091	10.531.241.429	5.172.465.035	77,46%	50,30%	22,54%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	20.114.693.422	25.401.035.358	24.317.613.915	22.564.264.356	17.775.125.709	11.542.440.091	10.531.241.429	4.789.138.647	78,78%	51,15%	21,22%
20AE	2.797.480.998	3.039.445.811	3.039.445.811	3.039.445.811	2.359.736.272	1.730.352.297	1.728.136.654	679.709.539	77,64%	56,93%	22,36%
20AH	117.388.758	217.000.000	217.000.000	182.000.000	96.420.044	63.860.717	44.630.620	85.579.956	52,98%	35,09%	47,02%
20K3	21.295.594	37.000.000	37.000.000	37.000.000	32.357.824	13.094.186	6.294.186	4.642.176	87,45%	35,39%	12,55%
20K5	37.004.687	45.000.000	45.000.000	45.000.000	5.000.000	1.250.229	1.250.229	40.000.000	11,11%	2,78%	88,89%
20K7	783.647.278	1.941.000.000	857.578.557	433.398.780	9.537.329	6.781.927	587.830	423.861.451	2,20%	1,56%	97,80%
20YQ	1.828.662	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.031.000	652.986	639.087	1.469.000	41,24%	26,12%	58,76%
20YR	3.032.635.034	3.783.000.000	3.783.000.000	3.908.772.697	2.983.860.216	2.979.436.021	2.439.822.820	924.912.481	76,34%	76,22%	23,66%
20YS	602.252.052	419.242.326	419.242.326	293.469.629	66.649.471	66.645.374	66.645.374	226.820.158	22,71%	22,71%	77,29%
212H	152.454.687	45.000.000	45.000.000	54.825.938	0	0	0	54.825.938	0,00%	0,00%	100,00%
21BF	290.118.722	311.000.000	311.000.000	311.000.000	34.017.587	22.035.817	5.214.021	276.982.413	10,94%	7,09%	89,06%
21ED	223.437.148	250.000.000	250.000.000	240.174.062	5.921.272	0	0	234.252.790	2,47%	0,00%	97,53%
4368	513.960.576	589.347.221	589.347.221	589.347.221	464.124.061	297.358.134	293.286.348	125.223.160	78,75%	50,46%	21,25%
4705	11.457.622.736	14.338.000.000	14.338.000.000	13.293.830.218	11.703.676.131	6.349.038.402	5.937.311.764	1.590.154.087	88,04%	47,76%	11,96%
8636	70.258.537	370.000.000	370.000.000	120.000.000	2.960.000	2.960.000	0	117.040.000	2,47%	2,47%	97,53%
8648	13.307.953	13.500.000	13.500.000	13.500.000	9.834.502	8.974.002	7.422.497	3.665.498	72,85%	66,47%	27,15%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	400.000.000	400.000.000	368.282.614	0	0	0	368.282.614	0,00%	0,00%	100,00%
09LP	0	400.000.000	400.000.000	368.282.614	0	0	0	368.282.614	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA INDIVIDUAL	4.052.631	0	15.043.774	15.043.774	0	0	0	15.043.774	0,00%	0,00%	100,00%
20K7	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0,00%	0,00%	100,00%
21BF	4.052.631	0	14.143.774	14.143.774	0	0	0	14.143.774	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA BANCADA	1.983.121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20K7	1.983.121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 10 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)

(em R\$ 1)

SEIDIGI	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	885.762.588	1.213.010.000	1.173.878.174	1.249.314.649	297.299.702	190.149.161	163.201.722	952.014.947	23,80%	15,22%	76,20%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	882.339.830	1.213.010.000	1.160.340.179	1.235.776.654	297.299.702	190.149.161	163.201.722	938.476.952	24,06%	15,39%	75,94%
20YN	294.329.581	471.000.000	431.766.654	425.736.654	198.233.878	130.903.732	120.562.621	227.502.776	46,56%	30,75%	53,44%
20YQ	47.492.414	57.000.000	57.000.000	57.000.000	23.921.972	19.544.197	16.481.445	33.078.028	41,97%	34,29%	58,03%
212H	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
21CF	60.531.051	103.010.000	89.573.525	165.010.000	52.068.853	32.371.233	21.077.657	112.941.147	31,55%	19,62%	68,45%
21GM	464.736.308	570.000.000	570.000.000	570.000.000	11.045.000	0	0	558.955.000	1,94%	0,00%	98,06%
8753	15.250.476	10.000.000	10.000.000	16.030.000	12.030.000	7.330.000	5.080.000	4.000.000	75,05%	45,73%	24,95%
EMENDA INDIVIDUAL	3.422.758	0	13.537.995	13.537.995	0	0	0	13.537.995	0,00%	0,00%	100,00%
21CF	3.422.758	0	9.037.995	9.037.995	0	0	0	9.037.995	0,00%	0,00%	100,00%
21GM	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 11 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Saúde Indígena (SESAI)

(em R\$ 1)

SESAI	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	3.081.019.570	2.919.400.000	1.463.565.097	3.164.249.443	2.083.123.902	1.898.333.294	1.834.403.580	1.081.125.541	65,83%	59,99%	34,17%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	3.081.019.570	2.919.400.000	1.385.715.654	3.086.400.000	2.083.123.902	1.898.333.294	1.834.403.580	1.003.276.098	67,49%	61,51%	32,51%
20YP	2.965.994.405	2.788.400.000	1.271.062.881	2.313.800.000	1.538.481.498	1.400.945.692	1.341.382.589	775.318.502	66,49%	60,55%	33,51%
21CJ	115.025.165	131.000.000	114.652.773	131.000.000	95.913.116	48.658.313	44.291.703	35.086.884	73,22%	37,14%	26,78%
21DX	0	0	0	641.600.000	448.729.288	448.729.288	448.729.288	192.870.712	69,94%	69,94%	30,06%
EMENDA INDIVIDUAL	18.335.036	0	24.849.443	24.849.443	0	0	0	24.849.443	0,00%	0,00%	100,00%
20YP	13.040.536	0	21.849.443	21.849.443	0	0	0	21.849.443	0,00%	0,00%	100,00%
21CJ	5.294.500	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA BANCADA	0	0	53.000.000	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
21CJ	0	0	53.000.000	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 12 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)

(em R\$ 1)

SGTES	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	12.552.620.943	18.134.736.768	15.540.119.149	18.506.266.412	10.247.728.461	10.077.593.019	9.770.955.538	8.258.537.951	55,37%	54,46%	44,63%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	12.552.620.943	18.134.736.768	15.529.581.149	18.495.728.412	10.247.728.461	10.077.593.019	9.770.955.538	8.247.999.951	55,41%	54,49%	44,59%
00UW	10.599.953.201	10.855.000.000	10.855.000.000	10.855.000.000	6.207.261.029	6.207.261.029	6.207.261.029	4.647.738.971	57,18%	57,18%	42,82%
20YD	1.930.482.257	2.458.000.000	2.453.000.000	2.365.476.592	1.272.000.863	1.136.334.814	1.125.636.909	1.093.475.729	53,77%	48,04%	46,23%
20YQ	22.185.486	50.000.000	50.000.000	50.000.000	22.750.075	17.268.064	12.835.860	27.249.925	45,50%	34,54%	54,50%
21BG	0	4.771.736.768	2.171.581.149	4.771.736.768	2.656.395.642	2.627.408.260	2.335.900.887	2.115.341.126	55,67%	55,06%	44,33%
21DX	0	0	0	453.515.052	89.320.852	89.320.852	89.320.852	364.194.200	19,70%	19,70%	80,30%
EMENDA INDIVIDUAL	0	0	10.538.000	10.538.000	0	0	0	10.538.000	0,00%	0,00%	100,00%
20YD	0	0	10.538.000	10.538.000	0	0	0	10.538.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 13 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA)

(em R\$ 1)

SVSA	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	12.281.850.972	12.988.571.420	13.054.407.837	13.266.429.108	9.528.104.783	6.308.205.259	6.122.885.440	3.738.324.325	71,82%	47,55%	28,18%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	12.220.392.767	12.988.571.420	12.976.844.649	13.188.865.920	9.528.104.783	6.308.205.259	6.122.885.440	3.660.761.137	72,24%	47,83%	27,76%
00NJ	20.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
00NK	5.837.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
00UB	2.392.540.808	2.655.536.000	2.655.536.000	2.655.536.000	1.851.935.712	1.645.587.900	1.645.587.900	803.600.288	69,74%	61,97%	30,26%
20AL	2.250.858.320	2.216.640.000	2.216.640.000	2.216.640.000	1.369.470.065	1.256.353.907	1.245.728.907	847.169.935	61,78%	56,68%	38,22%
20QF	72.455.812	90.000.000	90.000.000	90.000.000	47.753.982	34.599.817	31.732.390	42.246.018	53,06%	38,44%	46,94%
20YE	5.963.206.761	6.270.721.020	6.270.721.020	6.551.374.321	5.108.618.359	2.662.405.406	2.580.004.311	1.442.755.962	77,98%	40,64%	22,02%
20YJ	386.898.058	367.400.000	355.673.229	329.173.229	107.716.020	73.411.809	51.363.774	221.457.209	32,72%	22,30%	67,28%
20YQ	74.555.597	130.000.000	130.000.000	130.000.000	95.237.203	74.009.098	62.335.229	34.762.797	73,26%	56,93%	26,74%
4370	1.054.040.412	1.241.274.400	1.241.274.400	1.199.142.370	947.373.442	561.837.322	506.132.929	251.768.928	79,00%	46,85%	21,00%
EMENDA INDIVIDUAL	61.458.205	0	77.563.188	77.563.188	0	0	0	77.563.188	0,00%	0,00%	100,00%
20YJ	61.458.205	0	77.563.188	77.563.188	0	0	0	77.563.188	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 14 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

(em R\$ 1)

FIOCRUZ	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	9.822.839.612	8.734.524.917	8.575.619.223	9.545.910.464	8.218.742.922	6.366.604.309	5.638.358.354	1.327.167.542	86,10%	66,69%	13,90%
PESSOAL - ATIVO	1.182.636.103	1.224.296.070	1.224.296.070	1.338.705.878	1.207.387.578	850.212.365	729.003.160	131.318.300	90,19%	63,51%	9,81%
09HB	214.678.546	217.021.948	217.021.948	241.828.302	216.550.000	150.646.086	131.448.298	25.278.302	89,55%	62,29%	10,45%
20TP	967.957.557	1.007.274.122	1.007.274.122	1.096.877.576	990.837.578	699.566.279	597.554.861	106.039.998	90,33%	63,78%	9,67%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	66.999.617	75.713.557	75.713.557	75.713.557	75.213.557	48.356.294	42.179.657	500.000	99,34%	63,87%	0,66%
2004	14.327.062	17.195.292	17.195.292	17.195.292	17.195.292	10.376.301	9.170.791	0	100,00%	60,34%	0,00%
212B	52.672.555	58.518.265	58.518.265	58.518.265	58.018.265	37.979.993	33.008.866	500.000	99,15%	64,90%	0,85%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	439.074.924	439.053.431	439.053.431	494.150.317	438.463.311	325.434.544	281.858.352	55.687.006	88,73%	65,86%	11,27%
00S6	136.282	150.336	150.336	179.553	150.336	104.092	91.080	29.217	83,73%	57,97%	16,27%
0181	438.938.642	438.903.095	438.903.095	493.970.764	438.312.975	325.330.452	281.767.272	55.657.789	88,73%	65,86%	11,27%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	7.965.234.776	6.987.507.359	6.655.754.783	7.456.481.243	6.472.847.493	5.124.712.521	4.577.304.176	983.633.750	86,81%	68,73%	13,19%
13DW	4.209.015	600.000.000	273.325.373	54.524.056	24.158.300	20.497.426	295.400	30.365.756	44,31%	37,59%	55,69%
15VW	20.219.575	10.000.000	10.000.000	68.945.317	35.010.691	4.887.143	4.501.137	33.934.626	50,78%	7,09%	49,22%
15VX	4.922.744	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
15VZ	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00%	0,00%	100,00%
166S	0	3.000.000	1.366.627	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
166T	0	5.000.000	2.277.712	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
2000	134.950.521	142.000.000	142.000.000	142.000.000	101.809.868	96.119.725	81.900.166	40.190.132	71,70%	67,69%	28,30%
20K1	14.583.172	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.976.532	12.594.990	5.968.693	4.023.468	79,88%	62,97%	20,12%
20Q7	14.809.421	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.928.745	14.727.906	13.548.520	71.255	99,55%	92,05%	0,45%
20YD	212.107.151	206.000.000	208.000.000	206.000.000	151.692.181	142.327.635	126.361.316	54.307.819	73,64%	69,09%	26,36%
20YE	2.170.751.509	2.346.628.980	2.346.628.980	2.065.975.679	1.841.290.456	1.282.212.212	1.171.486.345	224.685.223	89,12%	62,06%	10,88%
21BF	524.571.922	350.000.000	350.000.000	486.296.000	357.968.110	271.311.857	243.610.585	128.327.890	73,61%	55,79%	26,39%
21DA	330.973.017	221.000.000	218.277.712	244.560.000	76.200.610	65.504.766	57.759.638	168.359.390	31,16%	26,78%	68,84%
4368	94.227.538	96.652.779	96.652.779	96.652.779	95.834.863	63.802.362	63.203.380	817.916	99,15%	66,01%	0,85%
4370	1.619.459.568	1.459.725.600	1.459.725.600	1.501.857.630	1.451.535.981	1.317.463.590	1.292.592.372	50.321.649	96,65%	87,72%	3,35%
4705	2.287.047.921	975.000.000	975.000.000	2.019.169.782	1.974.242.918	1.528.717.460	1.242.684.852	44.926.864	97,77%	75,71%	2,23%
6174	18.919.539	20.000.000	20.000.000	20.000.000	16.622.875	16.166.234	15.396.121	3.377.125	83,11%	80,83%	16,89%
6179	39.662.158	42.000.000	42.000.000	42.000.000	20.505.588	19.669.926	16.913.524	21.494.412	48,82%	46,83%	51,18%
6516	119.145.831	120.000.000	120.000.000	130.000.000	57.742.514	39.269.719	26.751.410	72.257.486	44,42%	30,21%	55,58%
8305	323.169.490	320.000.000	320.000.000	300.000.000	228.968.873	222.187.525	210.243.313	71.031.127	76,32%	74,06%	23,68%
8327	31.504.685	33.000.000	33.000.000	33.000.000	7.358.389	7.252.046	4.087.404	25.641.611	22,30%	21,98%	77,70%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.885.135	7.954.500	7.954.500	8.012.587	8.012.585	8.012.585	8.012.585	2	100,00%	100,00%	0,00%
0005	1.885.135	7.954.500	7.954.500	8.012.587	8.012.585	8.012.585	8.012.585	2	100,00%	100,00%	0,00%
EMENDA INDIVIDUAL	167.009.058	0	172.846.882	172.846.882	16.818.397	9.876.000	424	156.028.485	9,73%	5,71%	90,27%
20YD	116.415.189	0	109.056.732	109.056.732	2.572.997	0	0	106.483.735	2,36%	0,00%	97,64%

FIOCRUZ	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
21BF	24.758.194	0	28.056.580	28.056.580	2.972.500	0	0	25.084.080	10,59%	0,00%	89,41%
21DA	852.290	0	5.900.000	5.900.000	1.200.000	26.000	424	4.700.000	20,34%	0,44%	79,66%
6174	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6179	22.471.494	0	28.133.570	28.133.570	9.850.000	9.850.000	0	18.283.570	35,01%	35,01%	64,99%
8305	1.691.919	0	1.000.000	1.000.000	222.900	0	0	777.100	22,29%	0,00%	77,71%
8327	469.972	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 15 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

(em R\$ 1)

FUNASA	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	2.149.878.092	2.785.535.841	2.786.535.842	2.919.648.260	2.346.642.068	1.654.500.209	1.525.124.300	573.006.192	80,37%	56,67%	19,63%
PESSOAL - ATIVO	89.688.314	90.164.480	90.164.480	127.947.080	123.934.480	83.157.873	76.542.576	4.012.600	96,86%	64,99%	3,14%
09HB	12.785.702	14.689.844	14.689.844	18.585.357	14.689.844	11.537.155	11.537.155	3.895.513	79,04%	62,08%	20,96%
20TP	76.902.612	75.474.636	75.474.636	109.361.723	109.244.636	71.620.718	65.005.421	117.087	99,89%	65,49%	0,11%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	38.889.446	43.442.722	43.442.722	48.656.822	41.389.141	31.917.797	28.522.590	7.267.681	85,06%	65,60%	14,94%
0536	1.062.503	1.103.521	1.103.521	1.117.621	1.117.621	748.931	653.057	0	100,00%	67,01%	0,00%
2004	28.969.352	27.379.704	27.379.704	32.579.704	26.456.936	21.416.786	19.154.250	6.122.768	81,21%	65,74%	18,79%
212B	8.857.591	14.959.497	14.959.497	14.959.497	13.814.584	9.752.079	8.715.283	1.144.913	92,35%	65,19%	7,65%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	1.545.633.969	1.574.053.064	1.574.053.064	1.653.917.413	1.644.467.736	1.074.505.548	955.944.414	9.449.677	99,43%	64,97%	0,57%
00S6	0	13.000	13.000	13.000	0	0	0	13.000	0,00%	0,00%	100,00%
0181	1.545.633.969	1.574.040.064	1.574.040.064	1.653.904.413	1.644.467.736	1.074.505.548	955.944.414	9.436.677	99,43%	64,97%	0,57%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	461.869.874	668.000.000	668.000.000	668.000.000	117.358.500	45.426.779	44.622.509	550.641.500	17,57%	6,80%	82,43%
2000	74.094.437	125.000.000	125.000.000	125.000.000	88.227.420	36.131.627	35.415.072	36.772.580	70,58%	28,91%	29,42%
20AF	86.882	9.700.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	9.700.000	0,00%	0,00%	100,00%
20AG	3.557.742	7.000.000	7.000.000	7.000.000	46.111	46.111	46.111	6.953.889	0,66%	0,66%	99,34%
20AM	9.678.919	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
20K2	400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0,00%	0,00%	100,00%
20Q8	491.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	597.000	597.000	597.000	9.903.000	5,69%	5,69%	94,31%
20T6	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
216H	47.199	300.000	300.000	300.000	300.000	25.264	21.956	0	100,00%	8,42%	0,00%
21C9	183.432.059	220.000.000	220.000.000	220.000.000	5.312.570	1.301.220	1.301.220	214.687.430	2,41%	0,59%	97,59%
21CA	33.913.402	50.000.000	50.000.000	50.000.000	5.843.853	1.865.593	1.865.593	44.156.147	11,69%	3,73%	88,31%
21CB	40.638.585	50.000.000	50.000.000	50.000.000	6.874.006	92	92	43.125.994	13,75%	0,00%	86,25%
21CC	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
21CG	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0,00%	0,00%	100,00%
21CH	38.750.799	30.000.000	30.000.000	30.000.000	960.836	0	0	29.039.164	3,20%	0,00%	96,80%
21CI	60.884.660	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.518.416	0	0	78.481.584	1,90%	0,00%	98,10%
4572	316.678	2.300.000	2.300.000	2.300.000	595.181	274.026	270.790	1.704.819	25,88%	11,91%	74,12%
4641	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
6881	15.577.513	23.000.000	23.000.000	23.000.000	5.588.107	3.690.847	3.609.674	17.411.893	24,30%	16,05%	75,70%
6908	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	10.505.000	12,46%	12,46%	87,54%
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.167.746	409.875.575	409.875.575	420.126.944	419.492.211	419.492.211	419.492.211	634.733	99,85%	99,85%	0,15%
0005	8.167.746	409.875.575	409.875.575	420.126.944	419.492.211	419.492.211	419.492.211	634.733	99,85%	99,85%	0,15%
EMENDA INDIVIDUAL	4.300.000	0	1.000.001	1.000.001	0	0	0	1.000.001	0,00%	0,00%	100,00%
20AM	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21CC	700.000	0	1	1	0	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%

FUNASA	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
21CH	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21CI	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDA COMISSÃO	1.328.743	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21CA	1.328.743	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/09/2025)

Quadro 16 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 - Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

(em R\$ 1)											
GHC	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL	2.298.389.240	2.127.857.988	2.101.835.104	2.411.540.052	1.638.828.821	1.590.121.232	1.511.561.992	772.711.231	67,96%	65,94%	32,04%
PESSOAL - ATIVO	1.580.166.143	1.558.701.584	1.558.701.584	1.794.662.107	1.193.229.036	1.160.896.607	1.108.610.963	601.433.071	66,49%	64,69%	33,51%
20TP	1.580.166.143	1.558.701.584	1.558.701.584	1.794.662.107	1.193.229.036	1.160.896.607	1.108.610.963	601.433.071	66,49%	64,69%	33,51%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	115.832.183	108.757.398	108.757.398	170.118.008	124.100.234	119.951.207	116.976.090	46.017.774	72,95%	70,51%	27,05%
0536	1.478.203	1.544.781	1.544.781	1.576.397	975.140	975.048	975.048	601.257	61,86%	61,85%	38,14%
212B	114.353.980	107.212.617	107.212.617	168.541.611	123.125.094	118.976.159	116.001.041	45.416.517	73,05%	70,59%	26,95%
PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	457.750.295	447.000.000	419.777.116	420.141.664	305.704.220	294.459.883	271.161.404	114.437.444	72,76%	70,09%	27,24%
163C	70.472	34.800.000	15.852.873	15.852.873	52.899	52.899	52.899	15.799.974	0,33%	0,33%	99,67%
163D	14.631.361	15.200.000	6.924.243	6.924.243	0	0	0	6.924.243	0,00%	0,00%	100,00%
6149	27.675.575	30.000.000	30.000.000	31.500.000	24.241.694	24.241.694	23.898.606	7.258.306	76,96%	76,96%	23,04%
6217	415.372.887	367.000.000	367.000.000	365.864.548	281.409.627	270.165.289	247.209.899	84.454.921	76,92%	73,84%	23,08%
SENTENÇAS JUDICIAIS	129.480.908	13.399.006	13.399.006	24.282.821	13.678.094	13.678.084	13.678.084	10.604.727	56,33%	56,33%	43,67%
0005	107.863.905	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0022	1.917.940	4.057.112	4.057.112	4.057.112	775.648	775.638	775.638	3.281.464	19,12%	19,12%	80,88%
0625	19.699.063	9.341.894	9.341.894	20.225.709	12.902.445	12.902.445	12.902.445	7.323.264	63,79%	63,79%	36,21%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.499.329	0	0	1.135.452	1.135.452	1.135.452	1.135.452	0	100,00%	100,00%	0,00%
6217	2.499.329	0	0	1.135.452	1.135.452	1.135.452	1.135.452	0	100,00%	100,00%	0,00%
EMENDA INDIVIDUAL	4.050.000	0	1.200.000	1.200.000	981.785	0	0	218.215	81,82%	0,00%	18,18%
6217	4.050.000	0	1.200.000	1.200.000	981.785	0	0	218.215	81,82%	0,00%	18,18%
EMENDA BANCADA	8.610.382	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6217	8.610.382	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.2. Execução Orçamentária da Despesa – Grandes grupos

Quadro 17 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado por Função

(em R\$ 1)

FUNÇÃO	ID USO	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL PROGRAMAS		231.865.128.583	241.609.625.685	246.557.970.224	247.698.130.474	163.132.864.419	138.468.259.618	134.267.710.467	84.565.266.055	65,86%	55,90%	34,14%
04	ADMINISTRAÇÃO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	49.586	49.586	49.586	2.950.414	1,65%	1,65%	98,35%
	0 NÃO ASPS	0	2.700.000	3.000.000	3.000.000	49.586	49.586	49.586	2.950.414	1,65%	1,65%	98,35%
	6 ASPS	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.414.592.174	11.509.994.330	11.509.994.330	12.437.388.054	11.454.940.803	8.090.668.649	7.152.957.743	982.447.251	92,10%	65,05%	7,90%
	0 NÃO ASPS	11.414.592.174	11.509.994.330	11.509.994.330	12.437.388.054	11.454.940.803	8.090.668.649	7.152.957.743	982.447.251	92,10%	65,05%	7,90%
	6 ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10	SAÚDE	220.271.448.398	209.920.249.360	234.345.753.097	234.516.808.281	151.158.957.088	129.861.006.892	126.598.847.942	83.357.851.193	64,46%	55,37%	35,54%
	0 NÃO ASPS	2.015.829.487	1.651.711.448	2.389.285.698	2.317.115.251	1.145.793.080	936.864.455	835.106.828	1.171.322.171	49,45%	40,43%	50,55%
	6 ASPS	218.255.618.911	208.268.537.912	231.956.467.399	232.199.693.030	150.013.164.008	128.924.142.437	125.763.741.115	82.186.529.022	64,61%	55,52%	35,39%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	179.088.011	529.143.790	529.143.790	552.875.032	518.916.942	516.534.491	515.855.196	33.958.090	93,86%	93,43%	6,14%
	0 NÃO ASPS	37.964.796	85.813.012	97.914.709	100.452.680	77.734.052	75.351.611	74.672.316	22.718.628	77,38%	75,01%	22,62%
	6 ASPS	141.123.214	443.330.778	431.229.081	452.422.352	441.182.890	441.182.879	441.182.879	11.239.462	97,52%	97,52%	2,48%
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	19.647.238.205	170.079.007	188.059.107	0	0	0	188.059.107	0,00%	0,00%	100,00%
	0 NÃO ASPS	0	38.900.005	38.900.005	38.900.005	0	0	0	38.900.005	0,00%	0,00%	100,00%
	6 ASPS	0	19.608.338.200	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 18 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado por Programa

(em R\$ 1)

PROGRAMA	ID USO		EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL PROGRAMAS			231.865.128.583	241.609.625.685	246.557.970.224	247.698.130.474	163.132.864.419	138.468.259.618	134.267.710.467	84.565.266.055	65,86%	55,90%	34,14%
0032	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO		21.834.000.272	22.691.048.324	22.591.148.324	24.062.873.195	21.119.111.934	15.203.929.882	13.588.692.689	2.943.761.261	87,77%	63,18%	12,23%
	0	NÃO ASPS	12.547.864.727	12.056.393.790,00	12.701.996.038	13.713.573.946	12.430.077.195	8.879.697.216	7.842.457.100	1.283.496.751	90,64%	64,75%	9,36%
	6	ASPS	9.286.135.545	10.634.654.534	9.889.152.286	10.349.299.249	8.689.034.739	6.324.232.666	5.746.235.588	1.660.264.510	83,96%	61,11%	16,04%
5117	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.253.120.111	27.910.688.137	27.910.688.137	27.875.688.137	23.519.169.925	15.631.145.566	14.193.043.782	4.356.518.212	84,37%	56,07%	15,63%
	0	NÃO ASPS	602.252.052	419.242.326	419.242.326	293.469.629	66.649.471	66.645.374	66.645.374	226.820.158	22,71%	22,71%	77,29%
	6	ASPS	24.650.868.059	27.491.445.811	27.491.445.811	27.582.218.508	23.452.520.454	15.564.500.193	14.126.398.409	4.129.698.054	85,03%	56,43%	14,97%
5118	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		97.518.758.992	85.378.706.952	102.929.720.222	98.574.849.033	59.694.134.933	55.195.579.768	54.939.458.826	38.880.714.100	60,56%	55,99%	39,44%
	0	NÃO ASPS	0	0	0	1.135.452	1.135.452	1.135.452	1.135.452	0	100,00%	100,00%	0,00%
	6	ASPS	97.518.758.992	85.378.706.952	102.929.720.222	98.573.713.581	59.692.999.481	55.194.444.316	54.938.323.374	38.880.714.100	60,56%	55,99%	39,44%
5119	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		51.392.467.901	45.854.705.885	55.478.715.730	58.461.032.757	35.465.470.732	33.288.060.494	32.952.541.087	22.995.562.025	60,67%	56,94%	39,33%
	0	NÃO ASPS	49.764.000	62.300.000	64.872.001	64.872.001	27.564.000	27.564.000	27.564.000	37.308.001	42,49%	42,49%	57,51%
	6	ASPS	51.342.703.901	45.792.405.885	55.413.843.729	58.396.160.756	35.437.906.732	33.260.496.494	32.924.977.087	22.958.254.024	60,69%	56,96%	39,31%
5120	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO		2.730.908.134	4.548.400.000	3.181.226.335	2.484.298.569	885.061.012	685.455.454	573.630.113	1.599.237.557	35,63%	27,59%	64,37%
	0	NÃO ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6	ASPS	2.730.908.134	4.548.400.000	3.181.226.335	2.484.298.569	885.061.012	685.455.454	573.630.113	1.599.237.557	35,63%	27,59%	64,37%
5121	GESTÃO, TRABALHO, EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA SAÚDE		15.707.181.943	16.777.758.130	16.883.610.902	17.613.949.907	9.690.984.185	9.360.567.495	9.212.229.066	7.922.965.722	55,02%	53,14%	44,98%
	0	NÃO ASPS	69.880.046	86.059.400	86.059.400	86.059.400	38.485.433	31.770.642	29.604.515	47.573.967	44,72%	36,92%	55,28%
	6	ASPS	15.637.301.898	16.691.698.730	16.797.551.502	17.527.890.507	9.652.498.751	9.328.796.853	9.182.624.551	7.875.391.756	55,07%	53,22%	44,93%
5122	SAUDE INDIGENA		3.099.354.606	2.919.400.000	1.463.565.097	2.522.649.443	1.634.394.614	1.449.604.005	1.385.674.292	888.254.829	64,79%	57,46%	35,21%
	0	NÃO ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6	ASPS	3.099.354.606	2.919.400.000	1.463.565.097	2.522.649.443	1.634.394.614	1.449.604.005	1.385.674.292	888.254.829	64,79%	57,46%	35,21%
5123	VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE		13.661.111.958	14.317.626.000	14.384.162.417	14.357.562.417	10.581.432.377	7.130.179.201	6.900.382.155	3.776.130.040	73,70%	49,66%	26,30%
	0	NÃO ASPS	69.427.304	0	89.700.000	89.600.000	22.878.079	17.628.343	17.566.052	66.721.921	25,53%	19,67%	74,47%
	6	ASPS	13.591.684.655	14.317.626.000	14.294.462.417	14.267.962.417	10.558.554.298	7.112.550.857	6.882.816.103	3.709.408.119	74,00%	49,85%	26,00%

PROGRAMA	ID USO		EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
5133	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME		153.499.520	170.000.000	170.000.000	170.000.000	1.867.941	1.265.378	265.378	168.132.059	1,10%	0,74%	98,90%
	0	NÃO ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6	ASPS	153.499.520	170.000.000	170.000.000	170.000.000	1.867.941	1.265.378	265.378	168.132.059	1,10%	0,74%	98,90%
2322	SANEAMENTO BASICO		335.311.991	464.000.000	465.000.001	465.000.001	21.686.956	5.305.016	5.305.016	443.313.045	4,66%	1,14%	95,34%
	0	NÃO ASPS	90.908.390	139.500.000	139.500.001	139.500.001	13.360.970	2.508.796	2.508.796	126.139.031	9,58%	1,80%	90,42%
	6	ASPS	244.403.602	324.500.000	325.500.000	325.500.000	8.325.985	2.796.220	2.796.220	317.174.015	2,56%	0,86%	97,44%
0901	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		141.464.500	498.154.430	498.154.430	521.387.739	510.148.272	510.148.260	510.148.260	11.239.467	97,84%	97,84%	2,16%
	0	NÃO ASPS	341.286	54.823.652	66.925.349	68.965.387	68.965.381	68.965.381	68.965.381	6	100,00%	100,00%	0,00%
	6	ASPS	141.123.214	443.330.778	431.229.081	452.422.352	441.182.890	441.182.879	441.182.879	11.239.462	97,52%	97,52%	2,48%
0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		34.434.919	425.966.360	425.966.360	394.746.907	8.745.671	6.364.777	5.685.482	386.001.236	2,22%	1,61%	97,78%
	0	NÃO ASPS	34.434.919	425.966.360	425.966.360	394.746.907	8.745.671	6.364.777	5.685.482	386.001.236	2,22%	1,61%	97,78%
	6	ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0910	OPERACOES ESPECIAIS: GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS E		3.513.735	5.933.262	5.933.262	6.033.262	655.868	654.322	654.322	5.377.394	10,87%	10,85%	89,13%
	0	NÃO ASPS	3.513.735	5.933.262	5.933.262	6.033.262	655.868	654.322	654.322	5.377.394	10,87%	10,85%	89,13%
	6	ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0	19.647.238.205	170.079.007	188.059.107	0	0	0	188.059.107	0,00%	0,00%	100,00%
	0	NÃO ASPS	0	38.900.005	38.900.005	38.900.005	0	0	0	38.900.005	0,00%	0,00%	100,00%
	6	ASPS	0	19.608.338.200	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 19 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado por Unidade Orçamentária

(em R\$ 1)

UO	ID USO		EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL MS			231.865.128.583	241.609.625.685	246.557.970.224	247.698.130.474	163.132.864.419	138.468.259.618	134.267.710.467	84.565.266.055	65,86%	55,90%	34,14%
36901	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		216.401.852.317	226.550.446.745	231.682.719.861	231.311.136.875	149.926.951.988	127.998.019.637	124.828.925.774	81.384.184.887	64,82%	55,34%	35,18%
	0	NÃO ASPS	10.156.304.960	10.425.132.753	10.427.704.754	11.045.488.970	9.549.536.795	6.819.806.988	6.040.637.897	1.495.952.175	86,46%	61,74%	13,54%
	6	ASPS	206.245.547.357	216.125.313.992	221.255.015.107	220.265.647.905	140.377.415.193	121.178.212.649	118.788.287.877	79.888.232.712	63,73%	55,01%	36,27%
36201	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ - FIOCRUZ		9.822.839.612	8.734.524.917	8.575.619.223	9.545.910.464	8.218.742.922	6.366.604.309	5.638.358.354	1.327.167.542	86,10%	66,69%	13,90%
	0	NÃO ASPS	453.401.986	456.248.723	456.248.723	511.345.609	455.658.603	335.810.845	291.029.144	55.687.006	89,11%	65,67%	10,89%
	6	ASPS	9.369.437.627	8.278.276.194	8.119.370.500	9.034.564.855	7.763.084.318	6.030.793.464	5.347.329.210	1.271.480.537	85,93%	66,75%	14,07%
36210	GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC		2.298.389.240	2.127.857.988	2.101.835.104	2.411.540.052	1.638.828.821	1.590.121.232	1.511.561.992	772.711.231	67,96%	65,94%	32,04%
	0	NÃO ASPS	1.478.203	1.544.781	1.544.781	2.711.849	2.110.592	2.110.500	2.110.500	601.257	77,83%	77,83%	22,17%
	6	ASPS	2.296.911.037	2.126.313.207	2.100.290.323	2.408.828.203	1.636.718.230	1.588.010.732	1.509.451.492	772.109.973	67,95%	65,92%	32,05%
36211	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA		2.149.878.092	2.785.535.841	2.786.535.842	2.919.648.260	2.346.642.068	1.654.500.209	1.525.124.300	573.006.192	80,37%	56,67%	19,63%
	0	NÃO ASPS	1.666.621.412	1.742.336.289	1.742.336.290	1.827.414.739	1.685.703.264	1.099.205.325	978.282.473	141.711.475	92,25%	60,15%	7,75%
	6	ASPS	483.256.680	1.043.199.552	1.044.199.552	1.092.233.521	660.938.804	555.294.884	546.841.827	431.294.717	60,51%	50,84%	39,49%
36212	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA		873.181.301	965.519.873	965.519.873	1.036.374.232	665.265.547	594.949.103	524.942.724	371.108.685	64,19%	57,41%	35,81%
	0	NÃO ASPS	871.591.876	218.115.928	965.519.873	1.036.374.232	665.265.547	594.949.103	524.942.724	371.108.685	64,19%	57,41%	35,81%
	6	ASPS	1.589.425	747.403.945	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%
36213	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS		316.276.624	442.240.321	442.240.321	470.020.591	333.742.460	262.250.879	236.992.802	136.278.131	71,01%	55,80%	28,99%
	0	NÃO ASPS	316.276.624	442.240.321	442.240.321	470.020.591	333.742.460	262.250.879	236.992.802	136.278.131	71,01%	55,80%	28,99%
	6	ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
74202	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA ANS		2.711.397	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.690.613	1.814.250	1.804.521	809.387	76,87%	51,84%	23,13%
	0	NÃO ASPS	2.711.397	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.690.613	1.814.250	1.804.521	809.387	76,87%	51,84%	23,13%
	6	ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 20 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado Despesa Pessoal

(em R\$ 1)

PESSOAL	ID USO	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL PESSOAL		20.844.381.732	21.846.904.390	21.846.904.390	23.375.340.603	20.844.592.627	15.142.806.851	13.590.407.049	2.530.747.976	89,17%	64,78%	10,83%
PESSOAL - ATIVO		8.249.479.835	8.600.299.878	8.600.299.878	9.107.875.686	7.837.022.792	5.763.572.467	5.231.354.290	1.270.852.894	86,05%	63,28%	13,95%
0	NÃO ASPS	638.640.573	203.787.836	682.038.987	755.796.826	554.596.385	476.058.177	407.234.927	201.200.441	73,38%	62,99%	26,62%
6	ASPS	7.610.839.262	8.396.512.042	7.918.260.891	8.352.078.860	7.282.426.407	5.287.514.290	4.824.119.363	1.069.652.453	87,19%	63,31%	12,81%
PESSOAL - BENEFÍCIOS		1.038.708.940	1.107.074.414	1.107.074.414	1.158.875.469	1.041.937.424	778.019.800	695.601.756	116.938.045	89,91%	67,14%	10,09%
0	NÃO ASPS	333.818.462	303.495.910	322.883.019	333.355.080	317.328.510	246.898.852	218.268.333	16.026.570	95,19%	74,06%	4,81%
6	ASPS	704.890.478	803.578.504	784.191.395	825.520.389	724.608.914	531.120.947	477.333.423	100.911.475	87,78%	64,34%	12,22%
PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA		11.414.728.456	11.510.196.666	11.510.196.666	12.438.042.607	11.455.484.139	8.091.066.325	7.153.302.743	982.558.468	92,10%	65,05%	7,90%
0	NÃO ASPS	11.414.728.456	11.510.196.666	11.510.196.666	12.438.042.607	11.455.484.139	8.091.066.325	7.153.302.743	982.558.468	92,10%	65,05%	7,90%
6	ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS		141.464.500	498.154.430	498.154.430	521.387.739	510.148.272	510.148.260	510.148.260	11.239.467	97,84%	97,84%	2,16%
0	NÃO ASPS	341.286	54.823.652	66.925.349	68.965.387	68.965.381	68.965.381	68.965.381	6	100,00%	100,00%	0,00%
6	ASPS	141.123.214	443.330.778	431.229.081	452.422.352	441.182.890	441.182.879	441.182.879	11.239.462	97,52%	97,52%	2,48%
RESERVA CONTIGÊNCIA FISCAL		0	131.179.002	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%
0	NÃO ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6	ASPS	0	131.179.002	131.179.002	149.159.102	0	0	0	149.159.102	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 21 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado Emendas ASPS E NÃO ASPS

(em R\$ 1)

RP	ID USO	EXECUTADO EM 2024	PLQA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL EMENDAS		24.792.444.344	0	26.318.305.893	26.439.408.122	10.913.993.531	6.998.072.430	6.987.696.854	15.525.414.591	41,28%	26,47%	58,72%
6	EMENDA INDIVIDUAL	13.278.510.491	0	13.138.861.148	13.138.861.148	10.913.993.531	6.998.072.430	6.987.696.854	2.224.867.617	83,07%	53,26%	16,93%
0	NÃO ASPS	1.630.000	0	2.572.002	2.572.002	0	0	0	2.572.002	0,00%	0,00%	100,00%
6	ASPS	13.276.880.491	0	13.136.289.146	13.136.289.146	10.913.993.531	6.998.072.430	6.987.696.854	2.222.295.615	83,08%	53,27%	16,92%
7	EMENDA BANCADA	3.728.153.323	0	7.312.611.412	7.433.713.641	0	0	0	7.433.713.641	0,00%	0,00%	100,00%
0	NÃO ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6	ASPS	3.728.153.323	0	7.312.611.412	7.433.713.641	0	0	0	7.433.713.641	0,00%	0,00%	100,00%
8	EMENDA COMISSÃO	7.785.780.530	0	5.866.833.333	5.866.833.333	0	0	0	5.866.833.333	0,00%	0,00%	100,00%
0	NÃO ASPS	1.328.743	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6	ASPS	7.784.451.787	0	5.866.833.333	5.866.833.333	0	0	0	5.866.833.333	0,00%	0,00%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.3. Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso

Quadro 22 – Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2025 – Resumo Consolidado por Fonte

(em R\$ 1)

FONTE RECURSO		EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL MS		231.865.128.583	241.609.625.685	246.557.970.224	247.698.130.474	163.132.864.419	138.468.259.618	134.267.710.467	84.565.266.055	65,86%	55,90%	34,14%
000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	30.436.357.866	1.726.656.242	6.824.536.909	8.134.557.477	3.185.534.740	2.741.358.432	2.351.821.185	4.949.022.737	39,16%	33,70%	60,84%
001	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	99.231.594.922	106.016.664.682	106.107.344.252	103.465.607.256	69.175.501.834	53.676.564.503	51.801.496.560	34.290.105.422	66,86%	51,88%	33,14%
002	ATIVIDADES-FIM DA SEGURIDADE SOCIAL	96.401.161.829	129.035.229.335	129.035.229.335	121.252.425.369	85.393.627.579	77.588.967.555	75.803.226.968	35.858.797.790	70,43%	63,99%	29,57%
003	RECURSOS DA UO PARA APLICAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL	1.297.367.927	1.678.121.177	1.473.053.029	1.473.053.029	811.030.191	591.782.871	527.524.186	662.022.838	55,06%	40,17%	44,94%
010	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DOS SEGURADOS VITIMADOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO	117.000	168.997	168.997	168.997	0	0	0	168.997	0,00%	0,00%	100,00%
035	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	1.142.510.936	841.051.419	841.051.419	4.791.051.419	1.718.878.566	1.577.950.217	1.573.212.879	3.072.172.853	35,88%	32,94%	64,12%
048	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL NA SEGURIDADE SOCIAL	0	23.760	23.760	23.760	0	0	0	23.760	0,00%	0,00%	100,00%
049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	351.609.399	357.690.981	322.543.431	322.543.431	12.142.835	7.888.995	7.051.522	310.400.596	3,76%	2,45%	96,24%
056	BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO	2.065.526.732	1.936.640.158	1.936.640.158	2.183.298.277	1.884.931.988	1.685.497.706	1.627.717.444	298.366.289	86,33%	77,20%	13,67%
122	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL, COM RECURSO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	6.863.834	6.406.996	6.406.996	6.406.996	0	0	0	6.406.996	0,00%	0,00%	100,00%
123	SEGURIDADE SOCIAL, COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO.	847.669.462	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
129	RECURSOS ABANDONADOS DOS PATRIMÔNIOS DO PIS PASEP	0	0	0	6.058.022.525	940.244.748	598.249.337	575.659.724	5.117.777.777	15,52%	9,88%	84,48%
184	PREVENÇÃO,CONTROLE E MITIGAÇÃO DEDANOS SOCIAIS ADVINDOS DA PRÁTICA DE JOGOS, NAS ÁREAS DE SAÚDE	0	10.971.938	10.971.938	10.971.938	10.971.938	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
444	DEMAIS APLICAÇÕES AUTORIZADAS PARA RECURSOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	84.348.676	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.4. Execução Orçamentária da Despesa dos Hospitais Próprios / Institutos no RJ

Quadro 23 - Execução Orçamentária da Despesa dos Hospitais Próprios / Institutos no RJ – Fundo Nacional de Saúde

(em R\$ 1)

AÇÃO	LOCALIZADOR	RP	HOSPITAIS PRÓPRIOS/INSTITUTOS	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
TOTAL GERAL				1.769.135.033	1.914.450.000	1.846.637.290	1.838.709.046	1.064.802.617	911.703.001	846.044.175	773.906.429	57,91%	49,58%	42,09%
HOSPITAIS PRÓPRIOS				887.197.508	924.450.000	924.450.000	924.450.000	477.023.553	422.163.759	393.349.928	447.426.447	51,60%	45,67%	48,40%
4324	0010	2	Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro - Na Região Norte	20.454.336	31.000.000	31.000.000	31.000.000	9.135.054	7.657.983	1.095.961	21.864.946	29,47%	24,70%	70,53%
6217	6506	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral dos Servidores)	218.045.298	229.450.000	229.450.000	229.450.000	141.316.479	126.638.797	121.948.844	88.133.521	61,59%	55,19%	38,41%
6217	6507	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Bonsucesso)	213.986.878	179.000.000	179.000.000	179.000.000	117.039.465	103.513.072	96.292.826	61.960.535	65,39%	57,83%	34,61%
6217	6508	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Jacarepaguá)	100.973.516	125.000.000	125.000.000	125.000.000	32.456.263	28.665.622	27.285.523	92.543.737	25,97%	22,93%	74,03%
6217	6509	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Ipanema)	113.817.392	114.000.000	114.000.000	114.000.000	70.843.039	65.815.913	64.113.796	43.156.961	62,14%	57,73%	37,86%
6217	6510	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral do Andaraí)	132.539.808	147.000.000	147.000.000	147.000.000	46.723.497	40.023.108	34.457.598	100.276.503	31,78%	27,23%	68,22%
6217	6511	2	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral da Lagoa)	87.380.281	99.000.000	99.000.000	99.000.000	59.509.755	49.849.264	48.155.381	39.490.245	60,11%	50,35%	39,89%

AÇÃO	LOCALIZADOR	RP	HOSPITAIS PRÓPRIOS/INSTITUTOS	EXECUTADO EM 2024	PLOA 2025	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	EMPENHADO (B)	LIQUIDADO (C)	PAGO (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO E = (A - B)	% EMPENHO (B / A)	% LIQUIDAÇÃO (C / A)	% SALDO (E / A)
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA				495.115.409	602.000.000	529.527.290	521.599.046	346.524.366	298.538.752	277.364.902	175.074.680	66,44%	57,24%	33,56%
125H	0033	3	Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - No Estado do Rio de Janeiro (INCA)	13.438.798	133.000.000	60.527.290	52.599.046	0	0	0	52.599.046	0,00%	0,00%	100,00%
8758	0033	2	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - No Estado do Rio de Janeiro (INCA)	481.676.611	469.000.000	469.000.000	469.000.000	346.524.366	298.538.752	277.364.902	122.475.634	73,89%	63,65%	26,11%
INSTITUTO CARDIOLOGIA - INC				115.545.610	151.000.000	151.000.000	151.000.000	93.385.562	65.334.666	60.016.646	57.614.438	61,84%	43,27%	38,16%
15EG	3341	2	Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - No Estado do Rio de Janeiro (INC)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	100,00%
8755	0033	2	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia - No Estado do Rio de Janeiro (INC)	115.545.610	150.000.000	150.000.000	150.000.000	93.385.562	65.334.666	60.016.646	56.614.438	62,26%	43,56%	37,74%
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO				245.756.090	237.000.000	237.000.000	237.000.000	147.869.135	125.665.823	115.312.699	89.130.865	62,39%	53,02%	37,61%
8759	0033	2	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - No Estado do Rio de Janeiro (INTO)	245.756.090	237.000.000	237.000.000	237.000.000	147.869.135	125.665.823	115.312.699	89.130.865	62,39%	53,02%	37,61%
EMENDAS INDIVIDUAIS				21.947.136	0	4.660.000	4.660.000	0	0	0	4.660.000	0,00%	0,00%	100,00%
8755	0033	6	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia - No Estado do Rio de Janeiro (INC)	11.013.165	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0,00%	0,00%	100,00%
8758	0033	6	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - No Estado do Rio de Janeiro (INCA)	10.734.003	0	4.160.000	4.160.000	0	0	0	4.160.000	0,00%	0,00%	100,00%
8759	0033	6	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - No Estado do Rio de Janeiro (INTO)	199.968	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0,00%	0,00%	100,00%
EMENDAS BANCADA				3.573.280	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8758	0033	7	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - No Estado do Rio de Janeiro (INCA)	3.573.280	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.5. Saldo Financeiro nas Contas Bancárias do Ministério da Saúde

Quadro 24 – Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – MS - 2º Quadrimestre de 2025

(em R\$ 1)

UG EXECUTORA		SALDO AGOSTO/2025
TOTAL GERAL		2.023.412.661
250001	GABINETE DO MINISTRO - MS	4.135
250005	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG	0
250006	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	3.307.769
250007	SECR.DE CIENCIA,TECNO.INV.COMP-ECO IND.SAUDE	91
250012	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AC	20.444
250013	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AL	11.270
250014	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AP	0
250015	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AM	155.320
250016	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/BA	119.432
250017	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/CE	63.846
250019	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/ES	13.688
250021	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/GO	306.393
250022	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MA	16.139
250023	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MT	0
250024	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MS	13.782
250025	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MG	79.631
250026	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PA	69.612
250027	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PB	22.686
250028	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PR	32.281
250029	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PE	68.592
250030	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/PI	104.895
250031	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ	444.553
250032	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN	12.961
250033	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RS	46.158
250034	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO	85.684
250035	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RR	57
250036	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC	21.232
250037	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SP	38.044
250038	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SE	117.351
250039	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/TO	81.268
250042	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	9.206
250044	SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	3.358
250052	INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	0
250057	INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	0
250058	SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	440.753
250059	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	10.364
250061	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	0
250088	SPO-COORD.-GERAL DE FINANÇAS/MS	977.139.218
250100	SECR. DE GESTAO DO TRAB. E DA EDUC. NA SAUDE	130.556
250103	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	1.304
250104	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	0
250105	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	0
250106	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	11.004
250107	CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE	15.082.081
250108	SECRETARIA EXECUTIVA DO CNS	16.312
250110	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MS	4.984.332
250113	SECRETARIA DE INFORMACAO E SAUDE DIGITAL	44.765
253002	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	3.001.398
253003	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	416.868

UG EXECUTORA		SALDO AGOSTO/2025
253007	COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-PE	8.167
253019	COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-AL	154
253021	COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-PB	0
253028	COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-SP	16.341
253032	GERENCIA-GERAL DE RESSARCIMENTO AO SUS	53.318.152
253033	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE S. - DF	0
254420	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	84.124.679
254421	INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	1.268
254422	INSTITUTO GONCALO MONIZ	0
254423	INSTITUTO RENNE RACHOU	141.741
254445	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	198.219
254446	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	13.563.587
254447	INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA	0
254448	INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE	129.252
254450	ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	74.257
254462	COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI	0
254463	INSTITUTO OSWALDO CRUZ	46.859
254474	INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE	27.617
254488	CASA DE OSWALDO CRUZ	4.600
254492	INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	56.417
254501	INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS	0
255000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	6.447.022
255001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AC	691
255002	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AL	966
255004	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AM	20
255005	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - BA	2.730
255006	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CE	1.929
255008	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - ES	367
255009	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - GO	3.632
255010	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA	480
255011	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MT	7.988
255012	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MS	242
255013	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MG	1.583
255014	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA	399
255015	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB	573
255016	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PR	289
255017	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE	81.434
255018	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PI	7.542
255019	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RJ	3.600
255021	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS	1.957
255022	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO	0
255023	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RR	12.503
255024	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SC	251
255026	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SE	22.455
255027	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - TO	14.801
257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	851.917.928
257002	SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE	11.623
257003	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	2.068
257005	CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS	55.167
257020	SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA - SESAI	43.502
257021	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA	2.849
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	4.058
257023	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE	394
257024	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO	116.144

UG EXECUTORA		SALDO AGOSTO/2025
257025	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOE	21.956
257026	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI	36.355
257027	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS	18.302
257028	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS	2.943
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	246.088
257030	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS	428.248
257031	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA	761.571
257032	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA	37.433
257033	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA	56.535
257034	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO	53.378
257035	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES	151.702
257036	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL	152.043
257037	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA	21.043
257038	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO	22.099
257039	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA	66.220
257040	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	301.050
257041	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU	199.415
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	25.678
257043	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS	1.908.982
257044	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	69.538
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	29.308
257046	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA	9.916
257047	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO	362.748
257048	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL	162.570
257049	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO	331.485
257050	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA	25.901
257051	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR	61.929
257052	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI	561.497
257053	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL	4.869
257054	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS	12.732
366003	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	241.794

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.6. Execução de Restos a Pagar

Quadro 25 – Execução Restos a Pagar até o 2º Quadrimestre de 2025 - Consolidado por Secretaria/Unidade
(em R\$ 1)

UNIDADE		INSCRITOS E REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
TOTAL		36.376.971.232	312.791.795	21.518.976.542	14.545.202.895
SE	SECRETARIA EXECUTIVA	1.434.762.341	16.396.461	1.345.728.584	72.637.296
SAES	SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14.619.639.532	130.868.529	7.840.393.027	6.648.377.976
SAPS	SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.015.900.316	5.810.960	2.950.742.272	2.059.347.085
SECTICS	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPLEXO DA SAÚDE	6.323.442.553	7.441.413	4.258.874.720	2.057.126.420
SEIDIGI	SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL	225.951.927	3.464.452	115.287.245	107.200.230
SESAI	SECRETARIA ESPECIAL DA SAÚDE INDÍGENA	400.992.617	15.418.175	250.393.228	135.181.214
SGTES	SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE	850.521.658	1.719.242	733.649.172	115.153.243
SVSA	SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE	2.089.443.055	6.779.505	1.850.920.119	231.743.432
FIOCRUZ	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.225.373.719	11.269.839	1.722.933.160	491.170.719
FUNASA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.051.264.517	109.889.786	342.445.541	2.598.929.191
GHC	GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO	139.678.998	3.733.433	107.609.474	28.336.090

*Observação: Não inclui Anvisa e ANS.
Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 26 – Execução Restos a Pagar até o 2º Quadrimestre de 2025 - Consolidado por Unidade e Ação

(em R\$ 1)

UGE	AÇÃO	INSCRITOS E REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
TOTAL GERAL		36.376.971.232	312.791.795	21.518.976.542	14.545.202.895
36901	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	30.960.653.999	187.898.737	19.345.988.366	11.426.766.896
	PESSOAL - ATIVO	354.250.206	25.845	352.456.570	1.767.791
	09HB	150.637	11.483	63.701	75.453
	20TP	354.099.569	14.361	352.392.869	1.692.338
	PESSOAL - BENEFICIOS	71.605.525	476.088	71.129.437	0
	0536	535.216	0	535.216	0
	2004	23.398.947	6.183	23.392.764	0
	212B	47.324.639	469.906	46.854.734	0
	216H	346.723	0	346.723	0
	PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	699.128.709	290.596	698.838.112	0
	0056	0	0	0	0
	0181	699.128.709	290.596	698.838.112	0
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	0	0
	0005	0	0	0	0
	PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	29.835.669.559	187.106.207	18.223.564.247	11.424.999.105
	2000	130.473.212	5.178.518	101.172.795	24.121.898
	2016	3.535.660	0	2.438.895	1.096.765
	4295	414.047.407	0	389.481.155	24.566.252
	4324	38.035.138	3.693.789	19.645.350	14.695.999
	4368	289.909.514	151.324	263.621.591	26.136.599
	4370	283.229.139	830.128	262.991.246	19.407.765
	4525	36.199.138	0	0	36.199.138
	4572	2.461.852	104.760	1.575.169	781.923
	4641	107.126.559	4.672.897	79.896.543	22.557.119
	4705	3.297.196.620	1.582.392	3.003.927.811	291.686.417
	5516	8.832.448	7.896.447	0	936.001
	6146	4.213.673	928	0	4.212.745
	6182	16.301.000	0	9.161.038	7.139.962
	6217	181.699.006	8.244.355	142.466.669	30.987.982
	6233	187.549	0	0	187.549
	6516	14.540.111	243.900	19.175	14.277.036
	7666	34.786	0	0	34.786
	7690	23.734.716	2.284.090	3.791.249	17.659.377
	8287	7.276.524	374.104	6.241.879	660.541
	8535	8.094.212.552	84.768.978	2.204.533.434	5.804.910.141
	8573	209.208	0	0	209.208
	8577	12.171.604	0	0	12.171.604
	8581	2.551.594.472	1.192.627	1.065.412.579	1.484.989.266
	8585	4.455.197.482	26.312.388	3.984.390.170	444.494.925
	8636	57.329.486	830.795	12.927.137	43.571.553
	8648	2.690.860	2.228	2.406.919	281.713
	8708	6.938.345	1.867.926	2.150.830	2.919.589
	8715	7.390.781	28.091	4.332.386	3.030.304
	8721	3.000.016	0	2.635.274	364.742
	8730	1.624.647	0	0	1.624.647
	8753	5.100.000	0	5.100.000	0
	8755	28.187.344	550.676	26.973.083	663.586
	8758	102.692.647	3.781.302	72.467.544	26.443.800
	8759	33.149.761	1.026.170	31.816.940	306.651
	8933	155.451.548	2.163.166	48.018.203	105.270.179
	2E79	942.764	0	0	942.764
	2E84	1.889.450	0	0	1.889.450
	2E87	250.000	0	0	250.000
	2E89	624.493.237	0	621.064.517	3.428.720
	2E90	1.033.015.085	0	913.359.900	119.655.185
	00UW	750.148.045	93.598	670.656.411	79.398.036
	0220	2.516	0	2.516	0

UGE	AÇÃO	INSCRITOS E REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	125H	1.514.409	0	954.786	559.623
	12L4	4.210.000	640.000	0	3.570.000
	12L5	53.744.835	0	2.805.400	50.939.435
	15W2	22.899.678	0	0	22.899.678
	15WP	8.168.850	2.910.902	610.442	4.647.506
	163M	3.091.951	0	2.817.557	274.395
	20AB	30.000	0	0	30.000
	20AD	7.625.356	0	0	7.625.356
	20AE	347.108.239	4.928	272.045.234	75.058.076
	20AH	17.010.282	250.247	16.140.778	619.257
	20AI	3.609.870	0	0	3.609.870
	20AL	44.305.805	0	40.796.922	3.508.883
	20B0	7.605.758	40.538	783.600	6.781.620
	20G8	4.871.937	745.411	0	4.126.526
	20K3	19.259.167	10.550	10.493.333	8.755.285
	20K5	31.694.687	0	0	31.694.687
	20K7	1.182.902.888	903.378	80.475.080	1.101.524.430
	20QF	21.849.957	2.395.288	13.619.413	5.835.257
	20QG	6.916.050	334.454	4.012.031	2.569.566
	20QH	146.619.399	1.100	60.508.979	86.109.320
	20QI	3.513.587	328.825	3.084.762	100.000
	20R4	15.952.608	0	260.922	15.691.686
	20SP	8.817.853	2.593	1.922.986	6.892.274
	20YD	91.912.364	1.625.644	54.627.510	35.659.210
	20YE	1.461.354.829	2.475.005	1.355.055.743	103.824.080
	20YI	9.178.802	0	62.573	9.116.230
	20YJ	230.119.164	1.026.353	151.251.401	77.841.409
	20YL	46.888.000	0	1.599.000	45.289.000
	20YM	1.093.286	0	0	1.093.286
	20YN	183.957.484	3.361.385	89.227.235	91.368.864
	20YP	309.440.848	6.756.466	206.754.447	95.929.935
	20YQ	61.242.172	356.061	51.159.841	9.726.270
	20YR	310.469.070	2.719.130	277.852.588	29.897.352
	20YS	75.622.229	170.856	47.111.462	28.339.910
	212H	152.454.687	0	122.454.687	30.000.000
	214U	999	0	0	999
	217U	4.504.695	0	4.380.000	124.695
	219A	808.758.014	11.172	724.949.093	83.797.749
	21BF	306.430.603	639.300	69.362.265	236.429.037
	21BG	384.205.388	6.000	367.272.168	16.927.220
	21C0	67.992	10.610	39.744	17.639
	21CD	38.903.771	193.150	5.185.999	33.524.622
	21CE	180.493.345	28.849	67.914.746	112.549.749
	21CF	31.331.858	0	15.659.517	15.672.341
	21CJ	83.655.321	765.262	43.638.781	39.251.278
	21D9	53.424.286	271.500	6.486.850	46.665.936
	21DZ	28.410.853	4	13.182.240	15.228.610
	21EC	992.285	88.474	876.918	26.892
	21ED	229.017.025	124.000	79.973.666	148.919.360
	21GM	263.681	0	125.300	138.381
	2B52	1.383.032	33.195	1.349.837	0
	2F01	54.406	0	0	54.406
36201	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ	2.225.373.719	11.269.839	1.722.933.160	491.170.719
	PESSOAL - ATIVO	117.849.115	264.530	117.584.585	0
	09HB	0	0	0	0
	20TP	117.849.115	264.530	117.584.585	0
	PESSOAL - BENEFICIOS	6.487.350	603.746	5.883.604	0
	0536	0	0	0	0
	2004	1.344.550	48.676	1.295.874	0
	212B	5.142.800	555.070	4.587.730	0
	PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	36.528.476	6.447	36.522.029	0
	00S6	18.945	6.447	12.497	0

UGE	AÇÃO	INSCRITOS E REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	0181	36.509.532	0	36.509.532	0
	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.366	0	0	162.366
	0005	162.366	0	0	162.366
	PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	2.064.346.411	10.395.116	1.562.942.942	491.008.353
	2000	11.804.028	1.309.789	9.134.572	1.359.667
	2522	290.746	0	0	290.746
	4368	25.192.034	3.185	25.076.436	112.413
	4370	24.786.670	32.732	23.691.599	1.062.338
	4705	669.341.072	1.529.114	648.654.152	19.157.806
	6174	1.686.063	185.491	1.178.585	321.987
	6179	15.889.795	2.540	11.620.064	4.267.191
	6516	41.012.215	413.183	32.808.174	7.790.858
	7674	95.011	17.558	54.538	22.916
	8305	30.304.320	169.150	25.874.676	4.260.493
	8315	7.028	6.628	0	400
	8327	3.938.411	104.422	3.531.120	302.870
	13DU	841.622	0	0	841.622
	13DW	54.139.690	0	7.025.178	47.114.512
	14UO	27.000	0	0	27.000
	15VW	21.921.477	0	4.509.075	17.412.402
	15VX	3.106.066	0	783.559	2.322.506
	15VY	236.165	0	236.165	0
	20K1	994.734	43.518	788.483	162.733
	20Q7	829.460	32.919	493.320	303.221
	20YD	126.853.740	425.667	77.850.309	48.577.764
	20YE	484.909.953	2.996.277	430.355.339	51.558.337
	21BF	301.547.364	1.815.535	125.160.831	174.570.998
	21DA	244.363.665	1.307.120	134.107.297	108.949.248
	21DZ	122.083	287	4.471	117.325
	2B42	100.000	0	0	100.000
	2F01	5.999	0	4.999	1.000
36210	GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO	139.678.998	3.733.433	107.609.474	28.336.090
	PESSOAL - ATIVO	64.812.947	2.742.532	62.070.414	0
	09HB	0	0	0	0
	20TP	64.812.947	2.742.532	62.070.414	0
	PESSOAL - BENEFICIOS	2.493.827	164.349	2.329.478	0
	0536	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0
	212B	2.493.827	164.349	2.329.478	0
	PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	0	0	0	0
	00S6	0	0	0	0
	0181	0	0	0	0
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	0	0
	0005	0	0	0	0
	PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	72.372.224	826.552	43.209.582	28.336.090
	15W3	63.215	0	63.215	0
	163D	14.631.361	0	1.743.462	12.887.899
	6149	325.874	0	325.874	0
	6217	57.351.775	826.552	41.077.032	15.448.191
36211	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.051.264.517	109.889.786	342.445.541	2.598.929.191
	PESSOAL - ATIVO	10.736.349	0	10.736.349	0
	09HB	0	0	0	0
	20TP	10.736.349	0	10.736.349	0
	PESSOAL - BENEFICIOS	12.249.995	0	3.598.025	8.651.970
	0536	88.085	0	88.085	0
	2004	11.146.726	0	2.498.456	8.648.270
	212B	1.012.590	0	1.008.890	3.700
	216H	2.593	0	2.593	0
	PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA	116.428.467	0	116.428.460	7
	00S6	0	0	0	0

UGE	AÇÃO	INSCRITOS E REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	0181	116.428.467	0	116.428.460	7
	SENTENÇAS JUDICIAIS	179.256	179.256	0	0
	0005	179.256	179.256	0	0
	PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA	2.911.670.450	109.710.530	211.682.707	2.590.277.213
	2000	29.413.066	5.821.297	8.059.057	15.532.712
	3883	26.275.027	1.622.475	570.850	24.081.702
	3921	35.063.772	1.401.551	3.350.739	30.311.482
	4572	199.849	0	39.664	160.185
	5528	602.700	602.700	0	0
	6881	19.622.848	686.486	4.280.718	14.655.644
	6908	51.627.853	2.785.902	1.061.266	47.780.685
	7652	106.408.309	10.231.182	8.915.507	87.261.620
	7654	394.959	0	394.250	709
	7656	270.035.735	14.008.566	17.075.780	238.951.389
	002M	630.000	0	0	630.000
	10GD	239.423.152	12.757.306	15.142.764	211.523.082
	10GE	390.090.190	25.339.262	21.298.958	343.451.969
	10GG	54.730.088	1.335.095	0	53.394.993
	10SK	3.337.583	0	0	3.337.583
	10TA	365.252	0	0	365.252
	20AF	2.471.917	73.895	951.527	1.446.495
	20AG	30.576.039	1.763.852	3.700.715	25.111.472
	20AM	9.989.176	100.836	3.370.113	6.518.227
	20K2	1.790.512	0	269.428	1.521.084
	20Q8	49.077.821	452.821	0	48.625.000
	20T6	23.550.084	2.451.102	986.973	20.112.008
	21C9	668.564.738	9.360.544	24.790.340	634.413.854
	21CA	205.968.029	515.761	31.017.989	174.434.279
	21CB	275.711.319	8.127.307	18.679.485	248.904.526
	21CC	19.427.636	759.328	8.760.186	9.908.122
	21CG	17.283.373	0	0	17.283.373
	21CH	107.843.934	1.410.501	9.337.814	97.095.619
	21CI	178.028.549	6.076.953	28.027.977	143.923.618
	7X28	2.841.482	0	0	2.841.482
	7XK6	42.093.609	950.000	500.607	40.643.002
	7XK7	23.836.081	675.807	800.000	22.360.274
	7XK8	24.395.769	400.000	300.000	23.695.769

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

2.7. Acompanhamento Mensal da Receita Própria e Vinculada em 2025

Quadro 27 – Acompanhamento da Receita Própria e Vinculada até o 2º Quadrimestre de 2025 - Consolidado por Fonte de Recurso

(em R\$ 1)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE RECURSOS REDUZIDA		EXECUTADO EM 2024	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA	RECEITA REALIZADAS - DESPESAS EXECUTADAS ATÉ ABRIL/2025	RECEITA ESTIMADA	EXCESSO OU FRUSTACÃO
TOTAL GERAL			4.984.876.023	2.894.435.268	2.894.435.268	3.825.398.608	4.915.211.093	-2.020.775.825
36901	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		3.900.791.030	1.761.338.152	1.761.338.152	2.837.450.402	3.484.079.932	1.722.741.780
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	0	25.903.766	25.903.766	0	0	0
	003	RECURSOS DA UO PARA APLICAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL	769.693.636	580.856.727	580.856.727	511.950.599	763.732.364	182.875.637
	010	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DOS SEGURADOS VITIMADOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO	381.995	168.997	168.997	108.987	165.321	-3.676
	035	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	2.795.237.688	841.051.419	841.051.419	2.059.922.976	2.334.247.437	1.493.196.018
	048	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL NA SEGURIDADE SOCIAL	0	0	0	0	0	0
	049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	329.381.700	295.978.309	295.978.309	231.608.781	334.915.750	38.937.441
	096	DOAÇÕES NACIONAIS	440.613	0	0	1.182.242	1.182.242	1.182.242
	122	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL, COM RECURSO DE SUPERHAVIT FINANCEIRO	5.655.208	6.406.996	6.406.996	1.393.431	1.993.431	-4.413.565
	177	APLICAÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 568	0	0	0	0	0	0
	184	PREVENÇÃO, CONTROLE E MITIGAÇÃO DE DANOS SOCIAIS ADVINDOS DA PRÁTICA DE JOGOS, NAS ÁREAS DE SAÚDE	190	10.971.938	10.971.938	31.283.386	47.843.387	36.871.449
36201	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		25.948.882	3.906.604	3.906.604	36.039.330	38.879.732	34.973.128
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	0	781.176	781.176	0	0	0
	048	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0
	049	RECURSOS PRÓPRIOS	25.948.833	3.125.428	3.125.428	36.039.330	38.879.732	35.754.304
	052	RECURSOS LIVRES DA UO	49	0	0	0		0
36210	GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO		65.866.840	22.588.479	22.588.479	13.439.005	20.393.808	-2.194.671
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	0	5.670.460	5.670.460	0	0	0
	048	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL NA SEGURIDADE SOCIAL	263.700	0	0	0	0	0
	049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	65.603.140	16.918.019	16.918.019	13.439.005	20.393.808	3.475.789
36211	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE		6.554.773	4.695.713	4.695.713	4.203.290	7.408.889	2.713.176
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	0	1.399.587	1.399.587	0	0	0
	048	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL NA SEGURIDADE SOCIAL	0	23.760	23.760	13.620	15.000	-8.760
	049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	6.554.773	3.272.366	3.272.366	4.189.670	7.393.889	4.121.523
36212	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA		556.322.786	656.165.999	656.165.999	417.719.145	610.519.145	-45.646.854
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	0	196.849.800	196.849.800	0	0	0
	003	RECURSOS DA UO PARA APLICAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL	550.890.200	456.488.302	456.488.302	416.141.447	608.132.342	151.644.040
	049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	5.432.587	2.827.897	2.827.897	1.577.699	2.386.803	-441.094
36213	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS		429.391.713	445.740.321	445.740.321	516.547.436	753.929.587	308.189.266
	000	RECURSOS LIVRES DA UNIÃO	0	9.610.909	9.610.909	0	0	0
	003	RECURSOS DA UO PARA APLICAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL	428.702.891	435.708.000	435.708.000	515.258.581	752.379.735	316.671.735
	049	RECURSOS PRÓPRIOS DA UO PARA APLICAÇÃO EM SEGURIDADE SOCIAL	688.822	421.412	421.412	1.288.855	1.549.852	1.128.440

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

3. Desembolso Financeiro no 2º Quadrimestre de 2025

3.1 Transferências Fundo a Fundo por Bloco, Programa, Região e UF – Pagamentos Totais Efetuados (inclusive RAP)

Quadro 28 – Transferências Fundo a Fundo (Valores Brutos) até o 2º Quadrimestre de 2025 - Manutenção - Consolidado por Região e UF

(em milhares)

BLOCO	REGIÃO	UF	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			GESTÃO DO SUS			VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			TOTAL
			MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	
TOTAL			18.853.591	35.937.559	54.791.150	272.709	29.533.259	29.805.968	1.320.667	1.022.281	2.342.948	1.852.967	5.023.450	6.876.416	380.968	2.583.724	2.964.692	55	3.432	3.487	3.762	54.864	58.627	96.843.288
BLOCO DE MANUTENÇÃO	CENTRO - OESTE	DF	556.285	0	556.285	209.917	0	209.917	36.049	0	36.049	3.011	0	3.011	27.876	0	27.876	0	0	0	174	0	174	833.311
		GO	348.471	1.526.940	1.875.412	716	938.690	939.406	52.070	39.997	92.067	46.759	104.789	151.549	9.783	113.585	123.368	0	226	226	150	452	601	3.182.630
		MS	210.062	542.652	752.714	0	437.666	437.666	6.509	15.814	22.323	12.743	87.858	100.600	6.627	46.038	52.665	55	0	55	127	344	470	1.366.494
		MT	282.802	574.614	857.416	296	494.222	494.517	11.863	20.850	32.713	15.485	81.729	97.214	9.535	54.672	64.208	0	0	0	127	315	441	1.546.509
	NORDESTE	AL	430.144	847.707	1.277.851	1.448	711.767	713.215	3.568	18.389	21.957	16.088	135.272	151.360	7.980	46.977	54.957	0	0	0	127	2.754	2.881	2.222.221
		BA	1.553.286	2.009.465	3.562.751	480	2.709.837	2.710.317	36.638	81.942	118.581	236.177	466.042	702.219	27.378	208.407	235.785	0	1.199	1.199	173	9.029	9.201	7.340.052
		CE	710.365	2.009.421	2.719.786	21.551	1.649.916	1.671.467	71.475	15.528	87.004	41.604	346.025	387.628	15.468	128.317	143.785	0	0	0	150	3.976	4.125	5.013.796
		MA	562.460	932.980	1.495.440	1.934	1.639.289	1.641.223	9.542	38.942	48.484	133.032	385.034	518.065	16.818	98.931	115.749	0	0	0	150	5.780	5.930	3.824.891
		PB	295.511	713.914	1.009.425	1.923	991.636	993.559	22.819	23.663	46.482	45.996	237.846	283.842	9.037	56.842	65.879	0	0	0	127	4.312	4.438	2.403.625
		PE	1.478.398	1.096.662	2.575.060	13.977	1.605.394	1.619.372	33.893	52.355	86.248	318.654	275.476	594.130	20.218	121.573	141.791	0	0	0	173	4.417	4.590	5.021.191
		PI	291.517	676.411	967.928	0	1.032.894	1.032.894	4.546	19.367	23.913	25.192	132.739	157.931	6.610	46.653	53.263	0	0	0	127	4.948	5.075	2.241.005
		RN	512.803	579.756	1.092.559	0	677.296	677.296	3.337	19.506	22.843	42.921	148.790	191.711	6.428	52.868	59.296	0	0	0	127	2.776	2.903	2.046.607
		SE	376.784	248.610	625.394	3.065	515.789	518.854	12.079	12.954	25.032	41.900	41.509	83.409	5.827	28.405	34.232	0	0	0	104	1.401	1.504	1.288.425
	NORTE	AC	275.545	8.170	283.715	645	253.620	254.266	1.712	4.812	6.523	20.897	9.383	30.280	3.060	17.077	20.137	0	0	0	104	556	660	595.581
		AM	473.846	417.768	891.614	386	878.224	878.610	4.193	22.548	26.741	84.269	104.085	188.354	11.797	72.977	84.774	0	0	0	127	1.673	1.799	2.071.891
		AP	256.624	82.857	339.481	927	231.177	232.105	1.804	4.140	5.944	4.522	37.470	41.992	2.985	15.432	18.417	0	0	0	104	388	491	638.431
		PA	688.798	1.048.656	1.737.454	1.632	1.487.284	1.488.916	11.143	47.329	58.472	104.290	313.590	417.879	19.899	131.520	151.419	0	0	0	150	3.813	3.962	3.858.102
		RO	248.481	267.959	516.440	502	221.503	222.005	4.276	9.162	13.438	11.280	50.698	61.977	4.890	21.792	26.682	0	0	0	104	284	387	840.930
		RR	168.747	136.079	304.825	640	192.288	192.928	253	3.595	3.848	0	8.373	8.373	2.996	13.591	16.588	0	0	0	104	319	423	526.985
		TO	337.445	264.404	601.849	0	452.970	452.970	705	9.187	9.891	39.122	56.059	95.181	5.348	27.596	32.944	0	0	0	104	1.691	1.795	1.194.631
	SUDESTE	ES	684.042	387.456	1.071.498	4.265	532.942	537.207	25.092	21.461	46.553	80.165	68.615	148.780	8.273	46.665	54.939	0	0	0	127	34	160	1.859.136
		MG	138.078	5.897.923	6.036.000	0	3.150.632	3.150.632	78.642	118.594	197.236	46.466	946.486	992.952	33.186	354.417	387.603	0	0	0	173	4.518	4.690	10.769.114
		RJ	542.107	4.515.723	5.057.829	0	1.566.707	1.566.707	42.230	90.075	132.305	40.222	373.666	413.887	31.665	218.350	250.015	0	2.007	2.007	173	73	246	7.422.997
		SP	4.269.434	6.121.221	10.390.655	4.095	3.445.338	3.449.432	495.521	216.533	712.054	118.141	292.337	410.478	50.763	386.885	437.648	0	0	0	173	186	358	15.400.625
	SUL	PR	1.218.316	1.915.366	3.133.682	4.300	1.449.977	1.454.277	205.214	10.536	215.750	148.515	123.487	272.002	14.088	129.582	143.670	0	0	0	173	399	572	5.219.953
		RS	1.042.671	2.053.218	3.095.890	11	1.259.955	1.259.966	84.430	61.988	146.417	98.990	142.140	241.130	13.162	88.263	101.426	0	0	0	173	305	477	4.845.306
		SC	900.568	1.061.627	1.962.195	0	1.006.243	1.006.243	61.065	43.016	104.081	76.527	53.952	130.480	9.270	56.305	65.576	0	0	0	150	123	273	3.268.847

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

Quadro 29 – Transferências Fundo a Fundo (Valores Brutos) até o 2º Quadrimestre de 2025 - Estruturação - Consolidado por Região e UF

(em milhares)

BLOCO	REGIÃO	UF	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			GESTÃO DO SUS			VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE			FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE			SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			TOTAL		
			MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL			
TOTAL			159.134	714.609	873.743	0	3.160.795	3.160.795	0	15.441	15.441	0	0	0	7.217	18.611	25.828	20.051	14.325	34.376	0	0	0	4.110.184		
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	CENTRO - OESTE	DF	33.884	0	33.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.884		
		GO	3.453	29.307	32.760	0	173.657	173.657	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	551	551	0	0	0	207.344		
		MS	2.894	12.486	15.380	0	83.592	83.592	0	247	247	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	99.530		
		MT	3.999	20.692	24.691	0	88.716	88.716	0	378	378	0	0	0	0	0	0	0	132	132	0	0	0	113.917		
	NORDESTE	AL	0	14.253	14.253	0	52.898	52.898	0	380	380	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	67.781	
		BA	9.309	39.345	48.654	0	270.688	270.688	0	1.987	1.987	0	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430	0	0	0	0	323.758	
		CE	2.124	40.079	42.203	0	95.538	95.538	0	534	534	0	0	0	0	0	0	0	1.587	1.587	0	0	0	0	139.862	
		MA	1.379	32.910	34.288	0	143.449	143.449	0	1.321	1.321	0	0	0	0	0	0	0	763	763	0	0	0	0	179.821	
		PB	25.011	17.705	42.716	0	60.913	60.913	0	605	605	0	0	0	0	0	0	0	1.662	1.662	0	0	0	0	105.896	
		PE	7.926	28.942	36.869	0	164.130	164.130	0	1.082	1.082	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	202.162	
		PI	29.381	13.762	43.142	0	38.122	38.122	0	638	638	0	0	0	0	0	0	0	933	933	0	0	0	0	82.835	
		RN	3.407	10.059	13.465	0	77.205	77.205	0	334	334	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	91.130	
		SE	600	16.640	17.240	0	41.801	41.801	0	414	414	0	0	0	0	0	0	0	16.402	82	16.484	0	0	0	0	75.939
		NORTE	AC	0	6.121	6.121	0	4.182	4.182	0	142	142	0	0	0	0	0	0	3.337	0	3.337	0	0	0	0	13.782
	AM		324	28.617	28.941	0	50.744	50.744	0	385	385	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	80.499	
	AP		8.721	4.370	13.091	0	8.720	8.720	0	46	46	0	0	0	0	0	1.999	1.999	0	0	0	0	0	0	23.855	
	PA		0	63.174	63.174	0	134.876	134.876	0	1.056	1.056	0	0	0	0	0	0	0	485	485	0	0	0	0	199.590	
	RO		0	37.522	37.522	0	30.473	30.473	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	68.449	
	RR		5.413	8.665	14.077	0	11.850	11.850	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.008
	SUDESTE	TO	0	3.635	3.635	0	43.231	43.231	0	637	637	0	0	0	0	0	0	0	184	184	0	0	0	0	47.687	
		ES	5.684	5.854	11.538	0	41.287	41.287	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	53.023	
		MG	0	41.445	41.445	0	383.283	383.283	0	3.845	3.845	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	429.443	
		RJ	888	51.419	52.307	0	71.081	71.081	0	116	116	0	0	0	0	0	0	0	3.257	3.257	0	0	0	0	126.760	
	SUL	SP	4.956	77.414	82.370	0	488.058	488.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	0	0	0	0	570.770	
		PR	7.861	24.928	32.789	0	107.143	107.143	0	164	164	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0	0	0	140.178	
		RS	0	57.571	57.571	0	287.246	287.246	0	144	144	0	0	0	6.967	16.612	23.579	0	210	210	0	0	0	0	368.750	
		SC	1.921	27.696	29.617	0	207.913	207.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.530	

Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

3.2. Transferências a Estados, Municípios e Distrito Federal – Modalidade de Aplicação

Quadro 30 – Transferências a Estados, DF e Municípios até o 2º Quadrimestre de 2025 - Consolidado por Modalidade de Aplicação, Região e UF

(em milhares)

REGIÃO	NDD	UF	EMPENHADO					LIQUIDADO					PAGO				
			30	31	40	41	TOTAL	30	31	40	41	TOTAL	30	31	40	41	TOTAL
TOTAL GERAL			4.525	21.952.954	23.463	76.873.179	98.854.121	4.108	20.857.193	4.163	71.904.036	92.769.498	4.108	20.857.193	4.163	71.903.532	92.768.995
CENTRO - OESTE	11	DF	0	808.913	0	0	808.913	0	746.806	0	0	746.806	0	746.806	0	0	746.806
	15	GO	0	452.776	0	2.871.571	3.324.347	0	436.959	0	2.664.245	3.101.204	0	436.959	0	2.664.245	3.101.204
	21	MS	0	216.305	2	1.197.798	1.414.104	0	207.710	2	1.116.996	1.324.708	0	207.710	2	1.116.996	1.324.708
	19	MT	0	261.669	996	1.373.617	1.636.282	0	223.567	0	1.258.366	1.481.933	0	223.567	0	1.258.366	1.481.933
NORDESTE	3	AL	0	379.660	0	1.753.957	2.133.617	0	377.780	0	1.698.429	2.076.209	0	377.780	0	1.698.429	2.076.209
	7	BA	0	1.792.588	0	5.748.068	7.540.656	0	1.676.077	0	5.379.771	7.055.849	0	1.676.077	0	5.379.771	7.055.849
	9	CE	0	839.296	840	4.194.267	5.034.403	0	789.547	840	3.891.167	4.681.554	0	789.547	840	3.891.164	4.681.551
	17	MA	0	673.311	4.492	3.148.349	3.826.152	0	655.159	2.432	3.029.015	3.686.606	0	655.159	2.432	3.029.015	3.686.606
	27	PB	0	301.813	0	2.067.689	2.369.502	0	292.374	0	1.965.281	2.257.655	0	292.374	0	1.965.281	2.257.655
	31	PE	0	1.799.137	5.439	3.276.069	5.080.645	0	1.728.043	148	3.097.030	4.825.221	0	1.728.043	148	3.097.030	4.825.221
	33	PI	3.988	276.179	0	1.847.218	2.127.386	3.988	271.900	0	1.778.847	2.054.735	3.988	271.900	0	1.778.847	2.054.735
	37	RN	0	562.959	0	1.539.657	2.102.616	0	548.277	0	1.452.889	2.001.166	0	548.277	0	1.452.889	2.001.166
	47	SE	0	420.316	0	883.232	1.303.548	0	410.769	0	806.911	1.217.680	0	410.769	0	806.911	1.217.680
	NORTE	1	AC	408	281.076	0	341.426	622.910	119	274.252	0	284.622	558.994	119	274.252	0	284.122
5		AM	0	556.840	0	1.458.223	2.015.063	0	546.641	0	1.383.835	1.930.475	0	546.641	0	1.383.835	1.930.475
4		AP	0	249.581	0	380.606	630.186	0	227.482	0	346.838	574.320	0	227.482	0	346.838	574.320
25		PA	0	830.292	2.359	3.144.377	3.977.029	0	801.295	0	2.991.535	3.792.830	0	801.295	0	2.991.535	3.792.830
41		RO	0	269.100	6.555	650.485	926.140	0	261.507	96	520.909	782.512	0	261.507	96	520.909	782.512
42		RR	0	173.207	0	373.292	546.499	0	165.424	0	304.095	469.519	0	165.424	0	304.095	469.519
48		TO	0	332.778	0	774.870	1.107.648	0	327.510	0	709.870	1.037.380	0	327.510	0	709.870	1.037.380
SUDESTE	13	ES	0	771.506	0	1.134.457	1.905.962	0	745.151	0	1.048.676	1.793.827	0	745.151	0	1.048.676	1.793.827
	23	MG	0	304.829	0	10.755.437	11.060.266	0	289.661	0	10.168.859	10.458.521	0	289.661	0	10.168.859	10.458.521
	35	RJ	0	674.972	0	6.810.829	7.485.801	0	641.188	0	6.378.099	7.019.287	0	641.188	0	6.378.099	7.019.287
	45	SP	128	4.902.351	599	10.994.958	15.898.036	0	4.627.221	599	10.272.194	14.900.014	0	4.627.221	599	10.272.194	14.900.014
SUL	29	PR	0	1.589.287	645	3.817.330	5.407.262	0	1.486.241	46	3.485.231	4.971.519	0	1.486.241	46	3.485.231	4.971.519
	39	RS	0	1.230.752	1.535	3.925.156	5.157.442	0	1.178.324	0	3.611.498	4.789.822	0	1.178.324	0	3.611.498	4.789.822
	43	SC	0	1.001.463	0	2.410.243	3.411.706	0	920.328	0	2.258.825	3.179.153	0	920.328	0	2.258.825	3.179.153

*UF retirada da Natureza Detalhada.
Fonte: Tesouro Gerencial (11/9/2025)

4. Oferta e Produção de Serviços – Rede Própria, GHC e Institutos

Quadro 31 – Produção Assistencial dos Hospitais Próprios, do Grupo Hospitalar Conceição - GHC e dos Institutos – 2º Quadrimestre de 2025.

ACUMULADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025							
HOSPITAIS FEDERAIS, GHC e INSTITUTOS	Leitos**	ATENDIMENTOS		PROCEDIMENTOS			
		Internações	Consultas	Cirurgias	Partos	Exames Ambulatoriais	Atendimentos Ambulatoriais
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (GHC)	1.526	30.320	758.872	36.828	3.241	1.792.386	2.672.100
HOSPITAIS FEDERAIS*	1.547	19.834	336.938	20.621	660	1.717.465	2.096.787
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER	403	5.172	166.016	4.574	-	652.487	867.075
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA	160	1.773	12.570	1.417	-	133.811	154.127
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	321	3.722	31.805	2.908	-	68.574	100.547
REDE SARAH	709	12.114	285.269	12.049	-	1.024.746	3.152.764
Total Geral	4.666	72.935	1.591.470	78.397	3.901	5.389.469	9.043.400

(*) Hospital Federal do Andaraí (HFA); Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal da Lagoa (HFL); e Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).

(**) Dados enviados pelo DRAC/Saes em 16/9/2025.

Fonte: Base de Dados do SIASUS -Sistema de Informações Ambulatoriais - fornecido pelo DATASUS (tabulados pela CGSI em 16/9/2025).

Fonte: Base de Dados do SIHSUS -Sistema de Informações Hospitalares - fornecido pelo DATASUS (tabulados pela CGSI em 16/9/2025).

Fonte: CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

PERÍODO:

Produção (SIA e SIH): janeiro a junho/2025.

Leitos (CNES): agosto/2025.

OBS: As bases de dados (SIA/SIH) estão atualizadas até o mês de junho/2025 no momento de geração desse relatório.

CRITÉRIOS UTILIZADOS:

- **Leitos:** leitos existentes cadastrados no CNES;
- **Extração dos Dados por Ano de Processamento**
- **Internações:** frequência SIH;
- **Atendimentos ambulatoriais:** frequência SIA;
- **Partos:** 03.10.01.003-9 - PARTO NORMAL;
03.10.01.004-7 - PARTO NORMAL EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO;
03.10.01.005-5 - PARTO NORMAL EM CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN);
04.11.01.002-6 - PARTO CESARIANO EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO;
04.11.01.003-4 - PARTO CESARIANO; e
04.11.01.004-2 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA;
- **Cirurgias:** Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos - SIA e SIH;
- **Consultas:** Subgrupo 0301 - Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos – SIA;
- **Exames:** Grupo 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica – SIA.

CRITÉRIOS UTILIZADOS REDE SARAH:

- **Leitos:** leitos existentes cadastrados no CNES;
- **Extração dos Dados por Ano de Atendimento**
- **Internações:** frequência SIH;
- **Atendimentos ambulatoriais:** frequência SIA;
- **Cirurgias:** Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos – SIA;
Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos Secundárias – SIH/SP;
- **Consultas:** 03.01.01.005-6 - CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR – SIA;
03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SIA;
03.01.01.017-0 - CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO – SIH/SP;
- **Exames:** Grupo 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica – SIA;
Grupo 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica - Secundárias – SIH/SP.

5. Resultados dos Objetivos da PAS – 2º Quadrimestre de 2025

Objetivo 1. Fortalecer a atenção primária, ampliando a cobertura da Estratégia Saúde da Família e da Saúde Bucal, com vistas à universalização do acesso, à abrangência do cuidado integral, à promoção da saúde, à prevenção de doenças e agravos e à redução de desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS) e está organizada de forma descentralizada, sendo desenvolvida pelas equipes e pelos serviços próximos aos locais onde as pessoas vivem e trabalham. A Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) o modelo prioritário para expansão e consolidação da Atenção Primária e traz como princípios a universalidade, a equidade e a integralidade, além das diretrizes de territorialização, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado.

Com vistas à universalização do acesso, à abrangência do cuidado integral, à promoção da saúde, à prevenção de doença e agravos e à redução de desigualdades, este objetivo envolve a ampliação da cobertura populacional estimada da APS, da cobertura populacional estimada de saúde bucal e da cobertura populacional estimada de atenção integral à saúde das populações em situação de rua e privadas de liberdade, e ainda, a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes.

Além disso, visa o provimento de médicos, a realização de inserção de métodos contraceptivos de longa duração, o acesso oportuno ao pré-natal, a oferta de procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), a promoção da alimentação adequada e saudável, a ampliação dos polos do Programa Academia da Saúde, a ampliação da avaliação do risco cardiovascular, o aumento da avaliação do risco de insegurança alimentar, a ampliação da avaliação de exame de rastreamento do câncer de colo do útero e de mama e o acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), dentre outros.

Quadro 32 – Resultados PAS: Objetivo 1 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Ampliar a cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde.	Cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde.	Percentual	75%	69,91%	219A (0001)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
2. Ampliar o número de equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.	Número de equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) implantadas com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.	Unidade	320	319	219A (0004)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
3. Implantar Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF) com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.	Número de Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF) implantadas com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.	Unidade	70	68	219A (0004)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
4. Ampliar o número de equipes Multiprofissionais (eMulti) nos municípios	Número de equipes Multiprofissionais (eMulti) implantadas com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.	Unidade	4.600	5.549	219A (0002)	Saps/MS Estados, DF e Municípios

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
brasileiros, com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.						
5. Ocupar vagas nos programas de provimento médico da Atenção Primária à Saúde.	Número de vagas ocupadas nos programas de provimento médico da Atenção Primária à Saúde.	Unidade	27.000	26.794	21BG 21DX	Saps/MS e SGTES/MS Estados, DF e Municípios
6. Ampliar o quantitativo de polos credenciados do Programa Academia da Saúde.	Número de polos do Programa Academia da Saúde credenciados pelo Ministério da Saúde.	Unidade	1.700	1.843	217U	Saps/MS DF e Municípios
7. Ampliar a realização de inserção de métodos contraceptivos de longa duração na Atenção Primária à Saúde.	Número de procedimentos de inserção de métodos contraceptivos de longa duração na Atenção Primária à Saúde realizados.	Unidade	82.542	44.226 ¹	21CE (0006)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
8. Ampliar a cobertura populacional estimada de atenção integral à saúde das populações em situação de rua e privadas de liberdade.	Cobertura populacional estimada de atenção integral à saúde das populações em situação de rua e privadas de liberdade.	Percentual	78%	67,92%	219A (0004) 8581 (0000)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
9. Ampliar a cobertura populacional estimada de saúde bucal.	Cobertura populacional estimada de saúde bucal.	Percentual	50%	38,78%	219A (0003)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
10. Ampliar a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes.	Número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) estruturadas com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes.	Unidade	24.668	19.891 ²	8581 (0000) 8581 (0003) 8581 (0004)	Saps/MS DF e Municípios
11. Ampliar a proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, tendo iniciado o pré-natal até a 12ª semana de gestação.	Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, tendo iniciado o pré-natal até a 12ª semana de gestação.	Percentual	52%	51,65% ³	219A (0001)	Saps/MS Estados, DF e Municípios

¹ Dado relativo ao período de janeiro a julho de 2025.

² Meta cumulativa, portanto, no resultado considera-se também o total acumulado em 2024.

³ Dado referente ao primeiro quadrimestre de 2025.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
12. Ampliar o registro da oferta de procedimentos de PICS ⁴ na Atenção Primária à Saúde para cada mil habitantes cadastrados na APS no período de 12 meses.	Quantidade de procedimentos de PICS registrados para cada mil habitantes cadastrados na Atenção Primária à Saúde.	Unidade	20	11,31 ⁵	21CE (000D)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
13. Aumentar o número de domicílios com o risco para insegurança alimentar avaliado.	Número de domicílios com risco para insegurança alimentar avaliado.	Unidade	12.000.000	20.585.348 ⁶	20QH	Saps/MS Estados, DF e Municípios
14. Ampliar o percentual de escolas com adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) que realizaram pelo menos uma atividade de promoção da alimentação adequada e saudável.	Percentual de escolas com adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) que realizaram pelo menos uma atividade coletiva com o tema alimentação adequada e saudável.	Percentual	39,5%	23,93% ⁵	20QH 219A (0004)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
15. Alcançar pessoas com idade entre 40 e 74 anos atendidas na Atenção Primária à Saúde que tiveram a avaliação do risco cardiovascular realizada no intervalo de 12 meses, em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária cadastradas na APS.	Proporção de pessoas com idade entre 40 e 74 anos atendidas na Atenção Primária à Saúde com risco cardiovascular avaliado.	Percentual	12%	0,43% ⁷	21CE (000C)	Saps/MS Estados, DF e Municípios
16. Acompanhar, na Atenção Primária à Saúde, os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde nas condicionalidades de saúde.	Percentual de beneficiários do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhados nas condicionalidades de saúde na Atenção Primária à Saúde.	Percentual	80%	31,59% ⁸	Não se aplica	Saps e Sesai/MS Estados, DF e Municípios MDS
17. Ampliar o percentual de mulheres cadastradas na Atenção Primária à Saúde na faixa etária de 25 a 64 anos com exame de	Percentual de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com exame de rastreamento	Percentual	12%	8,89% ⁹	21CE (0001)	Saps e Saes/MS Estados e Municípios

⁴ PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

⁵ Dado relativo ao período de janeiro a julho de 2025.

⁶ Dado preliminar relativo ao período de novembro de 2023 até maio de 2025.

⁷ Dado referente ao primeiro quadrimestre de 2025.

⁸ Dados parciais referentes a 2ª vigência de 2025 do Programa Bolsa Família, com previsão de fechamento em janeiro/2026. Na 1ª vigência de 2025, alcançou-se 81,38%.

⁹ Dados parciais de janeiro a abril de 2025. A previsão de disponibilização do resultado do 2º quadrimestre é a partir de outubro/2025. Os últimos dados disponíveis referem-se ao 1º quadrimestre de 2025, onde 4.759.091 mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos tiveram seus exames de rastreamento de câncer do colo do útero avaliados nos últimos 36 meses. O total de mulheres cadastradas na APS na faixa etária de 25 a 64 anos foi de 53.480.981.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
rastreamento do câncer de colo do útero avaliado nos últimos 36 meses.	do câncer de colo do útero avaliado nos últimos 36 meses.					Inca
18. Ampliar o percentual de mulheres cadastradas na Atenção Primária à Saúde na faixa etária de 50 a 69 anos com exame de mamografia avaliado nos últimos 24 meses.	Percentual de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos com exame de mamografia avaliado nos últimos 24 meses.	Percentual	6%	3,82% ¹⁰	21CE (0001)	Saps e Saes/MS Estados e Municípios Inca
19. Ampliar a proporção de atendimentos individuais por problema ou condição avaliada "obesidade" na Atenção Primária à Saúde.	Proporção de atendimentos individuais por problema ou condição avaliada "obesidade" na Atenção Primária à Saúde.	Percentual	4%	3,61% ¹¹	20QH 219A (0001)	Saps/MS Estados, DF e Municípios

¹⁰ Dados parciais de janeiro a abril de 2025. A previsão de disponibilização do resultado do 2º quadrimestre é a partir de outubro/2025. Os últimos dados disponíveis referem-se ao 1º quadrimestre de 2025, onde 812.591 mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos tiveram seus exames de mamografia de rastreamento avaliados nos últimos 24 meses. O total de mulheres cadastradas na APS na faixa etária de 50 a 69 anos foi de 21.280.417.

¹¹ Dado relativo ao período de janeiro a julho de 2025.

Informações Adicionais

Este objetivo possui 19 metas, sendo 18 monitoradas pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) e uma em parceria entre a Saps e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (Sgtes). Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho por faixas de execução, considerando a previsão para o final do exercício de 2025, constante na Programação Anual de Saúde.

Esse desempenho é o resultado de políticas públicas executadas de forma coordenada entre as três esferas que compõem o SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	1	5,26%
Acima de 25% até 50%	1	5,26%
Acima de 50% até 75%	5	26,32%
Acima de 75% até 100%	9	47,37%
Acima de 100%	3	15,79%
Total	19	100,00%

A **cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde** mensura o percentual da população estimada coberta por equipes de Saúde da Família (eSF), por equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e por equipes de Atenção Primária (eAP) em determinado espaço geográfico. A ampliação das equipes aponta para a busca da universalização do acesso e para promoção da reorganização dos serviços de saúde nos territórios e, ainda, para o fortalecimento do vínculo e do cuidado integral da população.

Considerando o pagamento da parcela de agosto de 2025, a cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde foi de 69,91%, sendo a população coberta total de 148.625.584 pessoas em um universo de 212.583.750 (IBGE 2024). Esse resultado foi calculado com base no número de eSF, de eSFR e de eAP cofinanciadas, conforme os dados disponíveis no e-Gestor, utilizando-se o parâmetro de população adscrita por tipo de equipe, conforme estabelecido na Portaria GM/MS n.º 3.493, de 10 de abril de 2024.

Cobertura populacional estimada da Atenção Primária à Saúde, por UF					
AC	80,42%	MA	86,03%	RJ	62,83%
AL	81,08%	MG	78,36%	RN	82,81%
AM	66,02%	MS	71,72%	RO	66,10%
AP	87,34%	MT	67,21%	RR	91,42%
BA	76,65%	PA	72,50%	RS	68,70%
CE	84,48%	PB	89,79%	SC	80,08%
DF	64,06%	PE	78,44%	SE	84,56%
ES	75,34%	PI	93,42%	SP	51,59%
GO	65,07%	PR	68,08%	TO	89,14%
Brasil: 69,91%					

Fonte: Sistema e-Gestor Atenção Primária à Saúde.

O processo de implantação de equipes é dinâmico, pois depende das necessidades específicas e da organização de cada município em seu território. Além disso, observa-se que há flutuações no número de equipes cofinanciadas, em decorrência de suspensões de pagamento e descredenciamentos motivados pelo não cumprimento de critérios estabelecidos. Tais variações impactam diretamente os resultados de cobertura apresentados. Entre esses critérios, destacam-se a inexistência de irregularidades que justifiquem a suspensão das transferências, conforme previsto na Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), bem como o atendimento às normativas específicas que regulamentam a organização, o

funcionamento e o financiamento de cada tipo de equipe e serviço no âmbito APS. Em razão dessas flutuações, o realizado no segundo quadrimestre de 2025 apresenta-se inferior ao resultado obtido ao final de 2024.

Destaca-se que o MS disponibiliza apoio técnico aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, visando fortalecer a capacidade de execução e gestão dos entes federados, bem como realiza articulação junto aos entes para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre a solicitação de credenciamento e homologação de equipes.

Adicionalmente, registra-se que foi realizado um ajuste na metodologia de cálculo. Em 2025, passou-se a considerar exclusivamente o total de equipes cofinanciadas pelo Ministério da Saúde; o cálculo anterior considerava o total de equipes cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Scnes).

A equipe de Saúde da Família (eSF) possui uma composição mínima que inclui médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), podendo fazer parte da equipe o Agente de Combate às Endemias (ACE). Todos os profissionais da equipe devem cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. Na parcela de agosto de 2025, 54.195 eSF foram cofinanciadas pelo Ministério da Saúde (MS).

As equipes de Atenção Primária (eAP) se diferenciam da eSF, tanto por sua composição, como por suas distintas modalidades de organização de carga horária. São formadas, no mínimo, por médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de família e comunidade, e enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família. Essas equipes podem se organizar em duas modalidades, de acordo com a carga horária: a) modalidade I - composta por profissionais com carga horária mínima individual de 20 horas semanais; e b) modalidade II - composta por profissionais com carga horária mínima individual de 30 horas semanais. No que se refere às eAP, na parcela agosto de 2025, 5.636 foram cofinanciadas pelo MS, sendo 2.719 eAP 20h e 2.917 eAP 30h. Entende-se que a eSF é o modelo prioritário de expansão da Estratégia Saúde da Família, podendo as eAP, posteriormente, se organizarem tal qual o modelo prioritário.

No que diz respeito às equipes de saúde que atuam na Atenção Primária de referência para o atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa, em agosto de 2025 encontravam-se em funcionamento 243 equipes, em 112 municípios de 20 estados.

As **equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)** são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde, que pode estar localizada na sede do município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adscrita. Na parcela de agosto de 2025, 319 eSFR foram cofinanciadas pelo MS.

As **Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF)** são embarcações que comportam equipes de Saúde da Família Fluvial (eSFF) providas com ambiência, mobiliário e equipamentos necessários para atender a população ribeirinha e as comunidades dispersas, cujo acesso se ocorre por meio fluvial. Na parcela de agosto de 2025, havia 68 UBSF implantadas com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde.

As eSFR e as UBSF implantadas estão distribuídas da seguinte forma:

UF	Quantidade de eSFR	Quantidade de UBSF
AC	16	1
AM	131	39
AP	4	1
MA	7	-
PA	154	26
RO	5	-
RR	2	1
Total	319	68

Fonte: Sistema e-Gestor Atenção Primária à Saúde.

As **equipes Multiprofissionais (eMulti)** são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da APS, com

atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a Rede de Atenção à Saúde (RAS). Em agosto de 2025, 5.549 eMulti foram cofinanciadas pelo MS, sendo 776 na modalidade ampliada, 1.900 complementares e 2.873 estratégicas.

Para serem custeadas, essas equipes devem ter sido credenciadas e homologadas, ou seja, avaliadas de acordo com os regulamentos estabelecidos pelo Ministério e consideradas aptas a receber o cofinanciamento federal conforme determinado na Portaria GM/MS n.º 635, de 22 de maio de 2023, com base no registro no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Scnes). Contudo, existem critérios que podem resultar na suspensão do custeio, os quais são avaliados mensalmente e apresentam certa volatilidade devido a fatores como composição profissional, carga horária, vinculação da equipe, ausência de envio de produção por 3 competências consecutivas e denúncia de irregularidade por órgão de controle.

O MS vem desenvolvendo orientações aos gestores para organização do processo de trabalho junto às outras equipes da APS e, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a edição do curso de aperfeiçoamento "eMulti em Formação", além de pesquisas do escopo de práticas e força de trabalho das equipes. Estas ações fortalecem as eMulti e corroboram para o aumento do quantitativo de equipes pagas pelo MS. Até o momento a meta foi superada, assim, ao se observar uma evolução constante, há a previsão de revisão em momento oportuno.

No que se refere aos **programas de provimento médico da Atenção Primária à Saúde**, no mês de agosto de 2025 havia um total de 26.794 vagas ocupadas, conforme dados regionalizados abaixo, sendo 26.123 em municípios, 651 em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) e 20 em gestão estadual. O total de vagas ocupadas nos programas se divide da seguinte forma: 23.383 no Programa Mais Médicos (PMM) - 22.737 em municípios, 626 em Dsei e 20 em gestão estadual; e 3.411 no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) - 3.386 em municípios e 25 em Dsei. Os programas contemplam quatro tipos de equipes de Atenção Primária à Saúde: equipes de Saúde da Família (eSF), equipes de Consultório na Rua (eCR), equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (eMSI) — que atuam nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) — e equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP).

UF	Meta de Ocupação de Vagas (PMM e PMpB)	Total de Vagas Ocupadas (PMM e PMpB)	Percentual de Vagas Ocupadas em Relação a Meta (PMM e PMpB)
AC	254	239	94,09%
AL	419	365	87,11%
AM	1.058	975	92,16%
AP	270	216	80,00%
BA	2.335	2.273	97,34%
CE	1.647	1.721	104,49%
DF	176	163	92,61%
ES	605	590	97,52%
GO	910	767	84,29%
MA	1.190	1.230	103,36%
MG	1.720	2.251	130,87%
MS	294	348	118,37%
MT	402	378	94,03%
PA	2.255	1.497	66,39%
PB	440	479	108,86%
PE	1.426	1.727	121,11%
PI	413	507	122,76%
PR	1.318	1.726	130,96%
RJ	1.440	1.433	99,51%
RN	367	558	152,04%
RO	621	465	74,88%
RR	184	336	182,61%

UF	Meta de Ocupação de Vagas (PMM e PMpB)	Total de Vagas Ocupadas (PMM e PMpB)	Percentual de Vagas Ocupadas em Relação a Meta (PMM e PMpB)
RS	1.453	1.589	109,36%
SC	570	918	161,05%
SE	248	292	117,74%
SP	4.690	3.480	74,20%
TO	295	271	91,86%
Brasil	27.000	26.794	99,24%

Fonte: Departamento de Gestão e Provimento Profissional para o SUS/SGTES/MS.

Cabe registrar que a saúde indígena está sendo fortalecida por meio dos programas de provimento médico, com a promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde e melhoria na qualidade de vida da população indígena. Os profissionais vinculados aos programas de provimento médico atuam nos 34 Dsei, localizados em 18 estados, conforme apresentado abaixo:

Quantidade de Vagas Ocupadas em Dsei (PMM e PMpB)							
Alagoas e Sergipe/AL	14	Interior Sul/SC	20	Pernambuco/PE	16		
Altamira/PA	9	Kaiapó do Mato Grosso/MT	8	Porto Velho/RO	19		
Alto Rio Juruá/AC	17	Kaiapó do Pará/PA	7	Potiguara/PB	14		
Alto Rio Negro/AM	29	Leste de Roraima/RR	32	Rio Tapajós/PA	14		
Alto Rio Purus/AC	12	Litoral Sul/PR	27	Tocantins/TO	12		
Alto Rio Solimões/AM	28	Manaus/AM	25	Vale do Javari/AM	7		
Amapá e Norte do Pará/AP	13	Maranhão/MA	36	Vilhena/RO	9		
Araguaia/MT	5	Mato Grosso do Sul/MS	36	Xavante/MT	22		
Bahia/BA	33	Médio Rio Purus/AM	13	Xingu/MT	8		
Ceará/CE	24	Médio Rio Solimões e Afluentes/AM	19	Yanomami/RR	52		
Cuiabá/MT	15	Minas Gerais e Espírito Santo/MG	22				
Guamá-Tocantins/PA	20	Parintins/AM	14				
Total: 651							

Fonte: Departamento de Gestão e Provimento Profissional para o SUS/SGTES/MS.

Ressalta-se que ambos são programas dinâmicos, nos quais ocorrem desligamentos diários, existindo variações no quantitativo de profissionais alocados (enquanto existem médicos ocupando vagas, outros estão sendo desligados). Para reduzir a rotatividade e garantir a continuidade da assistência à população, o Programa Mais Médicos foi reformulado e possibilita mais oportunidades educacionais. O médico que participa do programa, selecionado por meio de edital, poderá fazer especialização e mestrado em até quatro anos. Os profissionais também passarão a receber benefícios para atuarem nas periferias e nas regiões mais remotas.

O **Programa Academia da Saúde (PAS)**, lançado em 2011, é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos onde são ofertadas práticas de atividades físicas para a população. Esses polos fazem parte da rede de Atenção Primária à Saúde e são dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Em agosto de 2025, 1.843 polos estavam credenciados, destes 1.587 polos foram cofinanciados pelo Ministério da Saúde. Destaca-se que a publicação da Portaria GM/MS n.º 6.912, de 30 de abril de 2025, possibilitou o credenciamento de todos os estabelecimentos que haviam solicitado recurso e estavam com aprovação no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde (Saips) até o dia 10 de março de 2025. Assim, a meta estabelecida para 2025 foi superada.

Os **métodos contraceptivos de longa duração (Larc)** são eficazes para reduzir as gestações não intencionais e suas consequências, como os abortos inseguros e a mortalidade materna e neonatal. São considerados adequados para adolescentes e atendem a um público amplo, com eficácia semelhante à

laqueadura. A ampliação do acesso a estes métodos na APS contribui para a promoção da saúde das mulheres, possibilitando autonomia em suas escolhas e o exercício dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Dentre os métodos contraceptivos de longa duração disponíveis no SUS, destaca-se o Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, com excelente custo-benefício, adequado para a maioria das pessoas e que pode ser utilizado como método de intervalo, pós evento obstétrico ou contracepção de emergência. Com base em dados referentes ao período de janeiro a julho de 2025, houve um total de 44.226 inserções de DIU, conforme quadro abaixo.

Região	Quantidade de Inserções de DIU
Norte	3.393
Nordeste	4.161
Centro-Oeste	7.158
Sudeste	22.254
Sul	7.260
Total	44.226

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (Sisab).

O Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído pela Lei n.º 14.214, de 6 de outubro de 2021, constitui-se em uma estratégia para promoção da saúde e atenção à higiene e possui os seguintes objetivos: I - combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários ao período da menstruação feminina, ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição; e II - oferecer garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual.

No período de janeiro a agosto de 2025, o número de pessoas beneficiadas, por Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), foi de 1.472.614. Considerando a necessidade de aprimorar a análise, a comparabilidade e a transparência das informações, optou-se por adotar, a partir do de julho de 2025, a apresentação dos resultados anuais, em substituição ao formato cumulativo utilizado desde o início da execução do programa.

As estratégias do programa incluem qualificação e formação de agentes públicos, educação da população e oferta gratuita de absorventes higiênicos. Além disso, prevê ações de enfrentamento à desinformação e de conscientização sobre a menstruação enquanto fenômeno natural que deve ser acolhido e cuidado. O Programa Dignidade Menstrual contribui com a agenda transversal de saúde da mulher pelo caráter de promover a saúde de quem menstrua e também promover equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos.

Para aprimorar o programa de distribuição de absorventes pelas Farmácias Populares e melhorar o desempenho na execução, faz-se necessária a superação de algumas barreiras, como: critérios de elegibilidade restritivos, exigência de responsáveis para menores de 16 anos e falta de integração com outras iniciativas, além de reduzir a burocratização do acesso.

A cobertura populacional estimada de atenção integral à saúde das populações em situação de rua e privadas de liberdade mensura o percentual da população estimada coberta por equipes de Consultório na Rua (eCR) e por equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP). É utilizada para o monitoramento do acesso às ações de saúde por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na parcela de agosto de 2025, a cobertura foi de 67,92%, com o cofinanciamento de 286 eCR (154 eCR modalidade III, 31 eCR modalidade II, 101 eCR modalidade I) e 395 eAPP, nas modalidades ampliada e essencial, ambas com a possibilidade de carga horária de 20h e 30h.

A cobertura populacional estimada de saúde bucal é utilizada para mensurar o acesso da população aos serviços de saúde bucal na APS, considerando a estimativa populacional coberta pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) cofinanciadas, as quais podem ter composição variável de acordo com as categorias profissionais, devendo cumprir a carga horária mínima semanal, conforme Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02, de 28 de setembro de 2017.

Com a publicação da Portaria GM/MS n.º 3.493, de 10 de abril de 2024, que instituiu a nova metodologia de cofinanciamento federal do piso de APS, o método de cálculo da cobertura foi revisto.

Para o cálculo da cobertura, estão sendo consideradas as equipes de Saúde Bucal (eSB tipo 71) com carga horária de 40, 30 e 20 horas cofinanciadas pelo Ministério da Saúde. Levou-se em conta as regras de conformidade das equipes, tais como carga horária dos profissionais, vinculação das equipes de saúde bucal com as equipes de saúde da família e de atenção primária, envio de produção, e demais regras de pagamento definidas na Portaria de Consolidação Saps nº 1, de 2 de junho de 2021.

Na parcela de agosto de 2025, a cobertura populacional estimada de Saúde Bucal foi de 38,78%, sendo a população coberta estimada de 82.447.468 pessoas em um universo de 212.583.750 (IBGE 2024).

O alcance dessa meta não depende apenas dos esforços do Governo Federal, mas também da priorização da gestão municipal, além da capacidade instalada das unidades de saúde e de recursos para a implantação e manutenção das equipes. Destaca-se que o MS disponibiliza apoio técnico aos entes federados, visando fortalecer a capacidade de execução e gestão das políticas e serviços, bem como realiza esclarecimento de dúvidas e orientações sobre a solicitação de credenciamento, cadastro e homologação de equipes, visando adequações necessárias nos sistemas de informação, evitando futuras suspensões financeiras e descredenciamentos de eSB. Importante ressaltar ainda, a disponibilização de relatórios públicos do Sistema e-Gestor possibilitando o monitoramento das equipes, a identificação e correção de inconsistências, e transparência das informações.

A seguir consta a cobertura populacional estimada de saúde bucal, por unidade da federação:

Cobertura Populacional Estimada de Saúde Bucal, por UF					
AC	43,74%	MA	62,99%	RJ	24,48%
AL	60,17%	MG	44,98%	RN	67,21%
AM	35,96%	MS	54,11%	RO	22,23%
AP	55,66%	MT	41,96%	RR	42,97%
BA	53,99%	PA	36,52%	RS	27,62%
CE	61,70%	PB	82,88%	SC	35,37%
DF	23,33%	PE	57,06%	SE	56,51%
ES	35,76%	PI	87,41%	SP	17,12%
GO	40,86%	PR	30,54%	TO	70,21%
Brasil: 38,78%					

Fonte: Coordenação-Geral de Saúde Bucal - CGSB/Desco/Saps/MS.

A redução da cobertura em 2025 quando comparada a 2024, se deve ao fato de estarem sendo consideradas apenas as equipes de saúde bucal pagas e não todas as equipes de saúde bucal cadastradas no Scnes; e à redução do parâmetro populacional, pois anteriormente considerava-se um parâmetro populacional fixo por equipe conforme sua carga horária e, atualmente, a estimativa populacional varia de acordo com o porte populacional do município e carga horária das equipes.

Conforme parcela de agosto de 2025, o Ministério da Saúde cofinanciou 33.888 equipes de Saúde Bucal (eSB), sendo 32.068 eSB com carga horária de 40h, 112 eSB com carga horária de 30 horas e 1.708 eSB com carga horária de 20 horas semanais.

As Unidades Odontológicas Móveis (UOM) são consultórios odontológicos estruturados em veículos devidamente adaptados e equipados para o desenvolvimento de ações de atenção à saúde bucal a serem realizadas por equipes de Saúde Bucal vinculadas às equipes da Estratégia de Saúde da Família, que viabilizam a prestação de assistência em áreas com dificuldades de acesso, dispersão populacional e para populações específicas. Na parcela de agosto de 2025, 89 UOM foram cofinanciadas pelo MS. Pode haver oscilação do número de UOM que receberam incentivo de custeio federal entre as competências devido à aplicação das regras de suspensão dos incentivos financeiros federais de custeio previstas na Portaria de Consolidação Saps n.º 1, de 2 de junho de 2021.

No que se refere à aquisição de UOM, informa-se que a Portaria GM/MS n.º 3.257, de 7 de março de 2024, divulgou o resultado do processo de seleção para participação em modalidades específicas do eixo da Saúde no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), onde 396 cidades tiveram suas propostas selecionadas para o recebimento de 400 UOM. O Ministério da Saúde realizou o processo licitatório para a aquisição centralizada das UOM e posterior doação aos municípios selecionados. Até

agosto de 2025, 341 UOM foram entregues e o MS aguarda o envio da solicitação de credenciamento dessas unidades pelos municípios.

O Serviço de Especialidades em Saúde Bucal (Sesb) implantado com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde é uma estratégia de ampliação da oferta de especialidades em saúde bucal, servindo de referência para as equipes de Saúde Bucal (eSB) da APS. Estes serviços foram previstos para municípios de até 30.000 habitantes, que possuam cobertura populacional estimada de saúde bucal na APS de, no mínimo, 75% e não disponham de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) credenciado no município. Na parcela agosto de 2025, 137 Sesb foram cofinanciadas pelo MS.

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) oferecem serviços especializados em Saúde Bucal para atender às principais especialidades necessárias à integralidade do cuidado em saúde bucal, que são: diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia e atendimento a pessoas de necessidades especiais. Em agosto de 2025, havia 1.189 CEO cofinanciados pelo MS, destes 643 CEO estão aderidos à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD).

Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) são os estabelecimentos responsáveis pela confecção laboratorial de próteses dentárias totais, próteses dentárias parciais removíveis e/ou próteses coronárias/intrarradiculares e fixas/adesivas. Na parcela de agosto de 2025, 3.419 municípios possuíam laboratórios cofinanciados pelo Ministério da Saúde. A redução da quantidade de municípios que receberam incentivo de custeio federal no segundo quadrimestre de 2025 deve-se à retomada da aplicação das regras de suspensão dos incentivos federais, previstas na Portaria de Consolidação GM/MS n.º 6, de 28 de setembro de 2017, principalmente ao não envio das informações de produção.

No que se refere a **ampliação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes**, informa-se que, no período de janeiro de 2024 a agosto de 2025, 19.891 UBS foram estruturadas, sendo uma obra de construção com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 438 obras retomadas também com recursos do PAC, 583 UBS com investimento em obras com recursos de programação e de emendas parlamentares (241 UBS reformadas, 122 UBS ampliadas com salas de vacinas e 220 obras de construção de UBS), 18.869 UBS estruturadas com equipamentos de informática cofinanciados. Segue, abaixo, a regionalização:

UBS estruturadas com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes, por UF					
AC	260	MA	947	RJ	704
AL	720	MG	1.328	RN	381
AM	79	MS	866	RO	492
AP	439	MT	536	RR	773
BA	1.050	PA	687	RS	3.595
CE	514	PB	561	SC	473
DF	17	PE	437	SE	178
ES	324	PI	974	SP	1.744
GO	879	PR	615	TO	318
Brasil: 19.891					

Fonte: Coordenação-Geral de Programação de Financiamento da Atenção Primária/Saps/MS.

Em relação às obras de construção de UBS com recursos do PAC, houve a publicação da Portaria GM/MS n.º 1.517, de 9 de outubro de 2023, que instituiu o processo de seleção para participação em modalidades específicas do eixo da Saúde no âmbito do programa, em que considerou, em regra, a vulnerabilidade socioeconômica dos entes subnacionais, a população beneficiada e os vazios assistenciais do serviço associado. Destaca-se que, em agosto 2025, constavam 1.796 propostas habilitadas com recursos de programa, destas, 294 obras em fase de ação preparatória, 1.296 obras em fase de início de execução, 181 obras em fase de execução e conclusão, uma concluída e 24 obras em cancelamento. Registra-se, ainda, quatro propostas habilitadas com recursos de emendas parlamentares, sendo que uma está em fase de ação preparatória e três em início de execução.

No que diz respeito à retomada e à conclusão de obras inacabadas em UBS, mediante aporte financeiro de recursos oriundos do PAC, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS n.º 3.084, de 15 de janeiro de 2024, que regulamenta as repactuações e reativação de obras e serviços de engenharia destinados à saúde. De acordo com as Portarias GM/MS n.º 5.426, de 24 de setembro de 2024, e n.º 6.562, de 24 de janeiro de 2025, 1.149 propostas foram aprovadas e autorizadas, sendo 848 propostas aptas para reativações e 301 para repactuações. Até agosto de 2025, foram concluídas 438 UBS, com recursos do PAC, conforme extração do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) e do Sistema de Investimento do SUS (InvestSUS).

Cumpra esclarecer que a ampliação da infraestrutura das UBS envolve um de esforço amplo, cujo o alcance é multifatorial, por exemplo: iniciativa dos gestores locais em solicitar e registrar formalmente via sistema, propostas de obras e propostas para aquisição de equipamentos necessários para estruturar UBS; disponibilidade orçamentária e financeira de recursos de emendas parlamentares e de programação; capacidade de execução e gestão dos entes subnacionais.

Com vistas à redução dos riscos de não cumprimento da meta, são adotadas as ações a seguir: 1. Orientação aos gestores locais quanto ao prazo do cadastro de proposta para a execução de obras em UBS; 2. Emissão de parecer de diligência aos entes federativos para sanar os impedimentos técnicos identificados por meio do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob); 3. Esclarecimentos quanto aos prazos de execução das obras, bem como quanto ao recurso financeiro aprovado e sua transferência em parcela única; 4. Publicização dos prazos para resolução dos impedimentos técnicos pelos gestores locais; e 5. Disponibilização de canais de atendimento e de manuais instrutivos e materiais informativos aos gestores locais.

As **Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics)** contribuem para a ampliação das ofertas de cuidados em saúde, para a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades; motiva as ações referentes à participação social, incentivando o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde, além de proporcionar maior resolutividade dos serviços de saúde. No período de janeiro a julho de 2025, 2.031.738 procedimentos Pics foram registrados no Sisab, representando 11,31 procedimentos Pics por mil habitantes.

Para contribuir com o alcance da meta, algumas ações foram realizadas: o acompanhamento da execução de Termos de Execução Descentralizada (TED); ações de fortalecimento do vínculo com os territórios, por meio da articulação com as referências técnicas estaduais, elaboração de novas propostas de TEDs voltadas ao fomento das Pics nos territórios; e Implementação do projeto Saúde e Bem Viver – Cuidado integral para a saúde mental.

A **avaliação do risco de insegurança alimentar e nutricional** permite identificar situações de falta de acesso à alimentação adequada e saudável vividas pelas famílias, ainda que não tenham sido identificadas repercussões sobre as condições de saúde e do estado nutricional dos indivíduos, proporcionando a ação de forma precoce com vistas a interromper um ciclo de vulnerabilidades, desigualdades, fome e pobreza. Assim, as equipes da atenção primária podem intervir com ações de promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável, prevenção de carências nutricionais específicas, além de proporcionar a articulação, de forma qualificada, com outros serviços de políticas públicas municipais, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e o Sistema de Assistência Social (Suas), além de organizações e movimentos sociais dos territórios. No período de novembro de 2023 até maio de 2025, foram identificados 1.460.385 domicílios com risco para insegurança alimentar (IA) em um universo de 20.585.348 milhões de domicílios com a triagem para risco de insegurança alimentar (Tria) aplicada. Salienta-se que esses dados são preliminares e sujeitos a alterações. Os relatórios preliminares disponibilizados no e-Gestor possibilitam somente a visualização acumulada para o período informado anteriormente.

No que tange à superação da meta em relação à projeção anual, ressalta-se que, pela Tria ser um novo procedimento, não havia uma série histórica vinculada ao número de registros no Brasil. Assim, há a expectativa de uma possível revisão dessas projeções a partir dos dados registrados.

O **percentual de escolas com adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE)** que realizaram atividades coletivas com o tema alimentação adequada e saudável possibilita identificar a realização de ações de estímulo e apoio às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira no ambiente escolar. As ações de promoção da alimentação adequada e saudável visam incentivar a adoção de uma alimentação equilibrada e nutritiva, com ênfase na alimentação com alimentos in natura, minimamente processados e redução do consumo de alimentos ultraprocessados, promovendo uma alimentação adequada para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Conforme dados extraídos do Sisab, no período de janeiro a julho de 2025, esse percentual foi igual a 23,93%, sendo que 25.112 escolas realizaram pelo menos uma atividade coletiva de um total de 104.931 escolas com adesão ao PSE.

As ações desenvolvidas para o alcance da meta contemplam o trabalho realizado por equipes de atenção primária à saúde no ambiente escolar, por meio de atividades de avaliação do estado nutricional e de hábitos relacionados à alimentação, realização de atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável com abordagem participativa, que envolvem atividades de educação alimentar e nutricional.

A Atenção Primária acompanha os **beneficiários do Programa Bolsa Família nas condicionalidades** de saúde duas vezes ao ano, por semestre/vigência: a primeira vigência corresponde ao período de janeiro a junho e a segunda vigência de julho a dezembro. De acordo com dados parciais da segunda vigência do programa, foram acompanhados 10.871.157 indivíduos, entre os 34.412.447 indivíduos a serem acompanhados, o que representa um resultado de 31,59%. Do total de 8.715.542 crianças a serem acompanhadas, 4,67% foram acompanhadas na APS, das quais 99,42% apresentavam vacinação em dia e 99,81% tiveram seus dados nutricionais coletados. Com relação a gestantes, 99,98% das gestantes localizadas possuíam pré-natal em dia.

A **proporção de atendimentos individuais por problema ou condição avaliada “obesidade”** foi de 3,61%, conforme dados preliminares relativos ao período de janeiro a julho de 2025. Foram 5.040.237 atendimentos por problema ou condição específica de obesidade de um total de 139.498.198 atendimentos realizados na Atenção Primária à Saúde, registrados no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab). Em relação ao desempenho estadual, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Ceará e o Estado de São Paulo se destacam com as maiores proporções de atendimentos relacionados à condição de obesidade, 7,9%, 6,7% e 6,0%, respectivamente. A seguir consta o percentual parcial por unidade da federação:

Proporção de Atendimentos Individuais por Problema ou Condição Avaliada “Obesidade”, por UF					
AC	1,7%	MA	1,3%	RJ	7,9%
AL	2,1%	MG	2,3%	RN	2,3%
AM	2,4%	MS	2,6%	RO	2,5%
AP	2,1%	MT	1,8%	RR	1,0%
BA	1,7%	PA	1,6%	RS	1,8%
CE	6,7%	PB	1,7%	SC	1,6%
DF	2,1%	PE	1,9%	SE	1,6%
ES	1,5%	PI	1,7%	SP	6,0%
GO	1,7%	PR	1,6%	TO	2,2%
Brasil: 3,61%					

Fonte: Sisab – Dados preliminares.

Com vistas ao alcance da meta, foram realizadas reuniões técnicas e oficinas com gestores e referências estaduais para sensibilizar os profissionais de saúde sobre a necessidade do monitoramento adequado e do registro do atendimento às pessoas com múltiplas morbidades, incluindo a obesidade, e sua importância para promover políticas de cuidado no território. Foram estabelecidas, ainda, parcerias com universidades públicas para a oferta de cursos autoinstrucionais, que incluem a qualificação dos profissionais para a organização da prevenção e do tratamento da obesidade de forma a reconhecê-la

como uma condição crônica e sua relação com outras condições crônicas estabelecidas na rotina dos profissionais da APS, como hipertensão e diabetes.

Além disso, têm sido realizados processos de qualificação da Vigilância Alimentar e Nutricional nos municípios a partir do projeto QualiGuia 2 no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Objetivo 2. Ampliar a oferta e o acesso às ações e serviços da Atenção Especializada, conforme as necessidades de saúde da população, reduzindo as desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais, e promovendo a integralidade do cuidado.

Atenção Especializada à Saúde consiste no conjunto de conhecimentos, práticas assistenciais, ações, técnicas e serviços envolvidos na produção do cuidado em saúde, de maior densidade tecnológica, relacionadas à urgência e emergência hospitalar, atenção domiciliar, atenção materno-infantil, atenção ambulatorial especializada, atenção psicossocial, apoio ao diagnóstico e terapêutico, transplante, reabilitação da pessoa com deficiência e sangue e hemoderivados, organizados no âmbito dos programas, redes e serviços que compõem a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (Portaria GM/MS n.º 1.604/2023).

Tendo em vista os desafios relacionados à oferta e ao acesso da população ao cuidado à saúde condizentes aos princípios da universalidade, integralidade e equidade no SUS, foram estabelecidas enquanto prioridades para o alcance do objetivo: a ampliação da oferta de ações e serviços de Atenção Especializada para a promoção do acesso oportuno, especialmente em áreas de vazio assistencial, em especial no cuidado intermediário e na necessidade de tratamento avançado, assim como a melhoria da qualidade do atendimento. Para tanto, este objetivo prevê ações direcionadas à formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e a qualificação das ações e serviços de saúde para oferecer atendimento de qualidade aos pacientes, a redução das filas de procedimentos eletivos, dentre outras intervenções direcionadas à redução das desigualdades regionais, sociais, raciais/étnicas e de gênero.

Quadro 33 – Resultados PAS: Objetivo 2 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Ampliar os procedimentos especializados realizados (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) para o tratamento do câncer.	Número de procedimentos especializados realizados (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) para o tratamento do câncer ao ano.	Unidade	4.753.741	2.615.201 ¹²	8585 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
2. Ampliar a oferta de serviços de saúde mental financiados pelo Ministério da Saúde, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial.	Número de serviços de saúde mental financiados pelo Ministério da Saúde.	Unidade	6.876	6.272	8585 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
3. Ampliar o número de pessoas beneficiárias do Programa de Volta para Casa.	Número beneficiários do Programa de Volta para Casa.	Unidade	5.015	3.795	20AI (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
4. Alcançar a taxa de expansão de procedimentos de cirurgias eletivas proposta para cada ano.	Taxa de expansão de cirurgias eletivas.	Nº decimal	1,25	0,92 ¹³	8585 (0000) 8585 (0005) 8535 (0017)	Saes/MS Estados, DF e Municípios

¹² Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2025, apurados em 10/9/2025.

¹³ Dados referentes ao período de janeiro a julho de 2025.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
5. Ampliar a cobertura populacional de Atenção Domiciliar.	Percentual cobertura populacional de Atenção Domiciliar.	Percentual	46%	45% ¹⁴	8585 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
6. Emitir a certificação de qualidade dos hospitais públicos e privados sem fins lucrativos, que realizam serviços de alta complexidade no SUS.	Número de hospitais públicos e privados sem fins lucrativos, com certificação integrada da qualidade em alta complexidade e ensino, emitida pelo Ministério da Saúde.	Unidade	300	0 ¹⁵	21CD (0002)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
7. Ampliar o número de leitos de terapia intensiva adulto, financiados pelo Ministério da Saúde.	Número de leitos de terapia intensiva adulto financiados pelo Ministério da Saúde.	Unidade	23.300	22.846	8585 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
8. Ampliar o número de profissionais especialistas atuando no SUS.	Número de novos profissionais especialistas atuando no SUS, por meio de estratégias de provimento.	Unidade	6.300	0 ¹⁶	8585 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
9. Ampliar os procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e córnea realizados.	Número de procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e córnea realizados ao ano.	Unidade	27.881	18.102	8585 (0000) 8585 (0005)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
10. Ampliar o número dos transplantes de células-tronco hematopoéticas (transplante de medula óssea) realizados.	Número de procedimentos de transplantes de células-tronco hematopoéticas (TCTH) realizados ao ano.	Unidade	3.382	1.810 ¹⁷	8585 (0000) 8585 (0005)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
11. Ampliar o índice de doador de órgãos por milhão de população (pmp).	Índice de doadores de órgãos por milhão de população (pmp).	PMP ¹⁸	22,9	13,0	8585 (0000) 8585 (0005)	Saes/MS Estados, DF e Municípios

¹⁴ No período de janeiro a junho de 2025.

¹⁵ Até agosto de 2025, não houve hospital público nem privado sem fins lucrativos com certificação integrada da qualidade em alta complexidade e ensino emitida pelo MS. A metodologia proposta para o Programa foi reestruturada, contemplando dois níveis de certificação: a avaliação documental e a visita in loco. O processo de certificação prevê a criação de uma Comissão Interministerial de Acompanhamento, composta por representantes do MS e do Ministério da Educação (MEC), e aguarda publicação de Portaria Interministerial.

¹⁶ Em junho de 2025, foi instituído o Projeto Mais Médicos Especialistas, que integra as iniciativas do Programa Agora tem Especialistas, com o objetivo de fortalecer a presença de especialistas em unidades de saúde de média e alta complexidade. Foram lançados os editais de chamamento público n.º 2/2025, para adesão de gestores ao projeto, e n.º 3/2025, para adesão médicos especialistas. Na primeira chamada foram selecionados 501 médicos, com início das atividades previsto para setembro de 2025.

¹⁷ Dados referentes ao período de janeiro a julho de 2025.

¹⁸ PMP (Por Milhão de população).

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
12. Implantar o modelo de Informação de regulação assistencial nos municípios.	Percentual de municípios com modelo de Informação de regulação assistencial implantado	Percentual	65%	60%	-	Saes/MS Estados, DF e Municípios
13. Ampliar as regiões de saúde com oferta de serviços de reabilitação financiadas pelo Ministério da Saúde.	Percentual de regiões de saúde com oferta de serviços de reabilitação financiados pelo Ministério da Saúde.	Percentual	49%	43%	8585 (0000) 8585 (0005) 8535 (0000) 8535 (0004) 8535 (000P) 8535.6506	Saes/MS Estados, DF e Municípios
14. Ampliar as coletas de sangue no SUS, em 2% ao ano, para disponibilizar sangue, componentes e derivados aos serviços de saúde necessários à realização dos procedimentos de média e alta complexidade.	Número de coletas de sangue realizadas no SUS ao ano.	Unidade	3.287.428	1.647.956 ¹⁹	6516 (0000) 21D9 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
15. Ampliar os serviços de hematologia e hemoterapia com melhoria das instalações físicas financiados pelo Ministério da Saúde.	Números de serviços de hematologia e hemoterapia com melhoria das instalações físicas financiados pelo Ministério da Saúde.	Unidade	66	0 ²⁰	21D9 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
16. Ampliar o percentual de recém-nascidos vivos com coleta do teste do pezinho até o 5º dia de vida, triados no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).	Percentual de recém-nascidos vivos com coleta do teste do pezinho até o 5º dia de vida triados no PNTN.	Percentual	67%	64,05%	8585 (0000) 6516 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
17. Ampliar a cobertura do exame doppler transcraniano para crianças com doença falciforme com dois anos de idade.	Percentual de crianças com doença falciforme com dois anos de idade que realizaram o exame doppler transcraniano.	Percentual	40%	3,06% ²¹	8585 (0000) 6516 (0000) 21D9 (0000)	Saes/MS Estados, DF e Municípios

¹⁹ Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2025.

²⁰ Até agosto de 2025 não houve conclusão de nenhuma proposta de melhoria das instalações físicas dos serviços de Hemoterapia e Hematologia, sejam obras ou aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O MS tem realizado apoio técnico para a execução dos projetos, revisão de normativos, além de articulação contínua com os gestores locais para adequação dos projetos arquitetônicos, acompanhamento das obras e elaboração de estratégias para a superação de entraves operacionais e jurídicos. Nesse sentido, foram enviados aos gestores locais, via ofício, formulários para monitoramento detalhado da execução dos instrumentos de repasse firmados em 2024.

²¹ Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2025.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
18. Ampliar o número de exames diagnósticos realizados no SUS para doenças raras e condições genéticas crônicas e complexas.	Número de exames diagnósticos realizados no SUS para doenças raras e condições genéticas crônicas e complexas ao ano.	Unidade	65.535	32.773 ²²	8585 (0005) 8535 (000F) 21CD (0004)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
19. Ampliar a oferta de procedimentos para a população trans, previstos na atenção especializada à saúde.	Número de procedimentos realizados na atenção especializada à saúde previstos para a população trans ao ano.	Unidade	21.000	17.386 ²³	8585 (0005)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
20. Ampliar a cobertura populacional com vistas à Universalização do SAMU 192.	Percentual de população coberta pelo SAMU 192.	Percentual	95%	88,71%	8585 (0001) 8535 (000N)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
21. Realizar Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), previstas nos Planos de Ação Regional (PAR) aprovados, no âmbito do Programa Mais Acesso a Especialistas (Pmae).	Percentual de Ofertas de Cuidados Integrados (OCI) realizadas, em relação as previstas nos Planos de Ação Regional (PAR) aprovados.	Percentual	80%	0,97% ²⁴	8585 (0001) 8585 (0005)	Saes/MS Estados, DF e Municípios
22. Ampliar a oferta de serviços de saúde materna e infantil financiados pelo Ministério da Saúde, no âmbito da Rede Alyné.	Número de serviços de saúde materna e infantil financiados pelo Ministério da Saúde.	Unidade	11.374	9.940	8585 (0001)	Saes/MS Estados, DF e Municípios

²² Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2025.

²³ Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2025. Retifica-se o número de procedimentos realizados na atenção especializada à saúde previstos para a população trans informado no 1º RQPC/2025 de 7.735 para 8.153. Justifica-se a retificação devido à correção do parâmetro para contabilização dos procedimentos de “ano/mês de processamento” para “ano/mês de atendimento”.

²⁴ No período de janeiro a junho de 2025.

Informações Adicionais

Este Objetivo possui 22 metas monitoradas pela Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (Saes). Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, no 2º quadrimestre, divididos em cinco intervalos percentuais, considerando as previsões para o final do exercício de 2025 (PAS). Ressalta-se que esse resultado reflete as políticas públicas executadas de forma ampla, ou seja, aquelas que envolvem os esforços de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	5	22,73%
Acima de 25 até 50%	0	0,00%
Acima de 50% até 75%	7	31,82%
Acima de 75% até 100%	10	45,45%
Acima de 100%	0	0,00%
Total	22	100,00%

No período de janeiro a junho de 2025, no panorama nacional, foram realizados 2.615.201 **procedimentos especializados (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) para o tratamento do câncer**, conforme disponibilidade dos dados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) - dados apurados em 10/09/2025 - sendo 249.456 procedimentos cirúrgicos, 88.262 procedimentos de radioterapia e 2.277.483 procedimentos de quimioterapia, o que corresponde 55,01% da meta prevista para o ano de 2025.

Com o objetivo de alcançar as regiões com vazios assistenciais em relação aos equipamentos oncológicos, o MS tem mapeado essas áreas para que possam ser priorizadas nas ações dos projetos PER-SUS 1 e 2, que visam implantar soluções em radioterapia e ampliar a oferta desses serviços. Além disso, estão sendo adquiridos aceleradores lineares para a atualização dos serviços de radioterapia existentes no SUS. Essas iniciativas são apoiadas com recursos do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). A modernização da infraestrutura e a formação de profissionais qualificados são essenciais para garantir maior equidade no acesso ao tratamento em todo o país.

No período de janeiro a agosto de 2025, na **Rede de Atenção Psicossocial (Raps)**, houve 100 novas habilitações de serviços de saúde e uma desabilitação, totalizando 6.272 serviços de saúde mental financiados pelo Ministério da Saúde, o que representa 91,22% da meta prevista para 2025. É importante registrar que a Raps encerrou o ano de 2024 com 6.173 serviços de saúde mental financiados pelo Ministério da Saúde, representando um crescimento de 4,1% em relação aos 5.930 serviços habilitados em 2023. Este incremento evidencia o esforço contínuo de expansão da cobertura da atenção psicossocial no país, em consonância com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da Política Nacional de Saúde Mental. Cabe destacar que, ao longo do ano, o número de serviços pode variar devido a novos processos de habilitação, qualificação ou desabilitação, o que reforça a importância do monitoramento contínuo para assegurar a adequação da rede às necessidades dos territórios e à sustentabilidade da política de saúde mental no âmbito do SUS.

Atualmente, a rede é composta pelos seguintes serviços: a) 3.061 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I: 1.542 + CAPS II: 525 + CAPSi: 336 + CAPS III: 153 + CAPS AD: 337 + CAPS AD III: 165 + CAPS AD IV: 3); b) 956 Serviços Residenciais Terapêuticos, sendo: Tipo I (331) e Tipo II (625); c) 86 Unidades de Acolhimento Adulto (55) e Infantil (31); d) 2.169 Leitos de saúde mental em hospitais gerais; e) Centros de Convivência: ainda não existem serviços habilitados pelo Ministério da Saúde, visto que a Portaria que institui o serviço está em tramitação para publicação no Diário Oficial da União. A Raps conta, ainda, com 224 equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental financiadas pelo Ministério da Saúde.

Até agosto de 2025, 3.795 **pessoas foram beneficiárias do Programa de Volta para Casa (PVC)**, com cadastro ativo, o que corresponde a 75,7% da meta prevista para o ano de 2025. Ao se comparar os resultados apresentados no primeiro 1º RQPC, observa-se um decréscimo significativo de 616

beneficiários. Isso se deve a problemas na consolidação dos dados. Apesar de as demandas de agosto terem sido devidamente processadas, o recebimento dessas solicitações por via eletrônica contribui para uma base de dados parcial, dada a dificuldade de consolidação contínua das informações. Além disso, é importante considerar que as limitações do sistema atual impedem o fornecimento de relatórios detalhados a respeito de inclusões, suspensões e exclusões, estratificados por UF ou município, o que limita o fornecimento de dados regionalizados a respeito deste processo.

A execução da meta do PVC encontra-se em curso, porém demanda esforços adicionais para promover novas inclusões e garantir a atualização permanente das referências técnicas municipais. Para tanto, foi realizado um mapeamento dos municípios com perfis elegíveis ao benefício e expedidos ofícios a todas as Secretarias Estaduais de Saúde Mental, solicitando o monitoramento de potenciais beneficiários e o acompanhamento daqueles já inseridos no PVC. Em razão das frequentes alterações nas equipes gestoras estaduais e municipais, o acompanhamento deve ser contínuo, devendo-se identificar, periodicamente, as localidades com referências técnicas desatualizadas e articular ações de campo para sua regularização.

Paralelamente, reconhece-se a necessidade premente de modernizar o sistema de gestão do programa, cuja versão atual implementada em 2003 encontra-se obsoleta. Nesse sentido, o projeto preliminar de atualização foi concluído e encaminhado ao Datasus/MS para avaliação e desenvolvimento da nova plataforma, a fim de otimizar processos, assegurar a precisão dos dados e fortalecer a capacidade de monitoramento e avaliação do programa. Também é necessário destacar que o alcance das metas do PVC está intrinsecamente ligado aos processos de desinstitucionalização, ou seja, de retirada das pessoas moradoras de hospitais psiquiátricos e sua inserção em Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) ou outros arranjos possíveis, como o acolhimento nas famílias de origem ou vinculação a outros programas sociais de garantia de moradia. Para tanto, é necessária a tomada da decisão pelos gestores locais e o desenvolvimento da cadeia de processos para que sejam extintas as vagas de moradores em hospitais psiquiátricos, com a concomitante expansão da rede comunitária de cuidados.

No período de janeiro a julho de 2025, a **taxa de expansão de cirurgias eletivas** foi de 0,92, evidenciando uma retração de 8% em relação ao mesmo período de 2024. No mesmo período de 2024 foram aprovadas 755.662 cirurgias eletivas e em 2025 esse número caiu para 697.986. É importante destacar que o indicador mede a variação da produção de cirurgias eletivas em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que valores superiores a 1 indicam aumento e valores inferiores a 1 sinalizam retração.

No que se refere a regionalização, a análise mostra que apenas a Região Centro-Oeste apresentou expansão (1,12, com crescimento de 12%, puxado principalmente por Goiás). O Sul ficou próximo da estabilidade (0,98, retração de 2%), enquanto Sudeste (0,95, retração de 5%), Norte (0,87, retração de 13%) e Nordeste (0,81, retração de 19%) registraram reduções expressivas. No recorte por estados, destacaram-se as maiores taxas de expansão no Amapá (101,71, efeito de base muito baixa em 2024), em Minas Gerais (1,60), Goiás (1,56), Rio Grande do Sul (1,46), Rio Grande do Norte (1,27), Santa Catarina (1,10) e Acre (1,05). Em contrapartida, as retrações mais acentuadas ocorreram no Espírito Santo (0,15), Paraná (0,26), Mato Grosso (0,29), Sergipe (0,39) e Amazonas (0,41). Também foram observadas quedas moderadas no Distrito Federal (0,60), Rio de Janeiro (0,65), Mato Grosso do Sul (0,65), Roraima (0,66), Ceará (0,78), Pernambuco (0,76), Maranhão (0,74), Paraíba (0,83), Rondônia (0,83), Pará (0,85), Tocantins (0,93), Bahia (0,90) e São Paulo (0,91). O estado com maior produção absoluta foi Santa Catarina, que realizou 184.600 procedimentos, enquanto a Região Sudeste concentrou o maior volume regional, com 245.444 cirurgias. Ressalta-se que os dados utilizados são parciais e estão sujeitos a atualização, devido aos prazos de processamento do SIA e do SIH.

O Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), instituído pela Portaria GM/MS n.º 90/2023, foi criado para enfrentar a demanda reprimida de cirurgias, consultas e exames especializados acumulados durante uma pandemia. Em 2024, passou a compor o Programa Mais Acesso a Especialistas (Pmae) como Componente Cirurgias, a partir das Portarias GM/MS n.º 2.336 e n.º 5.820 e da Portaria SAES/MS n.º 2.324.

Em 2025, foi incorporado ao Programa Agora Tem Especialistas – Componente Cirúrgico, instituído pela Portaria GM/MS n.º 7.266, que manteve o financiamento via Faec e vinculou a execução a um rol específico de procedimentos. O acompanhamento é realizado pela taxa de expansão de cirurgias, que

mede a variação do volume realizado no país, envolvendo regulação, monitoramento e avaliação compartilhados entre o Ministério da Saúde, estados e municípios.

Uma das estratégias para impulsionar a produção de cirurgias é ampliar o número de estabelecimentos habilitados que realizam cirurgias pelo Pmae. Em julho de 2025, havia 1.110 estabelecimentos habilitados no Componente Cirurgias do Pmae. A distribuição foi a seguinte: Região Norte com 88 (sendo Rondônia 14, Acre 1, Amazonas 11, Pará 25, Amapá 2 e Tocantins 35), Região Nordeste com 218 (Maranhão 52, Piauí 2, Ceará 64, Rio Grande do Norte 7, Paraíba 49, Pernambuco 28, Alagoas 7, Sergipe 2 e Bahia 7), Região Sudeste com 515 (Minas Gerais 222, Espírito Santo 13, Rio de Janeiro 72 e São Paulo 208), Região Sul com 236 (Paraná 51, Santa Catarina 125 e Rio Grande do Sul 60) e Região Centro-Oeste com 53 (Goiás 39, Mato Grosso do Sul 7, Mato Grosso 3 e Distrito Federal 4). A maior concentração encontra-se no Sudeste, seguida pelo Sul e pelo Nordeste. Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Ceará, juntos, responderam por quase metade das habilitações nacionais.

Esse panorama demonstra que, embora haja experiências positivas de expansão em alguns estados como Amapá, Minas Gerais e Goiás, a tendência nacional e regional ainda é de retração na produção de cirurgias eletivas, o que reforça a necessidade de ajustes na execução e no monitoramento do Programa Agora Tem Especialistas – Componente Cirúrgico, especialmente no contexto amazônico, onde as desigualdades de acesso, a dispersão territorial e as barreiras logísticas são mais acentuadas.

Apesar da retração observada na produção de cirurgias eletivas no primeiro semestre de 2025, ocasionada principalmente por essas desigualdades, o Ministério da Saúde tem adotado medidas estratégicas para reverter esse quadro. Entre elas, destacam-se o fortalecimento da regulação e do monitoramento compartilhado entre União, Estados e Municípios, além do apoio técnico às gestões locais para qualificar a execução, em consonância com os objetivos do Programa Agora Tem Especialistas. Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas cirúrgicas itinerantes) que passaram a percorrer o território nacional, a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas ampliam a resolutividade da rede, fortalecem a regionalização e oferecem resposta concreta à demanda reprimida de cirurgias eletivas, garantindo mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada. A seguir é apresentado o número de cirurgias realizadas e a taxa de expansão, por UF e Região:

Taxa de Expansão de Cirurgias Eletivas, UF e Região			
Região/UF	Número de Cirurgias (2024)	Número de Cirurgias (2025)	Taxa de Expansão (2025)
Região Norte	53.841	46.962	0,87
AC	8841	9277	1,05
AP	56	5696	101,71
AM	13796	5605	0,41
PA	13044	11124	0,85
RO	5112	4261	0,83
RO	4143	2741	0,66
TO	8849	8258	0,93
Região Nordeste	191.986	155.348	0,81
AL	3452	3003	0,87
BA	39546	35411	0,90
CE	24239	18893	0,78
MA	19600	14556	0,74
PB	37699	31290	0,83
PE	45500	34687	0,76
PI	7614	5686	0,75
RN	7062	8951	1,27
SE	7274	2871	0,39
Região Sudeste	259.044	245.444	0,95
ES	21972	3351	0,15
MG	63561	101726	1,60
RG	65023	42000	0,65
SP	108488	98367	0,91

Taxa de Expansão de Cirurgias Eletivas, UF e Região			
Região/UF	Número de Cirurgias (2024)	Número de Cirurgias (2025)	Taxa de Expansão (2025)
Região Sul	214.659	209.696	0,98
PR	35472	9343	0,26
RS	10807	15753	1,46
SC	168380	184600	1,10
Região Centro-Oeste	36.132	40.536	1,12
DF	7664	4597	0,60
GO	20480	32015	1,56
MT	3552	1046	0,29
MS	4436	2878	0,65
Brasil	755.662	697.986	0,92

Fonte: Saes/MS. Dados apurados em 15/9/2025. Competência: julho/2025.

Até junho de 2025, a **cobertura populacional da Atenção Domiciliar** atingiu 45%. No período de janeiro a junho de 2025, não houve novas habilitações de equipes, portanto a cobertura populacional se manteve. Nos meses de maio e junho de 2025, 190 propostas foram avaliadas, aprovadas em mérito e aguardam habilitação. Atualmente, o Programa Melhor em Casa está presente em 1.000 municípios, com 2.187 equipes habilitadas, atendendo a uma população de 96.315.293 habitantes, dentro de um total de 213.317.639 habitantes no Brasil, conforme a estimativa do TCU 2021. Essa estimativa populacional também serve de base para o Fundo de Participação Municipal, sendo, portanto, um dado crucial para cálculos populacionais, habilitação de equipes e distribuição de recursos orçamentários.

Em relação à regionalização, observa-se que a cobertura populacional da Atenção Domiciliar varia conforme as regiões do Brasil. A Região Nordeste apresenta a maior cobertura com 49%, seguido da Região Centro-Oeste com 41%, Região Sudeste com 39%, Região Norte com 38%, e Região Sul com 34%. Vale ressaltar que, apesar dos esforços do Ministério da Saúde para expandir a cobertura da Atenção Domiciliar, a ampliação da habilitação das equipes depende das decisões das gestões locais (estaduais e municipais), o que impacta diretamente no potencial crescimento da cobertura populacional. Destaca-se, ainda, que as capitais e estados com maior concentração populacional, como Minas Gerais (53%), São Paulo (46%), Rio de Janeiro (46%), Bahia (40%) e Paraná (34%), já possuem uma cobertura superior a 30% em relação ao Programa Melhor em Casa.

Contudo, muitos municípios, com menor número de habitantes, podem habilitar apenas uma equipe EMAP – R (Equipe Multiprofissional de Apoio e Reabilitação), conforme a Portaria GM/MS 3.005, de 2 de janeiro de 2024, que destina essa modalidade de equipe a municípios com menos de 19.999 habitantes. Essa situação sugere que, para um crescimento de 1% na cobertura populacional, será necessário atender a mais de 1 milhão de novos habitantes, ampliando significativamente o alcance do Programa. Esses pontos devem ser considerados ao analisar os resultados apresentados.

De janeiro a agosto de 2025, foram habilitados 237 novos **leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto**. Neste período também foram desabilitados 49 leitos, totalizando 22.846 leitos financiados pelo Ministério da Saúde (novos e manutenção dos existentes). Durante o ano, a quantidade total de serviços habilitados pode sofrer acréscimo ou decréscimo, pois também podem ocorrer desabilitações.

Cabe salientar que o índice de referência (21.982 – maio/2023), que orientou a projeção das metas anuais, era um índice parcial. Portanto, tendo em vista que a meta contempla a manutenção de todos os leitos existentes, foi necessário contabilizar os leitos habilitados no período de junho a dezembro de 2023 (263), totalizando 22.245 de leitos de UTI adultos em 2023. Já em 2024, foram habilitados 423, totalizando 22.658.

A solicitação para ampliação de leitos de UTI parte dos gestores de saúde locais (Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), após pactuação na CIB. O MS é demandado, homologando ou não a requisição dos entes. A adesão dos municípios é voluntária e depende da capacidade de implantação local, bem como da atração e fixação dos profissionais. A seguir são apresentadas as quantidades de leitos por UF:

Número de leitos de terapia intensiva adulto financiados pelo Ministério da Saúde, por UF					
AC	55	MA	588	RJ	1.823
AL	332	MG	2.697	RN	285
AM	271	MS	325	RO	245
AP	19	MT	358	RR	47
BA	1.273	PA	641	RS	1.350
CE	825	PB	438	SC	899
DF	416	PE	1.106	SE	192
ES	719	PI	245	SP	5.166
GO	794	PR	1.638	TO	99
Brasil: 22.846					

Fonte: Saes/MS. Dados apurados em 31/8/2025. Competência: agosto/2025

No período de janeiro a agosto de 2025, os **procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e de córneas** alcançaram um total de 18.102 transplantes realizados, representando 64,93% da meta prevista 2025. Esses dados foram extraídos em 08/09/2025, a partir do Sistema de Informação e Gerenciamento de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes (SIG/SNT). Em âmbito nacional, foi registrada uma média de 89,1 transplantes por milhão de habitantes no período. Para este cálculo foi considerada a população do censo IBGE de 2022 (203.080.756 hab.).

Conforme dados atualizados, em 2024 os procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e de córneas alcançaram um total de 26.521, superando a meta prevista para aquele ano. Essa conquista demonstra a eficácia da política do Sistema Nacional de Transplantes, que se fortaleceu com programas dedicados a acelerar a recuperação, reestabelecendo os níveis de atividade pré-pandêmicos.

É importante salientar que os dados de 2025 são parciais e estão sujeitos a atualizações, conforme os prazos definidos pelo Sistema Nacional de Transplantes e estipulado na Portaria de Consolidação n.º 4, de 28 de setembro de 2017. De acordo com esta regulamentação, as centrais estaduais de transplante devem enviar informações atualizadas sobre todas as atividades relacionadas aos transplantes estaduais até o décimo dia do mês seguinte. Isso inclui atividades relacionadas a doadores vivos e a confirmação dos transplantes pelas equipes transplantadoras no SIG/SNT até 15 dias após sua realização.

Quanto à regionalização, apesar dos avanços observados em nível nacional, a produção de transplantes ainda apresenta desigualdades regionais. A região Sul liderou em procedimentos realizados por milhão de habitantes (PMP), com 109,7 PMP e um total de 3.285 transplantes no período, seguida pelas regiões Sudeste (99,9 PMP), Centro-Oeste (89,0 PMP), Nordeste (78,9 PMP) e Norte, com o menor índice: 33,1 PMP. A seguir são apresentados os dados por UF:

Número de procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e córneas, por UF											
UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População
AC	24,1	20	830.018	MA	58,6	397	6.776.699	RJ	62,7	1.006	16.055.174
AL	32,3	101	3.127.683	MG	66,5	1.365	20.539.989	RN	47,5	157	3.302.729
AM	35,8	141	3.941.613	MS	99,0	273	2.757.013	RO	46,8	74	1.581.196
AP	0,0	0	733.759	MT	68,3	250	3.658.649	RR	0,0	0	636.707
BA	58,0	820	14.141.626	PA	35,1	285	8.120.131	RS	111,6	1.214	10.882.965
CE	144,5	1.271	8.794.957	PB	36,2	144	3.974.687	SC	105,1	800	7.610.361
DF	156,2	440	2.817.381	PE	113,4	1.027	9.058.931	SE	71,9	159	2.210.004
ES	109,8	421	3.833.712	PI	73,1	239	3.271.199	SP	128,0	5.686	44.411.238
GO	68,9	486	7.056.495	PR	111,1	1.271	11.444.380	TO	36,4	55	1.511.460
Brasil: 18.102 (89,1 PMP)											

Dados referentes a janeiro agosto de 2025, extraídos em 29/9/2025. Competência: agosto/2025.

Dados sujeitos a alterações com base no envio ou correção futura de dados.

PMP: Partes por Milhão da População, referente ao ano de 2022 (203.080.756 milhões), segundo o IBGE.

Fonte: Sistema Informatizado do Ministério da Saúde - SIG/SP/SNT/Centrais Estaduais de Transplantes (CET).

No período de janeiro a julho de 2025, **1.810 transplantes de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) foram realizados**, representando 53,52% da meta prevista para o ano, conforme dados extraídos 09/09/2025, a partir do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Em âmbito nacional, o Brasil registrou uma média de 8,9 transplantes por milhão de habitantes no período. Para calcular o índice PMP, utilizou-se a população referente ao ano de 2022, de 203.080.756 milhões, do IBGE.

Como o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) ainda não conta com um módulo informatizado específico para o registro desse tipo de procedimento, observa-se subnotificação, especialmente em relação aos transplantes realizados na rede privada. Desta forma, os dados disponíveis referem-se exclusivamente à produção do SUS. Cabe destacar que os dados referentes ao mês de agosto de 2025 ainda não foram inseridos devido ao prazo de processamento e consolidação das informações nos sistemas SIH/SUS e SIA/SUS, o que pode impactar temporariamente o acompanhamento da meta anual.

É importante destacar que essa meta tem como objetivo a realização de transplantes de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) visando ampliar especificamente o acesso a um tratamento essencial para diversas doenças hematológicas, imunológicas e oncológicas, sendo, portanto, um componente estratégico da Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde. A realização dos procedimentos de TCTH de forma segura, equitativa e com cobertura nacional ampliada, garante maior sobrevida e qualidade de vida aos pacientes atendidos no SUS. Para tanto, está sendo realizada a revisão do regulamento técnico vigente, considerando o surgimento de novas tecnologias e a necessidade de revisão das normas que serão importantes para o aumento do número de procedimentos TCTH. O novo regulamento técnico tem previsão de publicação no mês de setembro de 2025 e até o mês de julho/2025 está com 95% do seu andamento realizado. Além disso, para melhoria da qualidade dos serviços há uma previsão de capacitação da rede e dos centros transplantadores, tendo sido realizadas nove capacitações até o mês de julho.

Quanto à regionalização, a região Sudeste liderou em número absoluto de transplantes, com 959 procedimentos, seguida pelo Sul (401). Porém, em termos proporcionais, a região Sul apresentou o melhor desempenho (13,4 PMP), refletindo a concentração de centros especializados e serviços habilitados. Já o Sudeste se destaca com o estado de São Paulo, que realizou 653 transplantes (14,7 PMP), sendo responsável por mais de 1/3 da produção nacional. Por outro lado, na região Norte, alguns estados não conseguem o transplante de medula óssea, e os que fazem estão habilitados apenas para algumas modalidades, como o transplante de medula autólogo (essa modalidade é técnica menos complexa, pois não depende da busca por um doador compatível. As células-tronco são do próprio paciente, não há risco de colisão e as complicações são, em geral, mais controláveis). A seguir são apresentados os dados por UF:

Número de transplantes de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) realizados											
UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População
AC	0,0	0	830.018	MA	0,0	0	6.776.699	RJ	4,0	64	16.055.174
AL	0,0	0	3.127.683	MG	10,4	213	20.539.989	RN	21,5	71	3.302.729
AM	0,0	0	3.941.613	MS	0,0	0	2.757.013	RO	0,0	0	1.581.196
AP	0,0	0	733.759	MT	0,0	0	3.658.649	RR	0,0	0	636.707
BA	2,8	40	14.141.626	PA	0,4	3	8.120.131	RS	10,7	116	10.882.965
CE	6,9	61	8.794.957	PB	1,3	5	3.974.687	SC	8,7	66	7.610.361
DF	22,0	62	2.817.381	PE	19,0	172	9.058.931	SE	0,0	0	2.210.004
ES	7,6	29	3.833.712	PI	0,0	0	3.271.199	SP	14,7	653	44.411.238
GO	5,1	36	7.056.495	PR	19,1	219	11.444.380	TO	0,0	0	1.511.460
Brasil: 1.810 (8,9 PMP)											

Dados referentes a janeiro a julho de 2025, extraídos em 22/9/2025. Competência: julho/2025.

Dados sujeitos a alterações com base no envio ou correção futura de dados.

PMP: Partes por Milhão da População, referente ao ano de 2022 (203.080.756 milhões), segundo o IBGE.

Fonte: Sistema Informatizado do Ministério da Saúde - SIG/SP/SNT/Centrais Estaduais de Transplantes (CET).

Em 2025, de janeiro a agosto, o **índice de doador de órgãos por milhão de população (PMP)**, alcançou 13,0 doadores PMP (2.638 doadores), representando 56,77% da meta prevista, conforme dados extraídos em 08/09/2025, a partir do Sistema de Informação e Gerenciamento de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes (SIG/SNT). Para calcular o índice PMP, utilizou-se a população referente ao ano de 2022, de 203.080.756 milhões, do IBGE.

A meta tem como objetivo ampliar o índice de doadores de órgãos para um milhão de população, promovendo o aumento do número de doadores efetivos no país. Seu alcance é essencial para a redução da lista de espera por transplantes. O número de notificações de morte encefálica no mesmo período foi de 10.366, o que mostra o potencial de doação no país. O desafio é efetivar a doação desses potenciais doadores.

Em 2025, o Brasil registrou um total de 2.638 doadores de órgãos. A distribuição regional foi a seguinte: Sudeste: 1.129 doadores (13,3 por milhão de habitantes), representando 43% do total nacional. Sul: 669 doadores (22,3 por milhão de habitantes), representando 25% do total nacional. Nordeste: 596 doadores (10,9 por milhão de habitantes), representando 23% do total nacional. Centro-Oeste: 153 doadores (9,4 por milhão de habitantes), representando 6% do total nacional. Norte: 91 doadores (5,2 por milhão de habitantes), representando 3% do total nacional. Observa-se disparidade na capacidade de conversão de potenciais doadores em doadores efetivos entre os estados, alguns alcançando resultados comparáveis aos melhores países do mundo, enquanto outros enfrentam grandes desafios. A diferença no número de doadores efetivos entre as regiões do Brasil pode ser atribuída a diversos fatores, como a infraestrutura de saúde e a disponibilidade de serviços especializados, com variação significativa entre as regiões, o que impacta diretamente no processo de doação.

Regiões com maior concentração de centros de transplante e unidades de terapia intensiva, como as regiões Sul e Sudeste, tendem a ter números mais elevados de doadores, devido à maior capilaridade do sistema de saúde e à capacitação de profissionais para identificação de potenciais doadores. Em contrapartida, em regiões como o Norte e o Nordeste, a escassez de recursos, a distância entre os centros de saúde e a falta de formação adequada podem dificultar a identificação de potenciais doadores, levando a uma subnotificação e, consequentemente, a um número menor de doadores efetivos. Além disso, fatores culturais e de conscientização sobre a importância da doação de órgãos também influenciam essa diferença. Esse panorama reforça a necessidade de investimentos estruturantes e ações regionalizadas para fortalecer uma política de doação na região. A seguir são apresentados os dados por UF:

Índice de doador de órgãos por milhão de população (PMP), por UF											
UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População	UF	Índice (pmp)	Número de Transplante	População
AC	6,0	5	830.018	MA	8,8	52	6.776.699	RJ	15,3	245	16.055.174
AL	10,2	32	3.127.683	MG	7,7	198	20.539.989	RN	7,0	23	3.302.729
AM	4,3	17	3.941.613	MS	9,6	44	2.757.013	RO	20,9	33	1.581.196
AP	0,0	0	733.759	MT	16,0	7	3.658.649	RR	0,0	0	636.707
BA	9,1	128	14.141.626	PA	1,9	30	8.120.131	RS	13,6	148	10.882.965
CE	16,9	149	8.794.957	PB	3,7	27	3.974.687	SC	30,0	228	7.610.361
DF	14,2	40	2.817.381	PE	6,8	121	9.058.931	SE	13,1	29	2.210.004
ES	13,8	53	3.833.712	PI	13,4	35	3.271.199	SP	14,3	633	44.411.238
GO	8,8	62	7.056.495	PR	10,7	293	11.444.380	TO	4,0	6	1.511.460
Brasil: 2.638 (13,0 PMP)											

Dados referentes a janeiro a agosto de 2025, extraídos em 8/9/2025. Competência: agosto/2025.

Dados sujeitos a alterações com base no envio ou correção futura de dados.

PMP: Partes por Milhão da População, referente ao ano de 2022 (203.080.756 milhões), segundo o IBGE.

Fonte: Sistema Informatizado do Ministério da Saúde - SIG/SP/SNT/Centrals Estaduais de Transplantes (CET).

Até agosto de 2025, 60% (3.345 dos 5.570) dos **municípios implantaram o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (Mira)**. Esse quantitativo se refere aos municípios que possuem estabelecimentos definidos como reguladores ou executantes no fluxo da regulação assistencial, sob gestão municipal, no Sistema de Regulação (Sisreg) ou nos sistemas próprios, e que já estão integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Cumpre esclarecer que os referidos municípios compartilham

apenas as informações inseridas no Sisreg, ou em sistemas próprios, com a RNDS, não abrangendo necessariamente a totalidade dos dados relacionados à regulação assistencial. Destaca-se ainda que neste período, 52 sistemas de regulação assistencial estavam integrados à RNDS. Além disso, 139 municípios do país haviam implantado o E-SUS Regulação, sistema que possui integração nativa à RNDS, desenvolvido em substituição ao Sisreg.

Até julho de 2025, tem-se que 43% das **regiões de saúde apresentam oferta de serviços de reabilitação financiados pelo Ministério da Saúde**, um alcance de 87,8% da meta prevista para 2025. É importante destacar que em 2025 houve a atualização do quantitativo total de regiões de saúde vigentes no país, que passaram de 433 para 439 regiões de saúde, conforme dados do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa (Dgip/SE/MS), disponíveis no painel: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES/SEIDIGI_DEMAS_MACRORREGIOES.html.

Os serviços de reabilitação mencionados incluem os 324 Centros Especializados em Reabilitação (CER), que são unidades ambulatoriais que realizam diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se como referência para a Rede de Atenção à Saúde no atendimento de reabilitação nas modalidades auditiva, física, intelectual e/ou visual; e as 49 Oficinas Ortopédicas, que são serviços que realizam a confecção, adaptação, manutenção e dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) não cirúrgicos. Mesmo com a desabilitação de um CER e uma Oficina Ortopédica no mês de julho de 2025, as regiões de saúde abrangidas por esses serviços permaneceram cobertas por outros serviços de reabilitação, não havendo, portanto, redução na cobertura. Para o alcance da meta o Ministério da Saúde tem prestado apoio no processo de gestão, planejamento, execução, financiamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), bem como tem realizado articulação interfederativa, visando orientar e apoiar, no âmbito de suas competências, os gestores e profissionais de saúde quanto à conclusão de obras, aquisição de equipamentos, implantação e funcionamento dos serviços de reabilitação.

Com relação à distribuição regional, observa-se que as Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte se encontram, de forma geral, acima da média nacional, por outro lado, individualmente, os estados do AC, AM, BA, GO, MA, MG, MT, PE, PI, PR, SC, SE e TO encontram-se abaixo da média nacional. A seguir são apresentados os dados regionalizados por UF:

Percentual de regiões de saúde com oferta de serviços de reabilitação financiados pelo Ministério da Saúde					
AC	33%	MA	32%	RJ	67%
AL	70%	MG	33%	RN	88%
AM	22%	MS	67%	RO	86%
AP	67%	MT	38%	RR	100%
BA	39%	PA	62%	RS	43%
CE	80%	PB	56%	SC	35%
DF	100%	PE	33%	SE	29%
ES	100%	PI	42%	SP	47%
GO	39%	PR	14%	TO	38%
Brasil: 43%					

Fonte: CGSPD/Daet/Saes/MS. Dados apurados em 11/08/2025. Competência: julho/2025.

No período de janeiro a junho de 2025, foi registrado um total de 1.647.956 **coletas de sangue no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)**. Informa-se que os dados referentes aos meses de julho e agosto ainda estão em fase de consolidação no sistema SIA/SUS, sendo alimentados progressivamente pelos serviços de hemoterapia dos estados.

Para reforçar as ações de incentivo à doação, no dia 14 de junho o MS lançou a Campanha Nacional de Doação Voluntária de Sangue 2025. A campanha está sendo veiculada nos principais meios de comunicação (TV, rádio, internet e redes sociais), com foco em alcançar a população em todo o território nacional. Está prevista também a capacitação de profissionais de saúde, com foco na promoção

da doação voluntária e na aplicação dos princípios que regem o uso racional do sangue, bem como a revisão do Guia para o Uso de Hemocomponentes, com a inclusão de um novo capítulo dedicado ao uso racional do sangue.

De janeiro a agosto de 2025, foi alcançado o percentual médio de 64,05% **de recém-nascidos vivos com coleta do teste do pezinho até o 5º dia de vida**. Neste período, as regiões Sul e Sudeste alcançaram um percentual de 77,70% e 76,18%, respectivamente, influenciando positivamente o resultado nacional. As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste alcançaram percentuais de 52,72%, 52,20% e 44,64%, respectivamente. Destaca-se que o Distrito Federal, que geralmente apresenta histórico acima das metas estabelecidas, encaminhou dados apenas para o mês de julho, impactando negativamente tanto os resultados da região Centro-Oeste quanto os resultados nacionais. No segundo quadrimestre de 2025, foi realizada campanha nacional sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal com ênfase no período de coleta preconizado, na importância do responsável pelo recém-nascido buscar o resultado do exame na unidade de saúde, e no tratamento oferecido pelo SUS para as crianças diagnosticadas pelo Programa.

De janeiro a junho de 2025, **a cobertura do exame Doppler Transcraniano para crianças com doença falciforme aos 2 anos de idade** atingiu 3,06%. Os estados que realizaram o exame, e suas respectivas coberturas, foram BA (5,84%), GO (15%), PA (7,14%), PI (14,29%), RS (57,14%) e SP (1,69%). Para os demais estados, não houve registros no SIA/SUS até 30/06/2025. Importante ressaltar que o SIA/SUS tem um atraso de pelo menos dois meses.

Problemas de registro, falta de regularidade na oferta, atraso no processamento dos sistemas e falha operacional na execução dos exames têm ocasionado uma queda no quantitativo de exames. Como ação para o alcance da meta, o MS tem realizado visitas de apoio técnico aos estados. Até agosto de 2025, foram realizadas visitas aos estados de ES, MA, RS, RN e BA (essa última realizada no formato de reunião virtual). Também foram encaminhados ofícios para estados que registraram queda ou ausência de produção do exame.

Além disso, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, celebrado em 19 de junho, o MS veiculou, em suas redes sociais, peças informativas com ênfase na importância do exame ecodoppler transcraniano. As publicações tiveram como objetivo orientar profissionais de saúde, usuários do SUS e a população em geral, promovendo maior visibilidade às ações de cuidado integral à criança com doença falciforme.

De janeiro a junho 2025, foram realizados 32.773 **exames diagnósticos para doenças raras e condições genéticas crônicas e complexas**, o que representa 50% da meta prevista para 2025. Em razão do período de avaliação das Autorizações de Procedimento Ambulatorial - APACs geradas pelas unidades, só se encontra disponível a produção desse período no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).

De janeiro a junho de 2025, foram realizados 17.386 **procedimentos na atenção especializada à saúde previstos para a população trans**, sendo 193 procedimentos hospitalares e 17.193 ambulatoriais. Os procedimentos para a população trans estão previstos na Portaria n.º 2.803, de 19 de novembro de 2013 (compilada na Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017), que redefine e amplia o Processo Transsexualizador no SUS, e que se encontra em revisão. Atualmente existem 11 estabelecimentos habilitados na modalidade hospitalar e 23 estabelecimentos na modalidade ambulatorial, sendo que a iniciativa para solicitar a habilitação é do gestor estadual ou municipal, a partir de aprovação em CIB.

Até agosto de 2025, **a cobertura populacional do SAMU 192** alcançou 88,71% (189.236.038 habitantes), correspondendo a 98,5% da meta estabelecida para o ano. Esse cálculo da cobertura populacional foi realizado com base na Estimativa Populacional do IBGE de 2021, que aponta 213.317.639 habitantes. Atualmente o vazio assistencial é de 1.357 municípios sem acesso ao SAMU 192, com uma população descoberta de 24.081.601 (11,29%) brasileiros. Das 120 macrorregiões do país, quatro estão sem cobertura do SAMU-192, 54 com cobertura parcial e 62 com cobertura total. O estado de Bahia apresentou evolução na cobertura do serviço atingindo uma cobertura de 93,92%. Das 27 unidades federativas, o panorama geral mostra que 11 têm cobertura total e 16 têm cobertura parcial, sendo que apenas seis dessas UF possuem menos de 70% de cobertura.

Com o objetivo de impulsionar o alcance da meta estabelecida, estão sendo realizadas ações estratégicas para expandir a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Entre

elas, destacam-se a ampliação do número das Centrais de Regulação das Urgências (CRU), visando estruturar e ampliar a capacidade de coordenar e regular o atendimento de urgência e emergência médica em regiões vulneráveis ou sem cobertura do SAMU, e a expansão da frota de ambulâncias do SAMU 192. Essas ações visam reduzir os vazios assistenciais e universalizar o acesso ao serviço no país para a melhoria do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para a população. Para tanto, o Ministério da Saúde (MS) priorizou o financiamento da construção de CRU, em regiões sem cobertura ou com cobertura parcial do SAMU, com os recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), totalizando 14 propostas de construção, em 14 municípios, abrangendo oito Unidades da Federação: Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia.

O processo de aquisição de ambulâncias é realizado pelo Ministério da Saúde por meio de compra centralizada, que realiza a doação das ambulâncias aos entes federados subnacionais selecionados. Na 1ª Etapa do Novo PAC Seleção, realizada em 2024, foram selecionadas 350 ambulâncias, contemplando 224 municípios e 14 Unidades da Federação. Destas, 160 propostas foram efetivamente formalizadas, resultando na entrega de 256 ambulâncias (227 Unidades de Suporte Básico – USB e 29 Unidades de Suporte Avançado – USA). Além dessas, também foram entregues 58 ambulâncias provenientes de demandas anteriores registradas no Saips, totalizando ao final 314 veículos entregues (228 USB e 86 USA). Ressalta-se que essas aquisições foram viabilizadas por meio do Edital 150/2023, finalizado em julho de 2025. Estima-se que essa entrega represente uma ampliação da cobertura populacional de aproximadamente 6,3 milhões de pessoas, o que corresponde a um incremento de 2,98% na cobertura nacional do SAMU 192. A seguir apresenta-se os dados por região e UF:

Percentual de Cobertura Populacional do SAMU 192, por UF									
	% de Cobertura	População Coberta		% de Cobertura	População Coberta		% de Cobertura	População Coberta	
AC	100%	906.876	MA	63,29%	4.527.042	RJ	87,49%	15.278.026	
AL	100%	3.365.351	MG	86,34%	19.130.353	RN	84,22%	2.999.068	
AM	65,32%	2.789.325	MS	67,26%	1.909.526	RO	45,89%	832.955	
AP	73,74%	647.165	MT	58,05%	2.070.747	RR	100,0%	652.713	
BA	93,92%	14.073.442	PA	88,55%	7.772.041	RS	93,36%	10.728.476	
CE	100%	9.240.580	PB	100%	4.059.905	SC	100%	7.338.473	
DF	100%	3.094.325	PE	88,33%	8.545.729	SE	100%	2.338.474	
ES	100%	4.108.508	PI	85,82%	2.822.867	SP	86,22%	40.185.872	
GO	100%	7.206.589	PR	100%	11.597.484	TO	60,83%	977.828	
Brasil				88,71%	189.236.038				

Fonte: Cgurg/Dahu/Saes/MS. Dados apurados em 08/09/2025. Competência agosto/2025.

O Programa Mais Acesso a Especialistas (Pmae) tem como foco a **realização das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), previstas nos Planos de Ação Regional (PAR)** aprovados. Esse componente integra, desde 2025, o Programa Agora Tem Especialistas – Componente Ambulatorial, instituído pela Portaria GM/MS n.º 7.266/2025, e se consolida como estratégia estruturante da Política Nacional de Atenção Especializada, instituída pela Portaria GM/MS n.º 1.604/2023. As OCI são definidas como conjuntos organizados de ações e serviços especializados que abrangem consultas, exames e procedimentos em linhas de cuidado prioritárias, garantindo o acesso integral e continuado, desde o diagnóstico até o acompanhamento. Financiadas especificamente pelo Ministério da Saúde e vinculadas aos estabelecimentos habilitados no CNES sob o código 38.01, possuem cesta mínima de procedimentos obrigatórios e adicionais ajustados às demandas reprimidas. Sua execução deve ser registrada nos sistemas oficiais do SUS, como SIA, SISCAN e RNDS, possibilitando monitoramento, avaliação e prestação de contas.

No período de janeiro a junho de 2025, foram realizadas 115.412 Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), o que corresponde a 0,97% do total de 11.921.904 OCI previstas nos Planos de Ação Regional (PAR). Nesse período constatou-se que o desempenho do indicador permanece aquém do necessário para o cumprimento da meta. O dado, extraído em 15/09/2025, baseia-se em registros de 15 unidades federativas, refletindo a atuação apenas de estados que iniciaram efetivamente a operacionalização. A

análise evidenciou fragilidades importantes, entre elas falhas na importação de dados de julho, não processadas pelo TABNET/TABWIN-SIA, o que obrigou a repetição da competência de junho no relatório.

No detalhamento regional, a execução mostra cenários bastante desiguais. O Sudeste apresentou 65.495 OCI realizadas de 4.921.503 previsões (1,33%), sendo São Paulo o estado com maior volume absoluto (53.593), responsável por 81,9% da execução regional, com destaque para oftalmologia e cardiologia. O Sul registrou 15.964 procedimentos de 1.683.237 previstos (0,95%), com predominância do Rio Grande do Sul (9.477), concentrando 59,4% da produção regional. O Nordeste alcançou 25.382 de 3.259.527 (0,78%), com Pernambuco respondendo por 47,8% do total regional (12.137), especialmente em oftalmologia. O Centro-Oeste teve 5.444 de 950.977 (0,57%), puxado quase exclusivamente por Goiás, responsável por 100% da produção regional. Já o Norte apresentou apenas 3.127 de 1.106.660 (0,28%), com o Pará respondendo por 58,7% dessa execução, principalmente em ortopedia.

Do ponto de vista das especialidades, a oftalmologia concentrou 59% das OCI realizadas no país (68.141 procedimentos), seguida por cardiologia e ortopedia. Já oncologia e otorrinolaringologia tiveram participação marginal, refletindo ainda a necessidade de indução e fortalecimento da oferta. A unidade federativa com maior produção no período foi São Paulo, com 46,44% de todo o volume nacional. Em contrapartida, estados como Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal não registraram execução, o que compromete a meta nacional e evidencia falhas na regularidade do registro.

Em relação à rede habilitada para execução, em julho de 2025 havia 2.299 estabelecimentos credenciados (Código 38.01). A distribuição foi de 1.377 no Sudeste (761 em São Paulo e 392 em Minas Gerais), 445 no Nordeste (174 em Pernambuco, 70 na Paraíba e 64 no Ceará), 255 no Sul (143 no Rio Grande do Sul e 110 no Paraná), 116 no Norte (45 no Amazonas e 38 no Pará) e 106 no Centro-Oeste (101 em Goiás). Esses números mostram grande concentração em poucos estados, revelando também um descompasso entre habilitações e execução efetiva, já que regiões com maior capacidade ainda não apresentam produção registrada em escala compatível. Essa rede demonstra capacidade instalada mínima para dar início às execuções, mas insuficiente frente às metas projetadas.

Uma análise global aponta que o baixo percentual de execução se deve a vários fatores, tais como: falhas na contratualização de discussão, entraves de regulação, registros imprecisos e atrasos na reprogramação do PAR. Há ainda fragilidades nas articulações entre os entes federativos, integração digital insuficiente com a RNDS, desconhecimento das filas e prazos não cumpridos.

Para mitigar esses gargalos, estão sendo desenvolvidas as seguintes estratégias: intensificar a articulação federativa com reuniões técnicas regulares e pactos de compromisso, disponibilizar manuais e capacitações, fortalecer os Núcleos de Gestão do Cuidado (NGC) e de Apoio à Governança (NAG) para acompanhar a execução, além de investir na integração digital e auditorias periódicas dos dados; a ampliação da força de trabalho especializado, por meio de iniciativas como o Mais Médicos Especialistas, também se apresenta como medida central para garantir a realização de consultas, exames e procedimentos em tempo oportuno. Assim, a consolidação das OCI como eixo central da atenção especializada depende de ajustes imediatos. O desafio maior é transformar uma ampla rede de estabelecimentos habilitados e uma previsão robusta orçamentária em produção eficaz, capaz de reduzir desigualdades regionais e garantir que o Programa Agora Tem Especialistas cumpra sua missão estratégica no SUS.

Até dezembro de 2024, estavam habilitados 9.940 **serviços de saúde materna e infantil financiados pelo Ministério da Saúde, no âmbito da Rede Alyné**. De janeiro a agosto de 2025, não houve novas habilitações de serviços. Os gestores estaduais, municipais e do DF enviaram os Planos de Ação Regional (PAR), conforme prazos definidos pela Portaria GM/MS n.º 7.396 de 1º de julho de 2025. Os PAR encontram-se em análise pelo MS para publicação de portarias. Cumpre esclarecer que depende dos gestores a formalização das propostas de novas habilitações no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde (Saips) para subsidiar a publicação das portarias de habilitação.

Objetivo 3. Reduzir e controlar doenças e agravos passíveis de prevenção e controle, com enfoque na superação das desigualdades de acesso, regionais, sociais, de raça/etnia e gênero

Este objetivo trata de processos contínuos e sistemáticos de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à vigilância em saúde e ambiente, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, bem como a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

Quadro 34 – Resultados PAS: Objetivo 3 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Alcançar, pelo menos, 30% de municípios utilizando as declarações eletrônicas de nascido vivo ou de óbito até 2027. ²⁵	Percentual de municípios utilizando as declarações eletrônicas de nascido vivo ou de óbito.	Percentual	1%	0 ²⁶	20YJ (000A) 20YJ (000P)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
2. Ampliar o número de exames/ano realizados pela Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP).	Número de exames/ano realizados pela RNLSP.	Unidade	13.347.405	7.148.201	20YE (0001) 20YJ (000T) 20YJ (000U)	SVSA/MS Laboratórios de Referência Nacional, Estadual e Municipal
3. Aumentar o índice composto de redução da carga de HIV/aids, TB, HCV, HBV e sífilis congênita.	Índice composto de HIV/aids, TB, HCV, HBV e sífilis congênita.	Unidade	≥ 2	3 ²⁷	4370 (0001)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
4. Implantar a vigilância epidemiológica das micoses endêmicas nas UF.	Número de unidades federadas com a vigilância epidemiológica das micoses endêmicas implantada.	Unidade	12	9	20YJ (0001)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
5. Reduzir o número de casos autóctones de malária na Região Amazônica.	Número absoluto de casos autóctones de malária na Região Amazônica.	Unidade	76.200	63.310	20YJ (000M)	SVSA/MS Estados, Municípios e DSEI
6. Reduzir a taxa de incidência média de arboviroses (dengue, chikungunya, Zika e febre amarela) no Brasil.	Taxa de incidência média de arboviroses nos últimos 5 anos.	1 caso/ 100 mil hab.	1.093,4/ 100 mil hab.	1.165,69/ 100 mil hab. ²⁸	20AL (0003)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios

²⁵ Percentual do enunciado da meta foi reduzido de 45% para 30% durante revisão do PPA em função do atraso na disponibilização do sistema e-SUS Declarações.

²⁶ O sistema e-SUS Declarações ainda não foi disponibilizado para que os municípios pudessem iniciar a inserção das declarações eletrônicas de nascido vivo ou de óbito. A previsão foi adiada para o primeiro semestre de 2026.

²⁷ Após a apuração de julho, o índice composto para a competência de 2024 está em três pontos, mas poderá sofrer oscilações à proporção que os indicadores forem sendo apurados ao longo do ano.

²⁸ Dado referente ao período dos últimos 5 anos (2021 a 2025).

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
7. Aumentar o índice composto de eliminação como problema de saúde pública das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) - raiva, doença de chagas, leishmaniose visceral, esquistossomose e hanseníase.	Índice composto de raiva, doença de chagas, leishmaniose visceral, esquistossomose e hanseníase.	Unidade	≥2	2	20YJ (0002)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
8. Ampliar a capacidade de enfrentamento às emergências em saúde pública por meio de ações de preparação, vigilância e resposta nas unidades federadas. ²⁹	Percentual de conclusão da estratégia de fortalecimento das capacidades das unidades federativas no enfrentamento às Emergências em Saúde Pública	Percentual	46,4%	33,6%	20YJ (000Q)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
9. Ampliar o percentual de municípios com cobertura adequada (95%) das vacinas: penta (DTP/HepB/Hib) - PENTA; polio injetável - VIP; e pneumo 10 - VPC10, sarampo, caxumba, rubéola - SCR, em crianças de até 1 ano de idade.	Percentual de municípios com cobertura adequada (95%) das vacinas: penta (DTP/HepB/Hib); polio injetável - VIP; e pneumo 10 - VPC10, sarampo, caxumba, rubéola - SCR, em crianças de até 1 ano de idade.	Percentual	50%	17,7%	20YE (0002)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
10. Distribuir imunobiológicos aos estados de acordo com a demanda estimada.	Percentual de imunobiológicos distribuídos aos estados de acordo com a demanda estimada.	Percentual	100%	69%	20YE (0002)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
11. Ampliar o percentual de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) regionais e municipais com atuação satisfatória.	Percentual de Cerest com atuação satisfatória.	Percentual	70 %	55,5 ³⁰ %	20YJ (000B)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios
12. Alcançar a implantação da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) em todos os municípios prioritários.	Percentual de municípios prioritários com Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) implantada.	Percentual	60%	30,7%	20YJ (000B)	SVSA/MS Estados, DF e Municípios

²⁹ Meta incluída em substituição a meta "Identificar, nas regiões de saúde, a cobertura dos serviços de CIEVS, RENAHEV, VIGIDESASTRES e profissionais capacitados no EPISUS Fundamental" que, em 2024, superou o esperado para o final do Plano.

³⁰ Os dados apresentados possuem caráter preliminar e refletem a situação apurada até junho de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
13. Desenvolver pesquisas científicas com enfoque epidemiológico e genético para entender os determinantes sociais, fatores condicionantes, raciais/étnicos, de deficiência e de gênero que influenciam a ocorrência e a disseminação de doenças e agravos.	Número de pesquisa científica com enfoque epidemiológico e genético iniciada.	Unidade	25	6 ³¹	20QF (0001)	IEC/SVSA/MS
14. Realizar estudos sobre determinantes ambientais da saúde: mudanças do clima, poluição e biodiversidade.	Percentual de execução das ações de produção de conhecimento planejadas.	Percentual	40%	0 ³²	8327	Fiocruz/MS
15. Estratificar os municípios brasileiros por meio do uso de dados epidemiológicos, entomológicos, socioambientais, visando identificar regiões prioritárias para intervenção das arboviroses.	Percentual de estratificações de risco socioambiental, epidemiológica e entomológica realizadas.	Percentual	40%	0 ³³	8327	Fiocruz/MS
16. Ampliar as fiscalizações ou inspeções de conformidade para reduzir a oferta de produtos fumígenos irregulares.	Número de fiscalizações e inspeções de conformidade dos produtos realizadas.	Unidade	7	7	8719	Anvisa

³¹ Em 2025, seis pesquisas foram iniciadas em: uma em fevereiro, uma em março, duas em maio, uma em julho e uma em agosto.

³² Em 2024, o foco dos trabalhos da Fiocruz foi na criação e operação do Centro de Síntese sobre mudanças do clima, poluição e biodiversidade como principal iniciativa voltada para produzir conhecimento sobre determinantes ambientais da saúde. Em 2025 ainda não foram iniciadas novas atividades.

³³ Publicado, pela Fiocruz, um artigo científico sobre a modelagem espaço-temporal dos casos de dengue no município de Natal (RN), em parceria com profissionais da Prefeitura Municipal de Natal e ministrado curso intitulado “Estratificação de áreas de risco aplicada à Medicina Tropical”.

Informações Adicionais

Este objetivo possui 16 metas, sendo 13 monitoradas pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), duas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e uma pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa). Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, divididos em cinco intervalos percentuais, considerando as previsões para o final do exercício de 2025 (PAS). Ressalta-se que esse resultado reflete as políticas públicas executadas de forma ampla, ou seja, aquelas que envolvem os esforços de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	4	25,00%
Acima de 25 até 50%	1	6,25%
Acima de 50% até 75%	5	31,25%
Acima de 75% até 100%	4	25,00%
Acima de 100%	2	12,50%
Total	16	100,00%

O sistema e-SUS é uma plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Brasil que visa otimizar o registro de informações de saúde, incluindo as **declarações de nascido vivo e de óbito**. Essa plataforma visa modernizar os atuais sistemas de informação da linha da vida por meio de uma plataforma on-line, desenvolvidos em novas e seguras tecnologias, como a disponibilização dos formulários eletrônicos da Declaração de Nascido Vivo e da Declaração de Óbito e das notificações on-line de doenças e agravos de notificação compulsória. Entretanto, o sistema e-SUS Declarações ainda não está disponível para que os municípios possam iniciar a inserção das declarações eletrônicas de nascido vivo ou de óbito. Até o momento foram executados dois ciclos de homologação do sistema, contudo, devido a adequações nos fluxos de trabalho e às distintas realidades dos entes federados para migração on-line, será necessário mais um ciclo de homologação nas cinco regiões em 2025. A expectativa é disponibilizar o sistema no primeiro semestre de 2026.

O **número de exames laboratoriais realizados ao ano pela RNLSP** é um indicador que mede a capacidade de diagnóstico de doenças de notificação compulsória, permitindo a redução do tempo da resposta aos pacientes, com consequente diminuição da morbimortalidade, especialmente àquelas causadas pelas doenças infecciosas, e principalmente em regiões isoladas e promovendo o aumento da capacidade resolutiva (maior número de respostas no menor tempo possível) dos Laboratórios Públicos Estaduais e Municipais potencializando de forma transversal a saúde da população.

Entre janeiro e agosto de 2025 foram realizados 7.148.201 exames diagnóstico para doenças e agravos de acordo com dados retirados do sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), abrangendo todas as metodologias de diagnóstico e agravos dos LACEN.

Número de exames/ano realizados pela RNLSP, por UF. (janeiro a agosto de 2025)					
AC	162.297	MA	86.761	RJ	521.463
AL	32.064	MG	455.712	RN	239.159
AM	149.283	MS	306.652	RO	334.715
AP	51.453	MT	129.841	RR	61.118
BA	1.615.406	PA	113.224	RS	145.287
CE	200.518	PB	89.734	SC	308.808
DF	64.110	PE	174.919	SE	244.034
ES	373.826	PI	164.049	SP	633.904
GO	203.612	PR	250.920	TO	35.332
Brasil: 7.148.201					

Fonte: SVSA/MS.

O **índice composto de redução de carga viral** mensura conjuntamente a carga do HIV/aids, TB (tuberculose), HCV (vírus da hepatite C), HBV (vírus da hepatite B) e sífilis congênita no país. A diminuição dessa carga é fundamental para o alcance das metas de eliminação dessas doenças de determinação social. Quanto mais doenças reduzirem a incidência, maior o índice, e menor a carga dessas doenças.

O índice pode variar de zero a seis pontos, e é calculado somando-se um ponto se:

1. Há diminuição de 0,1 caso, por 1.000 nascidos vivos, na taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano analisado na comparação do ano com o ano anterior (aferição prevista para outubro de 2025);
2. Há diminuição de 0,1 caso, por 100.000 habitantes, na taxa de detecção de aids em menores de 5 anos na comparação do ano analisado com o ano anterior (aferição prevista para dezembro de 2025);
3. Taxa de detecção de hepatite B em crianças de 0 a 5 anos, por 100.000 habitantes, no ano analisado, é menor do que 0,5 (aferido em julho de 2025 – o indicador não pontuou);
4. Há diminuição de 1% em 2024 comparado com 2023, 2% em 2025 comparado com 2024, 3% em 2026 comparado com 2025, 4% em 2027 comparado com 2026 do coeficiente de incidência da tuberculose (aferido em março de 2025);
5. Taxa de detecção de aids em adultos maiores de 13 anos é menor do que 22 por 100.000 habitantes no ano analisado (aferição prevista para dezembro de 2025); e
6. Proporção de pessoas tratadas para hepatite C é maior que 90% dos casos detectados de hepatite C no ano analisado (aferido em julho de 2025).

Seguindo a programação de apuração dos indicadores, em julho de 2025, foram atualizados os seguintes indicadores: Taxa de detecção de hepatite B em crianças de 0 a 5 anos - de 2023 para 2024 houve um aumento de 0,3 para 0,7, portanto, não atingiu a meta e o indicador não pontuou; Coeficiente de incidência de tuberculose - de 2023 para 2024 houve um aumento de 1% (40,0 para 40,3 casos novos de TB/100 mil habitantes). Considerando a meta de diminuir em 1% no coeficiente de incidência de tuberculose em 2024 comparado com 2023, o indicador também não pontuou o índice composto; Razão entre o número de pessoas tratadas para hepatite C e o número de pessoas com carga viral detectável para hepatite C no ano analisado - 63%. Considerando a meta de a proporção de pessoas tratadas para hepatite C ser maior que 90% daqueles com carga viral detectável (diagnosticados), o indicador também não pontuou o índice composto.

Os três indicadores a seguir permanecem com a pontuação do ano anterior e ainda serão atualizados, seguindo cronograma: Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano por 1.000 nascidos vivos: em 2023, a taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano foi 9,9 casos por 1.000 nascidos vivos. Considerando que em 2022, a taxa foi de 10,3 casos por 1.000 nascidos vivos, houve uma redução de 0,4 casos por 1.000 nascidos vivos, pontuando, portanto, um ponto no índice composto; Taxa de detecção de aids em menores de 5 anos por 100.000 habitantes: em 2023, a taxa de detecção de aids em menores de 5 anos foi de 1,2 casos por 100.000 habitantes, 0,3 casos a menos que em 2022 (1,2 casos por 100.000 habitantes) e, portanto, pontuou um ponto no índice composto; Taxa de detecção de aids em adultos maiores de 13 anos por 100.000 habitantes: em 2023, a taxa de detecção de aids em adultos maiores de 13 anos foi de 21,5 casos por 100.000 habitantes, ficando menor do que 22 por 100.000 habitantes e, também, pontuando um ponto no índice composto. Dessa forma, o índice composto para a competência de 2024 está em três pontos, mas poderá sofrer oscilações à proporção que os indicadores forem sendo apurados ao longo do ano.

A **implantação da vigilância epidemiológica das micoses endêmicas** nas UF permitirá o conhecimento acerca da sua estruturação no país, de forma a ter dados relativos à sua distribuição e magnitude, subsidiando a formulação de políticas públicas para o seu controle. As micoses endêmicas abrangem um conjunto de infecções causadas por fungos, como aspergilose, candidíase sistêmica, coccidioidomicose, criptococose, cromoblastomicose, esporotricose humana, feohifomicose, fusariose, histoplasmoze, micetomas, mucormisose (fungo negro), paracoccidioidomicose e tricosporonose.

Considera-se vigilância epidemiológica das micoses endêmicas implantada em uma determinada unidade federada, quando tiverem sido atendidos os seguintes critérios:

1. Treinamento dos profissionais para a implantação da vigilância epidemiológica das micoses endêmicas (25%);
2. Pelo menos 1 (um) município realizando solicitação de medicamentos antifúngicos pelo sistema Micosis (25%);
3. Pelo menos 1 (um) serviço de saúde do estado estiver solicitando anfotericina lipossomal para o tratamento de neurocriptococose (25%); e
4. Pelo menos 1 (um) município estiver realizando notificação de casos de esporotricose no sistema após ser incluída como notificação compulsória (25%).

Entre os meses de janeiro e agosto de 2025, a implantação da vigilância das micoses endêmicas e oportunistas ocorreu nos estados de Rio de Janeiro, Ceará, Roraima, Rondônia, Pará e Goiás. Com a publicação da Portaria GM/MS n.º 6.734, de 18 de março de 2025 a esporotricose humana foi incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, alcançando assim uma das entregas intermediárias desta meta. Portanto, considerando o ano de 2024 até o presente ciclo de monitoramento, a implantação da vigilância das micoses endêmicas e oportunistas já ocorreu em nove Unidades Federadas (PR, SP, MS, RJ, CE, RR, PA, GO e RO)

Sobre a **malária**, dados preliminares apontam que, no período de janeiro a julho de 2025, o Brasil registrou 63.310 casos autóctones (com transmissão local) de malária, uma redução de 23% no número de casos autóctones de malária no país, em relação ao mesmo período de 2024. Destes casos, 10.647 foram provocados por *P. falciparum*, forma mais grave da doença, uma redução de 35,9% em relação ao ano anterior.

Ao analisar os dados de malária por estado da Região Amazônica no período, é possível identificar uma redução do número de casos nos estados do Acre (passando de 2.664 para 2.299, -13,7%), Amazonas (passando de 37.677 para 34.232, -9,1%), Amapá (passando de 2.553 para 2.064, -19,2%), Pará (passando de 13.463 para 8.794, -34,7%), Rondônia (de 4.707 para 3.229, -31,4%), Roraima (de 20.462 para 12.286, -40,0%), Maranhão (passando de 21 para 17 casos, -19,0%) e Mato Grosso (passando de 746 para 378 casos, -49,3%). O estado do Tocantins não registrou casos autóctones em 2025, tendo registrado um caso autóctone no período até julho de 2024. Na Região Extra-Amazônica, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul apresentaram casos autóctones da doença até julho de 2025. Em relação às áreas consideradas especiais na Região Amazônica, de acordo com dados preliminares, de janeiro a julho de 2025 tem sido observada redução no número de casos autóctones de malária em todas as áreas especiais em relação ao mesmo período de 2024. Nas áreas indígenas a redução é de -19,9% (de 37.155 para 29.773), nas áreas de assentamento de -25,2% (de 3.682 para 2.755), nas áreas de garimpo de -39,1% (de 9.083 para 5.533), nas áreas rurais de -20,9% (de 26.663 para 21.087) e nas áreas urbanas de -27,0% (de 5.260 para 3.838).

Atribui-se a redução, neste primeiro trimestre de 2025, ao impacto positivo das ações e novas tecnologias implementadas em 2024. A expansão da utilização da tafenoquina como esquema de tratamento para cura radical de malária por *P. vivax* tem se mostrado eficaz. Além disso, o restabelecimento da distribuição dos Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração (MILD) tem possibilitado ampliação das ações de controle vetorial bem como da cobertura das localidades com esta estratégia. Ademais, o uso do Artesunato Mefloquina tem trazido impactos positivos no controle da malária por *P. falciparum*. Nas terras Yanomami, ações do poder público que forcem a migração da população garimpeira dessas áreas ainda impacta na redução dos casos nas áreas de garimpo.

Os dados de 2025 estão sujeitos a alterações. Deve-se levar em consideração que há um atraso de um mês para apresentação de dados mais fidedignos no sistema, podendo chegar a dois meses nas áreas indígenas, devido à dificuldade de acesso. Assim, dados até julho são considerados preliminares.

Número absoluto de casos autóctones de malária, por UF. (janeiro a julho de 2025)					
AC	2.299	MA	17	RJ	1
AL	0	MG	0	RN	0
AM	34.232	MS	1	RO	3.229
AP	2.064	MT	378	RR	12.286
BA	0	PA	8.794	RS	2

Número absoluto de casos autóctones de malária, por UF. (janeiro a julho de 2025)					
CE	2	PB	0	SC	1
DF	0	PE	1	SE	0
ES	0	PI	0	SP	2
GO	1	PR	0	TO	0
Brasil: 63.310					

Fonte: SVSA/MS.

Com relação às **arboviroses**, a taxa de incidência média nos últimos 5 anos (2021-2025) está em 1.165,69 casos por 100 mil habitantes, fortemente influenciada pela maior epidemia de dengue da história ocorrida em 2023.

Desde o segundo semestre de 2024, o Ministério da Saúde passou a monitorar a situação por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com foco no “Plano de Ação para redução da dengue e de outras arboviroses – Período sazonal 2024/2025”. O plano está organizado em seis eixos de ação: 1- prevenção; 2- vigilância; 3- controle vetorial; 4- organização da rede assistencial e manejo clínico; 5- preparação e resposta às emergências; e, 6- comunicação e participação comunitária.

Em 2025, até a semana epidemiológica 37 (13/09), o Brasil registrou aproximadamente 1.568.893 casos prováveis de dengue e cerca de 1.609 óbitos e, com relação à chikungunya, registrou aproximadamente 119.923 casos prováveis e 110 óbitos. Embora os casos de zika tenham sido menos expressivos, com 3.739 casos prováveis até a semana epidemiológica 29 (19/07), a vigilância contínua permanece essencial.

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE Dengue) foi instituído pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS n.º 6.531, de 8 de janeiro de 2025) como uma ferramenta estratégica para monitorar e responder de forma integrada e coordenada às epidemias de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika.

O índice composto de eliminação como problema de saúde pública das **Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs)** mensura, de forma integrada, o progresso no controle ou eliminação da hanseníase, raiva humana, leishmaniose visceral, esquistossomose e doença de Chagas no Brasil. Esse índice considera múltiplos indicadores específicos para cada uma das doenças e pontua conforme o desempenho anual frente às metas estabelecidas para 2027. O indicador final expressa o avanço nacional em relação à eliminação dessas enfermidades historicamente associadas a desigualdades sociais, regionais e estruturais.

O índice pode atingir de 0 a 6 pontos e, de janeiro a agosto de 2025, foram avaliados os seguintes indicadores:

1. Proporção de municípios sem casos de hanseníase em menores de 15 anos por 5 anos consecutivos
2. Validação da Eliminação da Raiva Humana;
3. Redução de casos de Leishmaniose Visceral;
4. Diminuição da incidência de Doença de Chagas Aguda;
5. Cobertura de tratamento da Doença de Chagas Crônica; e
6. Exames Coprocópicos para Esquistossomose.

De janeiro a agosto de 2025, dois dos seis indicadores alcançaram as metas pactuadas: Hanseníase em menores de 15 anos e Redução de casos de Leishmaniose Visceral. Assim, o índice composto de eliminação das DTNs está em 2 pontos. Esse valor poderá ser ajustado ao longo do segundo semestre de 2025, conforme o recebimento de dados pendentes, especialmente relacionados à raiva, doença de Chagas e esquistossomose.

Com relação à **rede de preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública**, em dezembro de 2024, 348 (82%) dentre as 425 das regiões de saúde, contavam, simultaneamente, com os serviços da Rede de Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Rede CIEVS), da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (RENAVEH), do Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres) e com profissionais capacitados pelo EpiSUS Fundamental, superando a meta de 80% prevista para o final do Plano. Assim, a partir de 2025, como

parte de um esforço contínuo para aprimorar a capacidade nacional de enfrentamento às emergências em saúde pública, o Ministério da Saúde estruturou uma estratégia abrangente composta por cinco etapas:

1. Oficinas de Preparação, Vigilância e Resposta;
2. Simulados de Mesa;
3. Oficinas de Ativação de Estruturas de Resposta;
4. Autoavaliação de Capacidades; e
5. Vigilância Baseada em Eventos (VBE) com uso do EIOS.

Paralelamente a essas ações, se mantém uma estratégia complementar essencial para o fortalecimento nacional do enfrentamento às ESP e o alcance da meta estabelecida: a formação contínua de profissionais em epidemiologia de campo, por meio do EpiSUS, nos três níveis de formação. Em 2024, o Programa EpiSUS formou 438 profissionais nos três níveis de formação: Fundamental (374), Intermediário (50) e Avançado (14). Para 2025, a nova proposta estabeleceu como meta a formação de cerca de 300 profissionais por ano em todos os níveis de formação. Até o momento, 342 profissionais já foram capacitados nos três níveis de formação (261 no fundamental, 71 no intermediário e 10 no avançado). Essa estratégia é reconhecida como um componente complementar essencial, contribuindo significativamente para o fortalecimento das capacidades locais em vigilância em saúde pública.

Conforme dados preliminares, da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) referentes a junho de 2025, houve uma redução nos números apurados com relação ao último quadrimestre, quando 986 municípios (17,7%) atingiram a **cobertura vacinal adequada** (95%) para as vacinas pactuadas no calendário nacional. Esta aparente redução provavelmente decorre da preliminaridade dos dados. Esse percentual pode apresentar flutuações conforme os dados de cobertura vacinal no país vão sendo consolidados. As coberturas por vacina foram as seguintes:

- Tríplice Viral D1: 47,11% (2.624 municípios);
- Penta: 31,10% (1.732 municípios);
- Pneumo 10: 32,71% (1.822 municípios); e
- Poliomielite VIP: 29,03% (1.617 municípios).

O estado do Ceará registrou o maior percentual de municípios com a meta alcançada (28,26%), enquanto Acre apresentou o menor (0%). O Ministério da Saúde tem conduzido ações estratégicas com foco no aumento das coberturas tais como a implementação do Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ), realizado em 2023 pelo Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI/SVSA). A estratégia capacitou 1.237 profissionais de saúde em 18 oficinas, com foco em replicar metodologias para as 27 Unidades Federativas e os 34 distritos sanitários indígenas.

Adicionalmente, em 2024, o Ministério da Saúde implementou o Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) com o objetivo de avaliar a situação vacinal de crianças menores de 5 anos, visando resgatar e vacinar aquelas não imunizadas ou com esquema incompleto contra poliomielite e sarampo, por meio de 4 oficinas entre maio e junho, capacitando 146 gestores em 26 Unidades Federativas.

Além dessas, a Estratégia de Vacinação nas Escolas foi outra iniciativa do Ministério da Saúde, por meio do PNI e do Programa Saúde na Escola entre 1º de abril e 31 de maio de 2025 que buscou melhorar as taxas de cobertura em todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A ação incluiu checagem de cadernetas, vacinação in loco e a Semana de Intensificação da Vacinação nas Escolas, com foco em comunicação, sensibilização e microplanejamento, visando reduzir a hesitação vacinal e fortalecer a adesão de crianças e adolescentes. Ainda, a inclusão “dose zero” de sarampo (tríplice viral), voltada a crianças de 6 a 11 meses, com o objetivo de proteger precocemente crianças vulneráveis em situação de maior exposição, como regiões com alta mobilidade internacional como a COP-30, cidades turísticas, universitárias e municípios de fronteira. Esse conjunto de ações reflete os esforços contínuos para que o Brasil volte a ser referência em altas coberturas vacinais <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao>.

Por fim, observa-se desafios que ainda precisam ser superados, tais como: 1) priorização do monitoramento e combate aos grupos antivacinas e às notícias falsas sobre vacinas nas redes sociais; 2) ampliação de divulgação nos veículos de informação de massa sobre a importância do calendário de vacinação, segurança das vacinas e o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis no país; 3) aprimoramento dos currículos dos cursos de formação de profissionais na área da saúde com inclusão de

conteúdo sobre imunização e vacinação; 4) manutenção de capacitação contínua em imunização para trabalhadores da saúde, especialmente das salas de vacinas, da rede de frio e dos sistemas de informação; 5) Lançamento das campanhas de multivacinação para atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes até os 15 anos de idade.

Percentual de cobertura vacinal adequada, por UF, (janeiro a junho de 2025)					
AC	0	MA	25,81	RJ	4,35
AL	16,67	MG	18,05	RN	10,78
AM	16,1320,97	MS	12,66	RO	19,23
AP	12,525	MT	15,6	RR	6,67
BA	15,83	PA	10,42	RS	21,53
CE	28,26	PB	16,59	SC	23,39
DF	0,0	PE	17,84	SE	9,33
ES	16,67	PI	22,32	SP	13,64
GO	19,51	PR	17,04	TO	20,86
Brasil: 17,70%*					

*Dados preliminares.

Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde. Painel LocalizaSUS/DEMÁS.

A logística de vacinas em um país com as dimensões do Brasil é uma tarefa extremamente complexa, que envolve planejamento detalhado e integração entre diferentes níveis de governo. Com um território extenso e diverso, é necessário considerar variáveis como infraestrutura de transporte, armazenamento em temperaturas controladas, acesso a áreas remotas e regiões de difícil locomoção, além de eventuais desafios climáticos. Esse processo exige coordenação tripartite, com a União sendo responsável pela aquisição e distribuição nacional, os estados encarregados de distribuir para os municípios, e os municípios garantindo a aplicação na população. Essa dinâmica visa assegurar que vacinas cheguem com qualidade e segurança a todos os cidadãos, promovendo a equidade na cobertura vacinal em um país continental.

A **distribuição de imunobiológicos** do Programa Nacional de Imunizações atingiu 91% das doses solicitadas entre os meses de janeiro e agosto de 2025, enviando o total de 205.772.045 doses dos insumos analisados. Em comparação ao percentual planejado para 2025, a meta atingiu 69% no primeiro quadrimestre.

Distribuição de Imunobiológicos, por UF Janeiro a agosto de 2025					
AC	878.491	MA	7.081.740	RJ	14.482.794
AL	2.850.589	MG	24.082.393	RN	3.318.419
AM	3.924.475	MS	3.929.245	RO	1.226.046
AP	721.325	MT	3.883.072	RR	514.570
BA	14.241.017	PA	6.301.994	RS	9.631.659
CE	8.719.926	PB	4.213.074	SC	8.459.755
DF	2.769.549	PE	9.130.297	SE	2.208.262
ES	3.505.692	PI	3.373.972	SP	45.249.090
GO	6.132.724	PR	13.727.223	TO	1.174.652
Brasil: 205.772.045					

Fonte: SVSA/MS.

O Programa de **Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA)** visa à execução de ações de saúde integradas, compreendendo a promoção à saúde, a vigilância, a prevenção e o controle dos agravos e das doenças decorrentes da intoxicação exógena por agrotóxicos.

De janeiro a agosto de 2025, do total de 658 municípios prioritários, 202 (30,7%) estão com a VSPEA implantada, conforme demonstram os dados regionalizados a seguir:

- Região Norte: dos 151 municípios prioritários temos 50 municípios com VSPEA implantada: 33,1%
- Região Nordeste: dos 382 prioritários temos 113 municípios com VSPEA implantada: 29,6%
- Região Centro Oeste: dos 8 prioritários temos 0 municípios implantados: 0%
- Região Sudeste: dos 83 prioritários temos 21 municípios com VSPEA implantada: 25,3%
- Região Sul: dos 34 municípios prioritários temos 18 municípios com VSPEA implantada: 52,9%

A queda no percentual de implantação em relação ao ano de 2024, que foi de 36%, justifica-se pela alteração nas equipes de vigilância municipal. Devido às eleições de 2024, muitos municípios deixaram de responder ao formulário de acompanhamento de janeiro e março de 2025. Desse modo, o Ministério da Saúde junto aos estados tem intensificado as orientações de implantação à VSPEA para as novas equipes municipais, tanto com as assessorias presenciais quanto online e publicação de Notas Técnicas.

Objetivo 4. Promover o desenvolvimento científico e tecnológico para produção, inovação e avaliação em saúde a fim de atender a população de forma equitativa, sustentável, acessível, considerando a sociobiodiversidade territorial e contribuindo para a prosperidade econômica, social e redução da dependência de insumos para a saúde.

Este objetivo busca incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas à produção, inovação e avaliação em saúde, de forma a proporcionar a ampliação do acesso às tecnologias em saúde de forma equitativa, progressiva, racional e sustentável, contribuindo para a promoção da saúde da população e o desenvolvimento social e econômico do país. As ações de fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação em saúde assim como o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) são indispensáveis para o acesso universal, equânime e integral a tecnologias que aumentem a qualidade de vida das pessoas e assegurem o desenvolvimento produtivo e de inovação no país, permitindo, por meio de ações que visam otimizar o poder de compra do Estado, estabelecer políticas de financiamento (apoando a produção local e regional), comercial e de ciência e tecnologia.

Quadro 35 – Resultados PAS: Objetivo 4 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Ampliar o percentual de pesquisas em saúde prioritárias fomentadas.	Percentual de pesquisas prioritárias fomentadas.	Percentual	89%	80,18% ³⁴	21BF (0001) 21ED	Sectics/MS Estados
2. Ampliar o número de sequências genômicas completas de brasileiros.	Número de sequências genômicas completas geradas.	Unidade	50.000	42.014	21ED	Sectics/MS Estados
3. Ampliar o número de estudos secundários ofertados para apoiar à tomada de decisão no SUS.	Número de estudos secundários ofertados para apoiar à tomada de decisão no SUS.	Unidade	50	37	Não se aplica	Sectics/MS
4. Ampliar o número de entes federativos com novos Núcleos de Economia da Saúde implantados por região.	Número de entes federativos com novos Núcleos de Economia da Saúde implantados por região.	Unidade	5	7 ³⁵	8648	Sectics/MS Estados Municípios DF
5. Ampliar o número de projetos e instrumentos voltados para o desenvolvimento, inovação e produção local de tecnologias em saúde visando a	Número de projetos e instrumentos voltados para o desenvolvimento, inovação e produção local formalizados.	Unidade	42	25	20K7 8636	Sectics/MS

³⁴ É necessário corrigir o resultado informado no 3º RQPC e no RAG de 2024, onde se lê: 64%; leia-se 80,67%. Justifica-se a alteração uma vez que não foi contabilizada a totalidade de pesquisas prioritárias até dezembro de 2024, bem como a soma de iniciativas indevidamente, que não correspondiam à proposta do indicador.

³⁵ Em junho de 2025, constatou-se a institucionalização de um novo NES, no Estado do Mato Grosso (MT) ainda em 2024, conforme Portaria GBSSES/MT n.º 0775/2024, publicada em 21 de novembro de 2024. Dessa forma, até o momento, têm-se sete entes federativos com novos Núcleos de Economia da Saúde implantados por região.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
ampliação do acesso e o fortalecimento da soberania nacional. ³⁶						
6. Ampliar o percentual de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) submetidos à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (Conitec), em razão de incorporação de tecnologias em saúde no SUS.	Percentual de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas submetidos à Conitec.	Percentual	80%	34,78%	20K3	Sectics/MS Estados Municípios DF
7. Manter o número de projetos de pesquisa em saúde e ambiente em desenvolvimento.	Número de projetos de pesquisa em saúde e ambiente em desenvolvimento.	Unidade	2.200	1.666	21BF	Fiocruz

³⁶ A meta é composta por projetos e instrumentos formalizados para o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

Informações Adicionais

Este Objetivo possui seis metas monitoradas pela Sectics e uma pela Fiocruz. Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, divididos em cinco intervalos percentuais, considerando a previsão para o final do exercício de 2025 conforme a Programação Anual de Saúde (PAS). Ressalta-se que esse resultado reflete as políticas públicas executadas de forma ampla, ou seja, aquelas que envolvem os esforços de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	0	0,00%
Acima de 25 até 50%	1	14,28%
Acima de 50% até 75%	2	28,59%
Acima de 75% até 100%	3	42,85%
Acima de 100%	1	14,28%
Total	7	100,00%

Consideram-se **pesquisas prioritárias** aquelas cujas temáticas estejam contidas na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) e Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde (APPMS); que respondam a demandas em caráter de emergência em saúde pública; sejam definidas por Oficina de Prioridades em Pesquisa, como aquelas fomentadas por meio do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS); ou visem promover e fortalecer o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão (Genomas Brasil).

Cumpra informar que, após revisão dos dados de 2024, se faz necessário corrigir os resultados registrados previamente. Constatou-se que não haviam sido incluídos 20 projetos prioritários realizados em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). Adicionalmente, verificou-se que 50 iniciativas, contempladas pela chamada n.º 12/2024, foram contabilizadas de forma indevida, uma vez que se referem à realização de eventos de divulgação científica e não ao fomento direto de pesquisas. Desse modo, após a devida correção, até dezembro de 2024, foram fomentadas 263 pesquisas prioritárias e 326 pesquisas estratégicas, o que representa 80,67% de pesquisas prioritárias no total.

Entre os meses de janeiro e agosto de 2025, informa-se que não foram fomentadas novas pesquisas prioritárias e que duas novas pesquisas estratégicas foram fomentadas, correspondendo a 80,18% (263 prioritárias de 328 estratégicas).

Complementarmente, no âmbito do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS), foram lançadas 26 chamadas públicas em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) e as Secretarias de Estado da Saúde (SES). Essas iniciativas visam a contratação de pesquisas prioritárias e estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), alinhadas às linhas de pesquisa definidas em cada unidade federativa por meio das Oficinas de Prioridades de Pesquisa em Saúde (OPP). Apresenta-se, a seguir, a situação dos estados e DF nas fases de acompanhamento dessas 26 chamadas:

Fases de Acompanhamento das Chamadas Públicas	Estados	Total
Análise das Propostas Submetidas	AP, DF, GO, PR, RS, RJ, RR, RO, PA, AC, AM, TO, AL, SE, BA, SP e MG	17
Publicação dos Resultados das Propostas Seleccionadas	ES, PB, MT, SC, MA, PI, MS, PE e CE	9
Revisão da Minuta da Chamada	RN	1

O **Programa Genomas Brasil** tem entre suas metas estimular a geração de dados genômicos e fenotípicos da população brasileira, foco em genômica clínica (doenças raras, oncológicas, cardiovasculares e infectocontagiosas) e populacional, com a finalidade de compartilhamento responsável

dos dados para fins de pesquisa. Os dados genômicos obtidos servirão como um grande fórum de descobertas, possibilitando que estudos possam identificar as principais características genéticas da nossa população para prever e prevenir doenças, assim como para desenvolver novos tratamentos e novas estratégias de diagnóstico. Com isso, será possível gerar novos conhecimentos e tecnologias (diagnósticas e terapêuticas) com base no genoma da população brasileira, possibilitando a aceleração da translação das técnicas de saúde de precisão para a prática clínica.

Entre janeiro e agosto de 2025, 15.463 genomas completos de brasileiros foram sequenciados por meio de projetos fomentados, totalizando 42.014 genomas ao longo da execução do Plano Nacional de Saúde (2024-2027).

Registra-se, abaixo, a quantidade de genomas completos sequenciados por região.

Região	Quantidade de Genomas Completos Sequenciados
Norte	4.388
Nordeste	7.587
Centro-Oeste	1.889
Sudeste	21.988
Sul	6.162
Total	42.014

Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia – Decit/Secretaria/MS.

Estudos secundários são estudos rápidos que sintetizam evidências de forma clara e acessível, já disponíveis na literatura científica sobre um tema em questão com o intuito de facilitar o uso de evidências na tomada de decisão. Tem-se como referência o documento "Serviço de produção de evidências para apoio à tomada de decisão: portfólio de produtos".

Ao longo do desenvolvimento do PNS 2024-2027 foram ofertados 37 estudos secundários para apoiar à tomada de decisão no SUS, sendo que 20 foram elaborados entre janeiro e agosto de 2025 e estão descritos no quadro a seguir.

Período	Estudos Secundários Realizados
Janeiro	1. Revisão sistemática rápida: "Síntese de evidências sobre incorporação ou não do procedimento de recuperação intra-operatória".
	2. Levantamento bibliográfico: "Levantamento de dados sobre o impacto das variações climáticas na epidemiologia das arboviroses".
Fevereiro	3. Revisões sistemáticas: "Grupos prioritários para o tratamento com insulinas análogas de ação rápida e prolongada".
	4. Revisão sistemática rápida: "Eficácia do diafragma como método contraceptivo".
	5. Revisão sistemática rápida: "Fatores que podem influenciar a estabilidade do Misoprostol comercializado em Sistemas de Saúde".
Março	6. Revisão sistemática rápida: "Experiência global no rastreamento do câncer de pulmão".
	7. Avaliação crítica de estudo: "Charting the therapeutic landscape: a comprehensive evidence map on medical cannabis for health outcomes".
	8. Revisão de escopo rápida: "Efeitos das residências em saúde nos serviços e redes de atenção do SUS".
Abril	9. Overview de revisões sistemáticas: "Impacto das variações climáticas na epidemiologia das arboviroses".
	10. Revisão sistemática rápida: "Doenças ou condições de saúde associadas a exposição crônica de agrotóxicos".
Maio	11. Revisão sistemática rápida: "Eficácia e segurança do uso de semaglutida na redução de peso".
	12. Revisão de escopo rápida: "Dispositivos Point-of-care (PoC) utilizados na Atenção Primária à Saúde".
	13. Revisão rápida sobre a segurança do tratamento preventivo de Tuberculose em crianças de até cinco anos de idade.
	14. Revisão de Escopo sobre o tempo mínimo da reinfeção do vírus SARS-CoV-2.
Junho	15. Revisão de escopo rápida: "Abordagens para a regulamentação de substâncias químicas na água".
	16. Inventário de referências: "Métodos e desenhos de estudos de mundo real sobre a efetividade e segurança do onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®)".
Julho	17. Revisão sistemática rápida: "Métodos e desenhos de estudos de mundo real sobre a efetividade e segurança do onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®)".
Agosto	18. Revisão Sistemática Rápida: Síntese de Evidências sobre medicamento substituto terapêutico da Teclozana 500 mg para a eliminação de cistos de Entamoeba histolytica.
	19. Revisão Sistemática Rápida: "Prevenção e Controle da esporotricose felina".

Período	Estudos Secundários Realizados
	20. Revisão de Escopo Rápida: “Atribuições e critérios dos centros de vigilância em saúde baseada em eventos para resposta às emergências em saúde pública”.

Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia – Decit/Sectics/MS.

Adicionalmente, entre janeiro e agosto de 2025 foram realizadas nove pesquisas avaliativas de políticas, programas e projetos de saúde, sendo:

Período	Pesquisas Avaliativas de Políticas, Programas e Projetos de Saúde Ofertadas
Março	1. Relatório final: "Análise Ex Ante da Política de Monitoramento e Avaliação do SUS".
	2. Relatório parcial: "Revelando Caminho - Estudo de avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)".
	3. Relatório Final: “Análise de viabilidade da avaliação de impacto do Programa de Qualificação das Ações em Vigilância em Saúde (PQA-VS)”.
Abril	4. Relatório final: "Desigualdades de Sexo e Raça no Setor da Saúde: Uma análise interseccional para última década - Avaliação Ex ante do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde".
Maio	5. Relatório Final: Estudo de Avaliabilidade das ações de saneamento indígena: um olhar para a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
	6. Relatório Final Avaliação de Implementação: “Meu SUS Digital: A literacia digital e a experiência de cidadãos usuários do aplicativo e de profissionais da Atenção Primária à Saúde a partir de fatores facilitadores e inibidores da aceitação e uso da ferramenta”.
Julho	7. Relatório parcial sobre o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Prodi-SUS). Avaliação custo-benefício de políticas e programas de saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
	8. Relatório parcial sobre Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (Cebas). Avaliação custo-benefício de políticas e programas de saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
Agosto	9. Relatório final: “Análise Ex Ante da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Pnaism), com foco na Promoção a Atenção às Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Doméstica e Sexual”.

Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia – Decit/Sectics/MS.

Obs.: Foi necessária a adequação das pesquisas avaliativas informadas no 1º RQPC de 2025, devido a uma nova verificação dos dados.

Complementarmente, informa-se que foram realizadas 54 iniciativas de disseminação de evidências em saúde entre 2024 e 2025, sendo 33 entre janeiro e agosto de 2025.

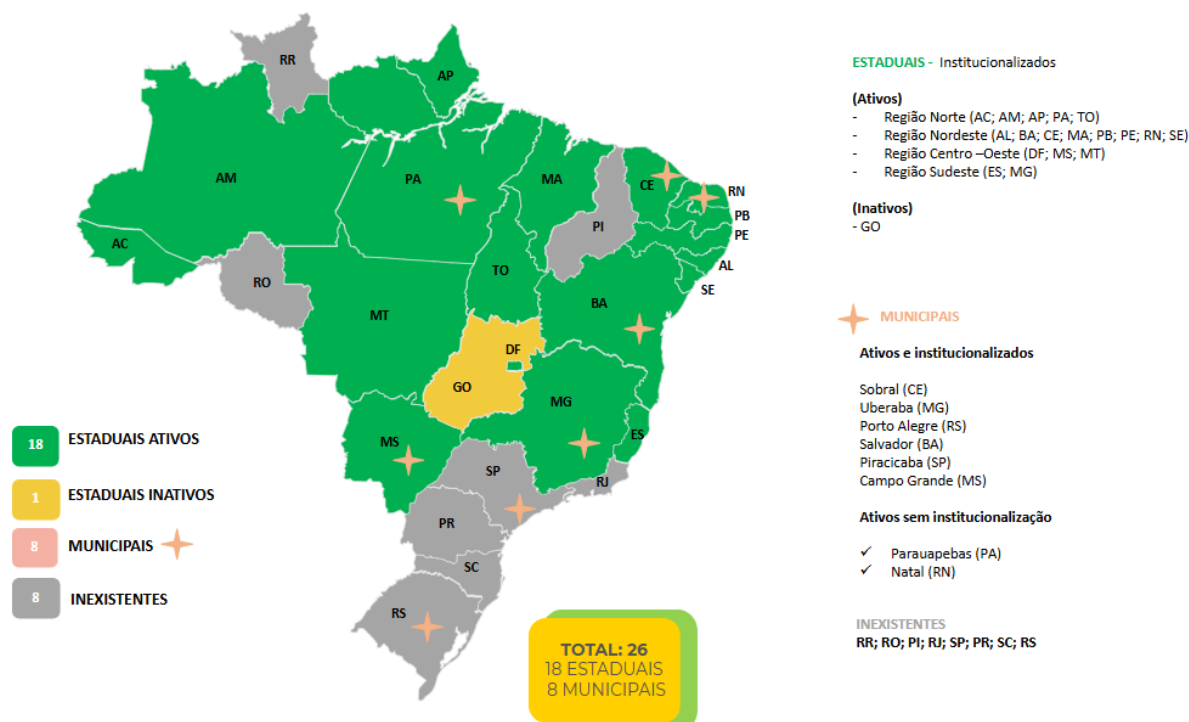
O fortalecimento e a **ampliação dos Núcleos de Economia da Saúde (NES)** constituem-se como instrumento de articulação e de apoio a governança com foco na eficiência, na equidade e qualidade das ações e serviços públicos de saúde. Assim, o intuito é torná-los centros de gestão estratégica a partir da ampliação do uso dos Sistemas de Informações em Economia da Saúde e da realização de estudos econômicos, ambos como subsídios para a tomada de decisão.

De janeiro a agosto de 2025 não houve a implantação de novos NES, contudo foram realizadas ações visando promover e incentivar a implantação de novos Núcleos de Economia da Saúde, com destaque para:

	Reuniões Virtuais	- Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Curitiba (PR) Joinville (PR) Santo Antônio de Posse (SP) Rolim de Moura (RN) Recife (PE) - Secretarias Estaduais de Saúde (SES): Santa Catarina (SC) Rio Grande do Sul (RS).
	Elaboração e/ou Monitoramento do Plano de Ação Anual dos NES Institucionalizados	- Estados: Amazonas Alagoas Paraíba Amapá Ceará Bahia Acre Maranhão Mato Grosso Sul Minas Gerais. - Municípios: Campo Grande (MS) Sobral (BA).
	Palestras e Eventos	Palestras sobre os Núcleos de Economia da Saúde para representantes das SES e SMS: Amapá Amazonas Alagoas Bahia Ceará Goiás Paraíba Maranhão Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista (SP).
	4ª Reunião Geral dos Núcleos de Economia da Saúde	- Aproximadamente 90 pessoas. - Realizada de forma virtual. - Representantes das secretarias estaduais e municipais de Saúde, do Ministério da Saúde, das superintendências, universidades, hospitais e conselhos, entre outros participantes.

Fonte: Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde – Desid/Sectics/MS.

Na figura a seguir é possível observar a situação dos NES pelo Brasil:
Núcleos de Economia da Saúde no Brasil



Fonte: Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde – Desid/Secitcs/MS.

Além disso, contribuindo também para a gestão de custos no âmbito do SUS, por meio da geração, aperfeiçoamento e efetiva utilização de informações referentes a custos, como subsídio para a tomada de decisão e a otimização do desempenho, busca-se que os estabelecimentos de saúde gerem informações no Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (ApuraSUS). Considera-se como gerando informações no ApuraSUS, o estabelecimento que alimenta o sistema pelo menos um mês nos últimos 12 meses. Assim, referente ao ciclo de agosto de 2025, 984 estabelecimentos enviaram informações no sistema.

Apresenta-se a seguir o quantitativo de estabelecimentos de saúde que enviaram informações no ApuraSUS por UF.

Estabelecimentos de Saúde que Enviaram Informações de Custos no Sistema ApuraSUS ³⁷					
AC	1	MA	11	RJ	66
AL	1	MG	311	RN	14
AM	20	MS	6	RO	-
AP	1	MT	21	RR	-
BA	28	PA	3	RS	163
CE	59	PB	15	SC	5
DF	203	PE	14	SE	16
ES	2	PI	1	SP	9
GO	1	PR	6	TO	7
Brasil: 984					

Fonte: Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde – Desid/Secitcs/MS.

O **Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis)** se configura, enquanto cadeia produtiva, como a base tecnológica do sistema de inovação e produção em saúde e integra todas as atividades que perpassam o sistema de saúde, onde se dá a produção e o acesso a medicamentos, vacinas,

³⁷ Considerando que o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é de adesão voluntária, conforme Portaria GM/MS n.º 55, de 10 de janeiro de 2018, informa-se que os estados de RO e RR não fizeram adesão ao Programa, portanto não enviam dados de gestão de custos no sistema.

hemoderivados, dispositivos médicos e serviços de comunicação e conectividade, essenciais para a efetividade das ações assistenciais, de prevenção, diagnóstico, promoção e reabilitação em saúde. O estímulo à inovação e à produção local dessas tecnologias críticas visa alcançar a transformação produtiva e o avanço científico e tecnológico necessários para a gradativa redução da vulnerabilidade tecnológica do SUS.

Em relação à execução da meta proposta, de janeiro a agosto de 2025, foram formalizados nove novos projetos, totalizando 25 instrumentos voltados para desenvolvimento, inovação e produção local, considerando os 16 projetos firmados em 2024.

Os instrumentos formalizados em 2025 constam no quadro a seguir:

Eixos Temáticos	Instrumentos/ Data de Publicação	Objeto	Instituição
Projetos para a ampliação e qualificação da produção local de tecnologias em saúde.	1. TED ³⁸ 07/2025 - Publicado em 12 de junho de 2025.	Aquisição de equipamentos para desenvolvimento, produção e controle de medicamentos.	LFM ³⁹
	2. TED 09/2025 - Publicado em 25 de junho de 2025.	Fomento à segunda etapa do projeto de internalização brasileira de normas técnicas internacionais para o setor de dispositivos médicos.	Unifei ⁴⁰
	3. TED 17/2025 - Publicado em 28 de julho de 2025.	Aquisição de equipamento para incremento da capacidade produtiva da linha de produção de medicamentos sólidos orais.	UFRN ⁴¹
Instrumentos para o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.	4. TC ⁴² n.º1/2025 – PDP ⁴³ -Publicado em 8 de maio de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando a produção local de INSULINA GLARGINA, para atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).	MS, Fiocruz, Biommm S. A. e a GAN & LEE Pharmaceuticals
	5. TC n.º 3/2025 – PDP - Publicado em 24 de julho de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando à produção local da VACINA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR), para atendimento às demandas do SUS.	MS, Butantan, Pfizer Brasil LTDA e Pfizer INC
	6. TC n.º 4/2025 – PDP - Publicado em 30 de julho de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando a produção local de CLADRIBINA 10mg, para atendimento às demandas do SUS.	MS, Fiocruz, Merck S.A. e Nortec Química S.A.
	7. TC n.º 5/2025 – PDP - Publicado em 28 de julho de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando à produção local de IVACAFITOR 150mg comprimido revestido, para atendimento às demandas do SUS.	MS, Furp ⁴⁴ e Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
	8. TC n.º 7/2025 – PDP - Publicado em 29 de julho de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando à produção local do produto Dicloridrato de Trientina 250mg cápsula dura, para atendimento às demandas do SUS.	MS, LFM e Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
	9. TC n.º 9/2025 – PDP - Publicado em 29 de julho de 2025.	Formalizar a parceria para o desenvolvimento, transferência tecnológica, absorção de tecnologia, capacitação produtiva e tecnológica do País, visando à produção local de NUSINERSENA solução injetável; intratecal; frasco-ampola com 5mL, cada frasco contém 12mg de Nusinersena/5mL (2,4mg/mL), para atendimento às demandas do SUS.	MS, Fiocruz, Hypera S.A. e Aurisco Pharmaceutical CO. Ltd

Fonte: Departamento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS -Deceiis/Sectics/MS.

³⁸ Termo de Execução Descentralizada (TED).

³⁹ Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM).

⁴⁰ Universidade Federal de Itajubá (Unifei).

⁴¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

⁴² Termo de compromisso (TC)

⁴³ Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)

⁴⁴ Fundação para o Remédio Popular "Chopin Tavares de Lima" (Furp).

Os **Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)** são documentos que visam garantir as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos pacientes no âmbito do SUS. Os temas dos PCDTs podem ser definidos pelas áreas internas do Ministério da Saúde e/ou podem ser demandados a partir de tecnologias incorporadas.

No período de janeiro a agosto de 2025, informa-se que foram recebidas 23 demandas de elaboração/atualização de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), oriundas de processos de incorporação de tecnologias em saúde e que oito (34,78%) protocolos foram submetidos à apreciação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) no prazo de 270 dias.

PCDTs Submetidos à Conitec no Prazo de 270 dias	
1.	Pamoato de pasireotida para o tratamento de pacientes com acromegalia.
2.	Deferiprona para o tratamento a sobrecarga de ferro em pacientes com doença falciforme.
3.	Ixequizumabe para tratamento de pacientes adultos com artrite psoríaca ativa com falha ou intolerantes ao tratamento a um medicamento modificador do curso da doença biológica em primeira linha.
4.	Rituximabe e o romiplostim para tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática refratária, crônica ou dependente de corticosteroide em crianças e adolescentes.
5.	Donepezila para pacientes com doença de Alzheimer grave.
6.	Tacrolimo tópico 0,3mg/g 1mg/g para o tratamento de pacientes com dermatite atópica.
7.	Furoato de mometasona 0,1% para o tratamento de pacientes com dermatite atópica.
8.	Metotrexato para pacientes com dermatite atópica moderada a grave.

Fonte: Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – Dgits/Secits/MS.

Importa destacar que a elaboração de um PCDT é um processo técnico e meticuloso, que envolve múltiplas etapas metodológicas, conduzidas por equipe multidisciplinar especializada. Cada protocolo exige análise rigorosa de evidências científicas disponíveis, além da avaliação técnica das tecnologias e intervenções propostas, sempre considerando a especificidade clínica e epidemiológica da condição de saúde em questão.

Cabe registrar que, considerando o realizado no ano de 2024 (108) até agosto de 2025, foram submetidas para avaliação da Conitec 171 Tecnologias em Saúde (ATS).

A partir dos **projetos de pesquisa em saúde e ambiente**, mantidos pela Fiocruz, espera-se auxiliar o desenvolvimento científico institucional/nacional, gerando mais e melhores bioprodutos, inovações em atenção à saúde e conhecimentos científicos que serão disponibilizados para a sociedade.

Observa-se que a Fiocruz desenvolve uma ampla gama de estudos, com destaque em medicina experimental e inovação tecnológica, contribuindo de forma relevante para a geração de conhecimento voltado ao enfrentamento de doenças. Além disso, a instituição também investiga temas de saúde coletiva, incluindo violência, meio ambiente e vigilância em saúde. Os esforços estratégicos têm possibilitado ampliar as pesquisas em diferentes áreas da saúde pública, gerando novos projetos em unidades técnico-científicas da Fundação em todo o país. No ciclo de agosto de 2025, foi possível identificar um total de 1.666 projetos de pesquisa em saúde e ambiente em desenvolvimento na Fiocruz, distribuídos regionalmente da seguinte maneira:

Região	Estados	Projetos de pesquisa em saúde e ambiente em desenvolvimento
Norte	AM	45
	RO	18
Nordeste	BA	238
	PE	109
	CE	51
	PI	1
Centro-Oeste	DF	66
	MS	31
Sudeste	MG	64
	RJ	988
Sul	PR	55
Total		1.666

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Adicionalmente, informa-se que a Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz promoveu avanços significativos, destacando a expansão com a integração de três novas plataformas: Genômica (RPT01S), Impressão 3D - Bioinovações 3D (RPT18C) e Farmacocinética Pré-clínica (RPT20A). Além disso, o fortalecimento da Rede incluiu treinamentos, cinco visitas técnicas às unidades: Instituto Carlos Chagas (Curitiba/PR), Instituto René Rachou (Belo Horizonte/MG), Instituto Aggeu Magalhães (Recife/PE), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic), ambas no Rio de Janeiro/RJ.

Registra-se que, de janeiro a agosto de 2025, 11.212 procedimentos de pesquisa foram atendidos por meio da Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz, totalizando 26.548 desde o início do Plano. Foram considerados os procedimentos realizados por meio da Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz (RPT), Pesquisas Clínicas (PC), Biobanco da Biodiversidade e Saúde (BBS-Fiocruz) e Coleções Biológicas (CB).

Objetivo 5. Ampliar o acesso da população aos medicamentos, insumos estratégicos e serviços farmacêuticos, qualificando a assistência farmacêutica, articulada à pesquisa, à inovação e à produção nacional, regulação, com qualidade e uso adequado no Sistema Único de Saúde, reduzindo as iniquidades.

Este objetivo reflete a complexidade de parte das ações e serviços de saúde relacionados à Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) e à Política Nacional de Medicamentos (PNM), bem como à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), no intuito de qualificar os processos que envolvem o planejamento, a aquisição, a distribuição e o acesso e uso adequado de medicamentos e insumos estratégicos pelos usuários do SUS, assim como o aprimoramento da assistência à saúde do cidadão e a produção de informações, a partir das estratégias de transformação digital, no âmbito da assistência farmacêutica.

Quadro 36 – Resultados PAS: Objetivo 5 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Ampliar o número de usuários atendidos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil ao ano.	Número de usuários atendidos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil ao ano.	Unidade	26.000.000	23.384.455	20YR 20YS	Sectics/MS
2. Adquirir fármacos e insumos estratégicos no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica sob responsabilidade do Ministério da Saúde conforme Relação Nacional de Medicamentos (Rename).	Número de fármacos e insumos estratégicos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica adquiridos.	Unidade	47	29	20AE (0003)	Sectics/MS Estados Municípios
3. Adquirir fármacos e insumos estratégicos no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica sob responsabilidade do Ministério da Saúde conforme Relação Nacional de Medicamentos (Rename).	Número de fármacos e insumos estratégicos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica adquiridos.	Unidade	86	59	4705 (0002)	Sectics/MS Estados Municípios
4. Adquirir fármacos e insumos estratégicos no âmbito do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica sob responsabilidade do Ministério da Saúde conforme Relação Nacional de Medicamentos (Rename).	Número de fármacos e insumos estratégicos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica adquiridos.	Unidade	74	49	4368 (Sectics)	Sectics/MS Estados Municípios
5. Ampliar o número de serviços de cuidado farmacêutico realizados nos estabelecimentos de saúde ofertados aos usuários do SUS.	Número de serviços de cuidado farmacêutico realizados nos estabelecimentos de saúde ofertados aos usuários do SUS.	Unidade	19.500.000	20.228.014	20AH	Sectics/MS Estados Municípios

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
6. Ampliar o número de estados, DF e municípios habilitados no Programa de Qualificação Nacional da Assistência Farmacêutica no SUS.	Número de estados, DF e municípios habilitados nos eixos do Programa de Qualificação Nacional da Assistência Farmacêutica no SUS.	Unidade	4.728	4.797	20AH 20K5	Sectics/MS Estados Municípios
7. Ampliar o número de estados, Distrito Federal e municípios enviando dados à Bnafar ⁴⁵ para o aperfeiçoamento do repasse de recursos de aquisição descentralizada de medicamentos e insumos estratégicos dos componentes Básico e Especializado da Assistência Farmacêutica.	Número de estados, Distrito Federal e municípios enviando dados de estoque e dispensação de medicamentos e insumos estratégicos para a população à Bnafar.	Unidade	4.555	3.156	20AE (0002) 20AE (0004) 4705 (0003) 20AH	Sectics/MS Estados Municípios
8. Ampliar o número de entes federados apoiados para o fortalecimento da gestão e estruturação da política de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS.	Número de entes federados apoiados para o fortalecimento da gestão e estruturação da política de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS.	Unidade	1.848	0 ⁴⁶	20K5	Sectics/MS Estados Municípios
9. Ampliar as soluções digitais ⁴⁷ desenvolvidas no âmbito da assistência farmacêutica para aprimoramento da gestão da informação e comunicação dos entes federados.	Número de soluções digitais desenvolvidas no âmbito da Assistência Farmacêutica para aprimoramento da gestão da informação e comunicação dos entes federados.	Unidade	10	6	20AH	Sectics/MS Estados Municípios
10. Fomentar pesquisas no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS.	Número de pesquisas relacionadas à Assistência Farmacêutica no SUS fomentadas.	Unidade	8	4	20AH	Sectics/MS
11. Alcançar o cumprimento dos requisitos da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionados à Anvisa para o reconhecimento do Brasil como autoridade referência em medicamentos e vacinas.	Percentual de cumprimento dos requisitos da OMS relacionados à Anvisa para medicamentos e vacinas.	Percentual	95%	92,43%	Não se aplica	Anvisa

⁴⁵ Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde (Bnafar).

⁴⁶ O apoio financeiro aos entes federativos permanece condicionado à finalização de etapas complementares, como a publicação da portaria de habilitação dos entes federativos selecionados e a divulgação do edital de chamamento público para apoio a projetos de implantação e/ou estruturação de farmácias vivas.

⁴⁷ As soluções digitais são soluções tecnológicas (sistemas, bancos de dados, portais entre outras ferramentas) que serão desenvolvidas e disponibilizadas aos entes para o aprimoramento da gestão da informação e comunicação dos serviços gerenciais e assistenciais no âmbito da Assistência Farmacêutica no SUS.

Informações Adicionais

Este objetivo possui 11 metas, sendo 10 monitoradas pela Sectics/MS e uma pela Anvisa. Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, divididos em cinco intervalos percentuais, considerando a previsão para o final do exercício de 2025 conforme a Programação Anual de Saúde (PAS). Ressalta-se que esse resultado reflete as políticas públicas executadas de forma ampla, ou seja, aquelas que envolvem os esforços de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	1	9,09%
Acima de 25 até 50%	1	9,09%
Acima de 50% até 75%	5	45,45%
Acima de 75% até 100%	2	18,19%
Acima de 100%	2	18,18%
Total	11	100,00%

Buscando a **ampliação do número de usuários que receberam medicamentos e insumos constantes do elenco do Programa Farmácia Popular**, informa-se que entre janeiro e agosto de 2025, as farmácias credenciadas ao Programa atenderam 23.384.455 pessoas.

O número de pessoas atendidas vem aumentando significativamente, uma vez que foi publicada a Portaria GM/MS n.º 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, que estabeleceu a gratuidade do medicamento dapagliflozina, indicada para diabetes mellitus associada a doença cardiovascular, e da fralda geriátrica. Desta forma, todo o elenco de medicamentos e correlatos do Programa Farmácia Popular passou a ser gratuito, extinguindo a modalidade “copagamento”.

Cumprir destacar que o Programa Farmácia Popular ampliou a sua abrangência em 188 novos municípios, alcançando a marca de 5.000 municípios atendidos em todo o país, o que representou um avanço significativo no acesso da população aos medicamentos disponibilizados.

Contudo, em agosto, o número de municípios atendidos pelo Programa caiu para 4.949, devido ao descredenciamento de 2.378 farmácias. Dessas, 2.097 foram excluídas por estarem inativas na Receita Federal ou por não renovarem seu credenciamento para o ano de 2025, e 281 foram descredenciadas por irregularidades ou a pedido.

Apesar da redução no número de farmácias, o atendimento à população não foi prejudicado, pois os estabelecimentos já não estavam em funcionamento ou não realizavam mais dispensações no âmbito do programa.

Apresenta-se a seguir o percentual de farmácias credenciadas ao Programa por unidade da federação:

Percentual de Farmácias Credenciadas no Programa Farmácia Popular do Brasil					
AC	6,07%	MA	7,83%	RJ	22,18%
AL	13,06%	MG	55,54%	RN	26,94%
AM	4,28%	MS	30,04%	RO	27,65%
AP	7,31%	MT	16,90%	RR	11,15%
BA	17,20%	PA	6,71%	RS	54,34%
CE	14,50%	PB	31,58%	SC	42,13%
DF	21,12%	PE	13,48%	SE	13,67%
ES	42,66%	PI	12,23%	SP	32,50%
GO	44,74%	PR	52,44%	TO	16,95%
Brasil: 29,75%					

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/Sectics/MS.

Complementarmente, informa-se que entre janeiro e agosto de 2025 foram credenciadas 293 novas farmácias ao Programa Farmácia Popular do Brasil, as quais estão localizadas em 231 municípios de 25 Unidades da Federação.

Visando ao aprimoramento da gestão da informação para subsidiar a tomada de decisão de modo tempestivo, resolutivo e acurado, o planejamento do processo de **aquisição de fármacos e insumos estratégicos sob responsabilidade do Ministério da Saúde** é feito a partir dos fármacos e insumos listados na Relação Nacional de Medicamentos (Rename). A lista é atualizada conforme as novas inclusões aprovadas na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. A publicação da Rename é feita a cada dois anos.

Diante do exposto, informa-se que entre janeiro e agosto foram realizadas aquisições de 29 fármacos e insumos estratégicos para atendimento do **Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf)**, 59 do **Componente Especializado (Ceaf)** e 49 fármacos do **Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf)**.

Quanto ao Componente Básico, o MS adquiriu, fármacos para compor o kit de calamidade, para atendimento do Programa Saúde da Mulher, para o tratamento da Hidradenite Supurativa, para o tratamento da diabetes mellitus, além de outros insumos relacionados ao componente em complementação à gestão de estoque e para atender à necessidade de abastecimento da Rede SUS.

Em relação ao Componente Especializado, destaca-se que, no período de janeiro a agosto de 2025, foram adquiridos cinco fármacos oncológicos: dasatinibe, mesilato de imatinibe, pertuzumabe, rituximabe e trastuzumabe. Informa-se ainda que a aquisição centralizada de fármacos e insumos estratégicos do Ceaf beneficiou, nos meses de janeiro a julho, um total de 1.700.320⁴⁸ usuários (as).

No que se refere ao Componente Estratégico, foram adquiridos fármacos para atendimento dos programas de controle da tuberculose, sífilis, hanseníase, tabagismo, malária, micoses sistêmicas, leishmaniose, toxoplasmose, além de fármacos para o programa de alimentação e nutrição dentre outros.

A meta relacionada à ampliação do número de **serviços de cuidado farmacêutico realizados nos estabelecimentos de saúde ofertados aos usuários do SUS** busca qualificar as ações e serviços assistenciais a partir da atuação do profissional farmacêutico e da equipe de assistência farmacêutica nas práticas clínicas, visando a resolutividade das ações em saúde, otimizando benefícios e minimizando riscos relacionados a farmacoterapia, e promovendo o uso seguro e racional de medicamentos.

No período de janeiro a julho de 2025⁴⁹, os sistemas oficiais de informação do Sistema Único de Saúde (SUS) registraram que foram realizados 7.968.271 procedimentos de serviços de cuidado farmacêutico vinculados aos CBOs do Farmacêutico. No contexto do quadriênio 2024–2027, o total acumulado já alcança 20.228.014 procedimentos⁵⁰ distribuídos regionalmente conforme quadro a seguir:

Serviços de Cuidado Farmacêutico Realizados por UF - Acumulado					
AC	76.222	MA	470.826	RJ	1.632.948
AL	70.823	MG	1.070.157	RN	84.291
AM	1.181.931	MS	76.958	RO	826.320
AP	97.179	MT	125.846	RR	6.225
BA	1.387.431	PA	1.217.940	RS	1.496.651
CE	713.631	PB	1.589.863	SC	487.769
DF	126.741	PE	140.322	SE	22.268
ES	231.318	PI	484.067	SP	4.743.850
GO	876.809	PR	640.001	TO	349.627
Brasil: 20.228.014					

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - DAF/Secitcs/MS.
Dados preliminares: extração em 1º/9/2025.

⁴⁸ O levantamento de dados considera o número de pessoas identificadas pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS) que efetivamente receberam fármacos de aquisição centralizada do Ceaf no referido período. Além disso, registra-se que as informações relacionadas ao número de usuários beneficiados são extraídas do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), assim, justifica-se a apresentação dos dados consolidados até julho de 2025.

⁴⁹ As informações enviadas pelos estados e municípios passam por atualizações contínuas em cada ciclo, essenciais para garantir a precisão e a integridade dos dados registrados nos sistemas, fundamentais para o monitoramento e a gestão da saúde pública. Devido a essas características do processo de atualização e retificação, é esperado que exista variações nos registros de produção para os meses anteriores ao longo do monitoramento, decorrentes das inclusões retroativas e das correções realizadas dentro dos prazos estabelecidos.

⁵⁰ Número de procedimentos realizados em 2024: 12.259.743, conforme dados extraídos em 01/09/2025.

No que concerne a avaliação dos serviços de Cuidado Farmacêutico nos estados, DF e municípios, foram avaliados 61 estabelecimentos de saúde, indicados pelos gestores estaduais e do Distrito Federal como unidades com atuação de farmacêuticos na prestação de serviços relacionados ao cuidado farmacêutico. Desses, foi possível identificar produção, conforme registrado no sistema oficial do SUS, em 17 estabelecimentos, o que representa um total acumulado de 27,86% do universo avaliado.

Complementarmente, diversas iniciativas estruturantes no âmbito do cuidado farmacêutico no SUS têm sido promovidas, destacando-se:

Desenvolvimento de Indicadores Nacionais	Projeto Piloto para Tuberculose e Hanseníase
O painel, atualmente em construção, já conta com 65 indicadores. Eles estão em processo de validação e serão submetidos à metodologia Delphi, com a participação de especialistas, para aprimoramento e consolidação. Os indicadores serão aplicados no contexto da Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada e Atenção Hospitalar. A avaliação considerará três componentes: estrutura, processo e resultados.	Avança a implementação do cuidado farmacêutico para pessoas com tuberculose e hanseníase em cinco municípios do estado de Minas Gerais, com previsão de expansão gradual para outras regiões do país. Os guias de prática clínica estão em fase final de ajuste e serão encaminhados para normalização, revisão, diagramação e publicação pela Editora do Ministério da Saúde. Em julho de 2025, o Plano de Trabalho para um curso de qualificação de farmacêuticos foi elaborado. O curso é autoinstrucional e focado no cuidado de pessoas com tuberculose e hanseníase. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre departamentos do MS e universidades parceiras envolvidas.
Ampliação do Serviço de Telecuidado	Qualificação da Dispensação de Medicamentos
Destaca-se a parceria com o núcleo de telessaúde da Universidade Federal de Goiás (UFG) para a criação do Centro Colaborador de Telecuidado Farmacêutico (CCTF). Usuários do medicamento Selexipague, indicado para Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), em estados como Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, já estão recebendo teleconsultas farmacêuticas, garantindo o uso seguro da terapia. Em Minas Gerais, os profissionais já foram capacitados e alinham os fluxos internos para início dos atendimentos, enquanto Pernambuco e São Paulo se preparam para iniciar a adesão ao serviço. O objetivo é ampliar gradualmente o teleatendimento a usuários de todos os estados e do Distrito Federal, bem como estender a estratégia para outras condições clínicas que demandam monitoramento farmacêutico.	Qualificação da dispensação por meio da produção de Materiais Educativos Digitais e Impressos (Medi) sobre os fármacos da Rename. Até o momento, foram elaborados 788 Medi, compostos por ficha técnica profissional e orientações para usuários. Desse total, 382 correspondem a medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), 292 do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) e 108 do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf).

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/Secitcs/MS.

O **Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (Qualifar-SUS)** possui quatro eixos de atuação: estrutura, educação, informação e cuidado. A habilitação no eixo estrutura é fundamental para a qualificação dos serviços assistenciais e gerenciais da assistência farmacêutica nas Redes de Atenção à Saúde do SUS.

Em relação ao número de estados, DF e municípios habilitados nos eixos do Programa de Qualificação Nacional da Assistência Farmacêutica no SUS, por meio da Portaria GM/MS n.º 7.556, de 11 de julho de 2025, foram habilitados mais 428 novos municípios, alcançando o total de 4.797 entes habilitados no QualifarSUS.

Número de Municípios Habilitados no Eixo Estrutura do QualifarSUS							
AC	22		MA	207		RJ	68
AL	101		MG	792		RN	165
AM	61		MS	75		RO	51
AP	15		MT	131		RR	14
BA	414		PA	142		RS	335
CE	183		PB	221		SC	172
DF	-		PE	182		SE	74
ES	70		PI	223		SP	391
GO	219		PR	334		TO	135
Brasil: 4.797							

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/Secitcs/MS.

A **Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (Bnafar)** é utilizada para a consolidação dos dados nacionais de posição de estoque, saída, movimentação ou perda de estoque de medicamentos e insumos a serem enviados pelos entes federativos.

Considerando a Portaria de Consolidação n.º 01, de 28 de setembro de 2017, a competência de monitoramento refere-se aos dados enviados para a Bnafar em agosto de 2025. Assim, a partir de análise das bases de dados, verificou-se o total de 3.156 entes que enviaram dados à Bnafar⁵¹.

De forma complementar, informa-se que, em 2025, a aquisição descentralizada de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica beneficiou, em julho de 2025, 585.763 usuários de medicamentos do Grupo 1B⁵².

Além disso, por meio da publicação da Portaria GM/MS n.º 7.513, de 16 de julho de 2025, foi autorizado o repasse do componente básico da assistência farmacêutica para atendimento de 668.570 pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (Pnaisp) atendendo 100% da população prisional em 2025.

A **Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF)** visa garantir à população o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Nesse contexto, foi proposta a meta para apoiar os entes federados para o fortalecimento da gestão e estruturação da PNPMF no âmbito da Assistência Farmacêutica do SUS.

O apoio financeiro aos entes federativos permanece condicionado à finalização de etapas complementares, como a publicação da portaria de habilitação dos 1.463 entes federativos selecionados e a divulgação do edital de chamamento público para apoio a projetos de implantação e/ou estruturação de farmácias vivas. As perspectivas para os próximos meses concentram-se em três frentes de ação prioritárias: a publicação da portaria de habilitação dos referidos entes para o recebimento do incremento financeiro; a publicação e divulgação de edital de chamamento público destinado ao apoio a projetos de implantação e/ou estruturação de farmácias vivas; e a continuidade das atividades previstas no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) n.º 139/2024, que têm como objetivo identificar e apoiar, até o final deste ano, pelo menos três centros de referência em plantas medicinais e fitoterápicos.

A fim de demonstrar as **soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para apoio à Saúde Digital**, foi definida, no Plano Nacional de Saúde, a meta de evidenciar sua aplicação tanto na gestão centralizada da assistência farmacêutica, realizada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, quanto na gestão descentralizada, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O propósito é fortalecer a gestão da informação e qualificar a atenção à saúde nos estabelecimentos de saúde e nas centrais de abastecimento farmacêutico.

⁵¹ Destaca-se que, em julho, foram repactuados novos prazos em virtude das dificuldades dos entes subnacionais, principalmente os municípios, para adequarem seus sistemas aos novos padrões de dados estabelecidos para envio diário para a Bnafar, conforme Portaria GM/MS n.º 5.713, de 9 de dezembro de 2024 e para a RNDS, conforme a Portaria GM/MS 6.100 de 17 de dezembro de 2024. Os municípios passaram a ter até 180 dias e estados até 120 dias para adequações dos sistemas próprios e envio a essas bases.

Este prazo reflete na redução no número de dados enviados para a base pelos entes que utilizam sistema próprio e estão no processo de migração no Serviço de Interoperabilidade do antigo Webservice para o SI Bnafar.

⁵² O "grupo 1B" diz respeito a uma categoria de medicamentos do Ceaf, que são financiados pelo Ministério da Saúde, mas adquiridos e dispensados de forma descentralizada pelas secretarias estaduais de saúde (e do Distrito Federal).

Em 2025, a Programação Anual de Saúde estabelece 10 soluções digitais prioritárias para manutenção, sendo cinco soluções entregues em 2024, e o desenvolvimento de mais cinco soluções no âmbito do Ministério da Saúde para atender as demandas do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) e dos estados, DF e municípios no âmbito da Assistência Farmacêutica.

No que se refere ao desenvolvimento de soluções programadas para 2025, informa-se que a versão web do Sistema MedSUS foi entregue, totalizando seis soluções digitais entregues até o momento. Quanto as demais observam-se os seguintes estágios:

Solução em Desenvolvimento	Estágio
SisAF	Em fase de homologação do módulo fornecedor, com treinamento iniciado em julho. Em setembro, a previsão é iniciar a homologação do módulo específico para as secretarias de saúde para realizarem a programação das demandas dos componentes básico, estratégicos e especializado e avanço no levantamento de requisitos dos fornecedores.
Farmácia Popular do Brasil - Povos Originários	Está em desenvolvimento com previsão de entrega do módulo inicial reprogramada para setembro de 2025.
MedSUS	A entrega da versão 1.0 ocorreu em maio de 2025. O treinamento nacional está previsto para iniciar em setembro, após a publicação da portaria específica que tornará o sistema oficial para a assistência farmacêutica.
Plataforma de Telecuidado	A plataforma de telecuidado foi desenvolvida e entregue para suporte ao atendimento de pacientes em tratamento com o medicamento selexipague, indicado para hipertensão arterial pulmonar (HAP). É esperada a ampliação dos ambientes, dos estados parceiros e das condições clínicas atendidas em 2025, tendo em vista a formalização da parceria com a Universidade Federal de Goiás. A entidade parceira atuará como centro colaborador de cuidado farmacêutico para estabelecer as prioridades e prazos de desenvolvimento dos novos protocolos de atendimento e condições clínicas prioritárias para o telecuidado.
eSUSAF	Avança na evolução dos seus módulos entregues (básico e estratégico) com piloto de implantação para os municípios em Pernambuco. O início do desenvolvimento do Módulo Especializado e a validação do Módulo Indígena foram reprogramados para agosto de 2025 a partir da parceria firmada com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/Secitcs/MS.

Destaca-se que no caso dos sistemas eSUSAF e MedSUS houve pactuação tripartite, resultando na publicação da Portaria GM/MS 7.947, de 21 de agosto de 2025, para definir a estrutura de governança colaborativa tripartite do eSUSAF e a oficialização do MedSUS como repositório único das listas de medicamentos e vacinas no SUS e em 30 dias o MS deve apresentar o Plano Operativo destes sistemas.

O **desenvolvimento de pesquisas** é fundamental para aprimorar a Assistência Farmacêutica no SUS. Por meio da avaliação sistemática de políticas, programas e diretrizes, as pesquisas contribuem diretamente para mensurar o impacto das ações ofertadas ou que ainda precisam ser trabalhadas. Nesse sentido, ao longo do ciclo do PNS 2024-2027, foram fomentadas quatro pesquisas, no âmbito da assistência farmacêutica, por meio de instrumentos de parceria com instituições de ensino, sendo:

Ano	Pesquisas Fomentadas no Âmbito da Assistência Farmacêutica	Instituição Parceira
2024	Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil (Pnaum) – Inquérito	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
	Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil (Pnaum) - Serviço Subeixo Ceaf	Universidade de Brasília
	Pesquisa para mapeamento de medicamentos essenciais pela via magistral.	
2025	Pesquisa de satisfação do telecuidado.	Universidade Federal de Goiás

Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/Secitcs/MS.

Em se tratando da meta para o **cumprimento dos requisitos da OMS relacionados à Anvisa para medicamentos e vacinas**, o último resultado aferido ocorreu em 8 de setembro de 2025, alcançando 92,43%. O resultado demonstra que 262,5 critérios de auditoria foram atendidos em relação ao total de 284 critérios de auditoria da OMS (quatro critérios foram excluídos por terem sido considerados não

aplicáveis ao Brasil e um critério de desempenho foi retirado pela OMS restando 20 de desempenho e 264 do GBT= 284 total).

Até o momento, a análise completa do status de implementação dos critérios de auditoria de maturidade 1, 2, 3 e 4 e dos 20 critérios de desempenho (que correspondem ao total dos 284 critérios) revelou uma redução no percentual de atendimento, de 93,05% (em junho) para 92,43% (em agosto). Esse resultado era previsto uma vez que foram iniciadas as auditorias internas da qualidade referentes ao ciclo 2025/2026.

Em 9 de setembro de 2025, do total de 835 recomendações emitidas (somando-se 2021, 2023 e auditorias internas realizadas em 2025), 80,2% (670) encontravam-se com status de concluídas pelas unidades da Anvisa, 13,3% (111) tinham as suas ações de melhoria iniciadas e 4,4% (37) não haviam sido iniciadas por serem recomendações recentes das auditorias de 2025.

Ressalta-se que 2% (17) das recomendações foram avaliadas como não atendidas ou parcialmente atendidas, em sua maioria, por extrapolarem a competência da Anvisa, como a recomposição do quadro de pessoal. Com a emissão de 96 novas recomendações oriundas das auditorias internas realizadas até agosto de 2025, é esperado que o percentual de atendimento apresente nova queda até o encerramento do ciclo de auditorias.

Ademais, observa-se o extensivo acompanhamento, com a realização de reuniões periódicas com os agentes da qualidade distribuídos nas diferentes unidades organizacionais envolvidas e a implementação de lembretes automáticos para os responsáveis a fim de garantir que as recomendações sejam efetivamente cumpridas.

Considerando a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na Anvisa para melhorar a qualidade dos produtos e serviços entregues à população, até 8 de setembro de 2025, 101 processos finalísticos eram parte do escopo do SGQ da Anvisa, representando 51% do total de 198 processos finalísticos mapeáveis.

Outra atividade desenvolvida pela Anvisa é a inspeção de estabelecimentos. Atualmente, o Órgão é responsável pelas inspeções de 25⁵³ estabelecimentos fabricantes de medicamentos, os quais possuem diferentes frequências de realização de inspeção dependendo do risco associado a cada um deles. As inspeções centralizadas de medicamentos encontram-se concentradas nos estados localizados no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, com exceção do estado de Goiás. Dessa forma, busca-se monitorar os fabricantes conforme o risco associado, garantindo a fabricação de medicamentos com qualidade.

Para o ano de 2025, dos 25 estabelecimentos previstos para serem monitorados entre 2024-2027, foram selecionados seis estabelecimentos para que fossem realizadas as inspeções. Em relação aos resultados alcançados até o momento, foram realizadas quatro inspeções: duas no Distrito Federal, uma no Ceará e outra na Bahia, resultando em 66,66% de fabricantes de medicamentos nacionais inspecionados com frequência condizente com o risco associado ao estabelecimento e seus produtos.

⁵³ O número de estabelecimentos fabricantes de medicamentos poderá variar à medida que estabelecimentos podem paralisar suas atividades de fabricação ou novos estabelecimentos podem entrar para o monitoramento conforme o risco associado.

Objetivo 6. Promover e qualificar a oferta de ações e serviços de saúde e saneamento ambiental, considerando os diferentes contextos étnico-culturais da população indígena, em articulação e fortalecimento dos saberes e práticas tradicionais.

Este objetivo guia o acesso à atenção integral à saúde dos povos indígenas, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Para isso, são empregadas medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, práticas sanitárias e atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência com base no controle social. As ações contemplam a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população vulnerável aos agravos de maior magnitude em saúde no Brasil, ao mesmo tempo em que reconhece a eficácia da medicina tradicional indígena e assegura o direito desses povos à sua cultura. O Subsistema de Saúde Indígena constitui uma rede de serviços estabelecida em áreas e territórios indígenas, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. Ele está estruturado em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), responsáveis pela execução das ações de Atenção Primária à Saúde (APS).

Quadro 37 – Resultados PAS: Objetivo 6 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Aumentar o percentual de indígenas menores de um ano com esquema vacinal completo.	Percentual de crianças indígenas menores de um ano com esquema vacinal completo.	Percentual	80%	82,07% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS
2. Ampliar o percentual de crianças indígenas menores de um ano com no mínimo seis consultas de crescimento e desenvolvimento.	Percentual de crianças indígenas menores de um ano com no mínimo seis consultas de crescimento e desenvolvimento.	Percentual	50%	53,90% ⁵³	20YP	Sesai/MS
3. Ampliar o percentual das gestantes indígenas com no mínimo seis consultas de pré-natal.	Percentual das gestantes indígenas com no mínimo seis consultas de pré-natal.	Percentual	55%	55,52% ⁵³	20YP	Sesai/MS
4. Ampliar o percentual das mulheres indígenas entre 25 e 64 anos com acesso à coleta do exame citopatológico ou papanicolau (PCCU).	Proporção de mulheres indígenas, com idade entre 25 e 64 anos, com uma coleta de exame citopatológico ou papanicolau no ano.	Percentual	25%	8,79% ⁵³	20YP	Sesai/MS
5. Ampliar o percentual de crianças indígenas menores de um ano com no mínimo seis acompanhamentos alimentar e nutricional realizados.	Percentual de crianças indígenas menores de um ano com no mínimo seis acompanhamentos alimentar e nutricional realizados.	Percentual	70%	68,20% ⁵³	20YP	Sesai/MS

⁵⁴ Dados preliminares de janeiro a junho de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
6. Ampliar a investigação de óbitos em crianças indígenas menores de um ano.	Percentual de óbitos em crianças indígenas menores de um ano de idade investigados.	Percentual	85%	52,96% ⁵⁵	20YP	Sesai/MS Estados Municípios
7. Ampliar a investigação de óbitos maternos em mulheres indígenas.	Percentual de óbitos maternos em mulheres indígenas investigados.	Percentual	92%	66,66% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS Estados Municípios
8. Ampliar o percentual de gestantes indígenas com no mínimo uma consulta odontológica durante o pré-natal.	Percentual de gestantes indígenas com no mínimo uma consulta odontológica durante o pré-natal.	Percentual	50%	50,47% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS
9. Ampliar o percentual da população indígena com primeira consulta odontológica programática.	Percentual da população indígena com primeira consulta odontológica programática.	Percentual	50%	28,87% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS
10. Ampliar o percentual de tratamento odontológico básico concluído na população indígena com primeira consulta odontológica programática.	Percentual de tratamento odontológico básico concluído na população indígena com primeira consulta odontológica programática.	Unidade	55%	51,17% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS
11. Aumentar a proporção de DSEI com processo de monitoramento sistemático dos indicadores de saúde.	Proporção de DSEI com processo de monitoramento dos indicadores de saúde implementado.	Percentual	58%	23,52% ⁵⁴	20YP	Sesai/MS
12. Ampliar o número de aldeias beneficiadas com obras de infraestrutura de abastecimento de água potável.	Número de aldeias beneficiadas com obras de infraestrutura de abastecimento de água potável.	Unidade	513	469	21CJ (0000) 21CJ (0001)	Sesai/MS
13. Ampliar o percentual de aldeias com coleta e análise de água para consumo humano.	Percentual de aldeias com coleta e análise de qualidade da água para consumo humano no ano.	Percentual	14%	8,73%	21CJ (0000)	Sesai/MS

⁵⁵ Dados preliminares de janeiro a junho de 2025

Informações Adicionais

Este objetivo possui 13 metas e todas são monitoradas pela Sesai. Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, considerando as previsões para o final do exercício de 2025 (PAS). Dentre elas, quatro metas foram alcançadas, enquanto outras sete registraram um bom desempenho para o período, com mais de 50% de implementação. É importante destacar que esses resultados refletem a execução de políticas públicas de forma integrada, envolvendo o esforço conjunto de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	0	0,00%
Acima de 25 até 50%	2	15,38%
Acima de 50% até 75%	4	30,77%
Acima de 75% até 100%	3	23,08%
Acima de 100%	4	30,77%
Total	13	100,00%

As informações abaixo referem-se às metas e indicadores monitorados pelo Subsistema de Saúde Indígena. Cabe destacar que os dados de proteção, promoção e recuperação da saúde indígena são atualizados trimestralmente. Assim, os números apresentados correspondem aos resultados preliminares do segundo trimestre de 2025.

O indicador que mede o percentual de **crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo (EVC)** avalia o nível de proteção dessa população contra doenças evitáveis por imunização, por meio do cumprimento do esquema básico de vacinação individual. No segundo trimestre de 2025, o resultado foi de 82,07%, o que corresponde a 14.094 crianças com menos de 1 ano que completaram seu esquema vacinal (EVC), em um total de 17.172 crianças nessa faixa etária. Dos 34 DSEI, 20 atingiram a meta de 80% de cobertura vacinal. Estão em andamento ações de contato direto com os pontos focais dos DSEI, visando reforçar a padronização e consistência dos dados para o monitoramento das ações de saúde indígena, além do apoio técnico remoto. Os resultados refletem diversas estratégias em território, como o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), a Operação Gota, a vigilância contínua das coberturas vacinais, o microplanejamento em áreas de difícil acesso, ações extramuros com logística específica, capacitações em sala de vacina e cadeia de frio, bem como a intensificação da vacinação de rotina do serviço. Adicionalmente, foi elaborado um Plano Integrado e Estratégico para ampliar as coberturas vacinais nos territórios indígenas.

O acompanhamento do indicador de **acesso de crianças indígenas menores de um ano a, no mínimo, seis consultas de crescimento e desenvolvimento** infantil é fundamental para avaliar a capacidade do sistema em assegurar o cuidado integral e contínuo das crianças indígenas no primeiro ano de vida. Esse acompanhamento também subsidia a gestão na tomada de decisões que contribuam para a redução da morbimortalidade infantil. Consideram-se apenas as consultas realizadas por médicos e enfermeiros antes de a criança completar um ano de vida. No segundo trimestre de 2025, das 9.634 crianças registradas no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), 5.193 (53,9%) receberam as consultas preconizadas para a idade. Todos os 34 DSEI inseriram as informações no sistema. Entre as ações realizadas para o alcance da meta, destacam-se: visitas domiciliares com busca ativa de crianças com consultas em atraso; atividades de educação em saúde nas comunidades e nas Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casai), voltadas para a importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; e a execução da estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) Comunitária na Saúde Materna e Infantil no Contexto Indígena. Ainda, estão sendo

elaborados planos de ação com pontos de controle semanais com foco especial nos DSEI Yanomami e Xavante.

No que se refere à saúde das gestantes indígenas, destaca-se a importância de avaliar as condições de acesso, a variação da cobertura do atendimento e qualidade da assistência pré-natal, pois, quando analisado com associação de outros indicadores, como a mortalidade materna e infantil, é possível obter subsídios para identificar situações de desigualdade e tendências que demandem ações específicas. Entre janeiro e junho de 2025, 10.486 gestantes finalizaram sua gestação, sendo que 5.822 (55,52%) tiveram **acesso a seis ou mais consultas de pré-natal** realizadas por médico, ou enfermeiro. As informações referem-se ao total de gestações finalizadas no período, excluindo-se aquelas interrompidas por aborto e considerando apenas os registros ativos em aldeias ou acampamentos. Algumas ações se destacam para a melhoria desse indicador, como o monitoramento mensal com devolutivas aos territórios e a elaboração de planos de ação para ampliar a cobertura nos DSEI com baixo desempenho. Também são firmadas parcerias estratégicas voltadas à saúde indígena, incluindo projetos com foco em ampliar o acesso à saúde especializada, no telemonitoramento de intercorrências obstétricas e no fortalecimento do pré-natal e planejamento reprodutivo. Além disso, foi instituída a Sala de Situação da Saúde da Mulher Indígena em 11 DSEI prioritários, com o objetivo de reduzir a mortalidade materna, fetal e infantil. Nela são realizadas reuniões quinzenais para análise e acompanhamento de indicadores, bem como para o planejamento das ações.

O indicador **percentual das mulheres indígenas entre 25 e 64 anos com acesso à coleta do exame citopatológico ou Papanicolau (PCCU)** dimensiona o percentual de mulheres elegíveis que realizam ao menos uma coleta de PCCU no período considerado. No segundo trimestre de 2025, das 150.708 mulheres indígenas elegíveis, 13.255 (8,79%) tiveram acesso ao exame citopatológico realizado por profissional médico ou enfermeiro. Apesar do baixo percentual de cobertura registrado, observa-se avanço na qualificação das equipes, no fortalecimento da linha de cuidado e na articulação com políticas nacionais. Espera-se que os efeitos das ações em andamento contribuam para a melhoria dos indicadores nos próximos ciclos, especialmente nas regiões priorizadas. Ressalta-se, ainda, a ampliação de parcerias estratégicas voltadas ao enfrentamento do câncer do colo do útero e ao fortalecimento da saúde materna e infantil em territórios indígenas. Entre as iniciativas relevantes estão a integração ao Plano Nacional de Eliminação do Câncer do Colo do Útero; projetos com foco em rastreamento, diagnóstico e tratamento em comunidades indígenas (como o Saúde em Rede Yanomami e o Tecnologias e Estratégias Remotas, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês); ações integradas de cuidado intercultural com o Hospital Albert Einstein; além do envio de notas técnicas aos DSEI de baixo desempenho para elaboração de planos de ação e relatórios de resultados.

A avaliação contínua do perfil alimentar e nutricional da população, bem como de seus fatores determinantes, integra a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde. Essa ferramenta, essencial para a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, pode ser incorporada aos serviços de saúde por meio da avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional das pessoas em todas as fases da vida. Dessa forma, o **indicador de acompanhamento do estado alimentar e nutricional das crianças menores de um ano**, no segundo trimestre de 2025, indicou que 6.571 crianças menores de um ano estavam em conformidade com o calendário mínimo de consultas de assistência à saúde recomendado pelo Ministério da Saúde, o que representa 68,20% do total de crianças nessa faixa etária (9.634). Para o alcance das metas pactuadas, as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) realizam visitas domiciliares, busca ativa de crianças com consultas em atraso e ações educativas que reforçam a importância do acompanhamento alimentar e nutricional. Nos territórios indígenas, a Vigilância Alimentar e Nutricional desenvolve ações contínuas, entre as quais se destacam: monitoramento de indicadores pelo Siasi; fortalecimento da segurança alimentar em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição; suplementação de ferro, vitamina A e NutriSUS para crianças; promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável; articulação interinstitucional para programas de apoio alimentar; integração entre práticas de medicinas indígenas tradicionais e nutrição, além da elaboração de materiais técnicos e educativos voltados à identificação e prevenção da desnutrição.

A investigação de óbitos é crucial para guiar medidas preventivas e, assim, diminuir a taxa de mortalidade. No entanto, vale destacar que esse indicador é sensível ao tempo de investigação, que pode se estender até quatro meses após o falecimento. Além disso, fatores culturais relacionados ao luto, que possui significado próprio entre os povos indígenas e pode restringir entrevistas com familiares, bem como a dificuldade de acesso a informações, especialmente em casos de óbitos hospitalares, podem atrasar o processo investigativo.

A **investigação de óbitos em crianças indígenas menores de um ano** permite identificar os fatores que influenciam na mortalidade infantil e a ocorrência de óbitos evitáveis. Sua investigação é obrigatória em todos os serviços de saúde e envolve várias etapas. As informações coletadas sobre esse indicador subsidiam a equipe de vigilância de óbitos e comitês de gestão a realizar análise das informações e orientar as intervenções para reduzir os óbitos evitáveis. No segundo trimestre de 2025, foram registrados 253 óbitos de crianças menores de um ano, sendo que 134 desses óbitos foram investigados, o que representa 52,96% dos registros. Vale destacar que, entre os distritos que realizaram investigações, sete alcançaram 100% de investigação dos óbitos, são eles: Altamira, Kaiapó do Mato Grosso, Manaus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Rio Tapajós, Vilhena e Xingu. Complementarmente, são monitorados indicadores relacionados à implantação do Grupo Técnico de Vigilância de Óbitos nos DSEI em que 27 deles relataram ter esse grupo implantado e ativo. Além disso, até agosto de 2025, 474 profissionais receberam capacitação sobre vigilância de óbitos.

Em relação ao **óbito materno**, é feito o monitoramento dos óbitos ocorridos durante a gestação ou até um ano após o seu término, devido às causas relacionadas ou agravadas no período gestacional, excluindo as acidentais ou incidentais, assistidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. No segundo trimestre de 2025, foram contabilizados 12 óbitos maternos, sendo oito investigados (66,66%). Além disso, são realizadas ações para a qualificação de profissionais de saúde no tema Vigilância do Óbito, com articulação junto a estados e municípios para a oferta de cursos, implantação do Grupo Técnico de Vigilância do Óbito nos DSEI e participação nos Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.

O monitoramento do indicador **percentual de gestantes indígenas com no mínimo uma consulta odontológica durante o pré-natal** tem como objetivo avaliar se as gestantes indígenas assistidas no pré-natal têm acesso ao atendimento e ao tratamento odontológico durante a gestação, na perspectiva da linha do cuidado integral, para diminuir possíveis agravos bucais durante a gestação. No período gestacional, o atendimento odontológico à gestante é fundamental, uma vez que elas têm um alto risco de desenvolver doenças periodontais em função da variação hormonal, que aumenta a possibilidade do processo inflamatório gengival. Ainda, é aumentado o risco de parto prematuro pela presença de doenças periodontais. Nos 34 DSEI, 50,47% das mulheres indígenas que completaram a gestação realizaram pelo menos uma consulta odontológica durante o pré-natal. Esse dado corresponde a 5.293 atendimentos registrados na Atenção Primária à Saúde (APS), realizados por cirurgiões-dentistas, e foi calculado com base nas gestações finalizadas, excluindo os casos de aborto (totalizando 10.486).

Em relação às ações voltadas para a saúde bucal da população indígena, os dados parciais registrados no Siasi até junho de 2025 revelam que foram realizadas 237.162 **primeiras consultas odontológicas programáticas** no período, alcançando o percentual de 28,87% de cobertura da população indígena (nº= 821.314) com primeira consulta odontológica programática.

De forma complementar, é monitorado o **percentual de tratamentos odontológicos básicos concluídos** na população indígena que realizou sua primeira consulta odontológica programática, com o objetivo de avaliar a resolutividade da assistência. De janeiro a junho de 2025, foram concluídos 121.371 tratamentos odontológicos básicos, representando 51,17% das 237.162 primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas.

Para melhorar o desempenho dos indicadores de saúde bucal, diversas estratégias estão sendo adotadas, como monitoramento mensal dos dados, devolutivas aos territórios, elaboração de planos de ação e intervenções direcionadas aos DSEI com desempenho abaixo da meta, acompanhadas de reuniões regulares para a construção conjunta de soluções. Também está em andamento a elaboração de um Manual de Diretrizes de Saúde Bucal para os DSEI, que trará estratégias específicas para o aprimoramento dos dados. No âmbito das ações de fortalecimento do pré-natal odontológico junto às equipes que atuam

na saúde indígena, destaca-se o curso de formação do programa Mais Médicos para o Brasil. Durante a capacitação, o tema foi abordado com os médicos que passariam a atuar nos territórios indígenas, visando promover o trabalho integrado das equipes e garantir cuidados integrais às gestantes indígenas. Entre os desafios, ressaltam-se as dificuldades logísticas e climáticas (como a seca amazônica), a alta rotatividade e ausência prolongada de profissionais de saúde bucal, falta de cobertura de licenças e férias de profissionais pelas conveniadas, além das limitações no transporte até as aldeias.

O indicador **proporção de DSEI com processo de monitoramento sistemático dos indicadores de saúde** mensura a proporção dos DSEI com oficina de implementação sistemática do monitoramento de indicadores de saúde nos DSEI ao longo do período de vigência do PDSI/PPA/PNS (2024-2027). Esta medida contribui para o monitoramento da implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas por meio da análise constante dos indicadores definidos. Portanto, após a fase de implementação, os DSEI passam a monitorar os indicadores pactuados no nível local de forma sistemática, criando estratégias e ações em saúde que considerem as especificidades locais, além de prevenir situações emergenciais de saúde pública. Até junho de 2025, foram realizadas oficinas em oito DSEI: Manaus, Bahia e Yanomami, Leste de Roraima, Guamá-Tocantins, Alto Rio Purus, Vilhena e Alagoas e Sergipe, com o objetivo de institucionalizar o processo de monitoramento sistemático dos indicadores, alcançando, assim, 23,52% dos DSEI com esse processo implementado.

Com relação às ações de saneamento, é monitorado o indicador referente às aldeias beneficiadas com obras de implantação ou reforma de infraestruturas de abastecimento de água. Este indicador é fundamental para quantificar a população atendida com algum sistema de abastecimento de água, uma vez que esses sistemas são projetados para suprir as necessidades de toda a comunidade. Esse acompanhamento também permite avaliar a qualidade da água distribuída, uma vez que a falta de sistemas adequados está diretamente relacionada às doenças de veiculação hídrica. No período de janeiro de 2024 a agosto de 2025, foram registradas 469 aldeias beneficiadas com **obras de infraestrutura de abastecimento de água potável**. Desse total, 247 correspondem à implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e 229 a reformas e ampliações. Durante esse período, foram realizadas diversas iniciativas, incluindo a instalação e ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, a construção de sistemas simplificados para abastecimento e a implementação de sistemas fotovoltaicos completos, com bombas solares para captação de água.

É acompanhado, também, o indicador de **coleta e análise da água para consumo humano**. A coleta e análise de água é uma atividade que deve ser realizada rotineiramente nas aldeias com sistemas de abastecimento de água implantados, assim como em mananciais utilizados pelas comunidades indígenas para seu uso cotidiano. Destaca-se que, no âmbito do subsistema de saúde indígena, a frequência em que as amostras são coletadas para análise da qualidade da água é influenciada pelas condições de acesso nas localidades onde estes sistemas estão em funcionamento, bem como pela capacidade de organização dos serviços de saneamento dos DSEI, incluída a logística necessária e a disponibilidade de profissionais contratados para executar as ações em todas as etapas necessárias. De janeiro a agosto de 2025, levando em conta os critérios de frequência na coleta de amostras e nos parâmetros analisados, constatou-se que 8,73% das aldeias realizaram a coleta e análise da água destinada ao consumo humano. Observa-se que nesse período foram efetuadas 6.465 visitas para a coleta e análise da qualidade da água em aldeias indígenas, abrangendo um total de 582 aldeias monitoradas. Alguns desafios persistem e impactam na execução das atividades, como dificuldades de deslocamento para acessar as áreas de atuação e a falta de insumos necessários para as análises em algumas equipes do DSEI, o que prejudica a realização das atividades programadas.

Além disso, estão sendo adotadas medidas para fortalecer as atividades de análise da qualidade da água incluindo a realização de reuniões periódicas com os DSEI para discutir os desafios e oportunidades, apresentar os resultados das análises e avaliar conjuntamente ações tomadas com base nesses resultados. Também estão sendo propostas parcerias com laboratórios locais para realizar análises onde não há equipe disponível, além de incentivar a capacitação dos profissionais envolvidos. Ainda, há orientações na instrução processual para a aquisição de equipamentos e insumos necessários para a realização das análises.

Objetivo 7. Aprimorar o cuidado à saúde, fortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde, e intensificar a incorporação da inovação e da saúde digital e o enfrentamento das discriminações e desigualdades de raça/etnia, de gênero, regionais e sociais.

Este objetivo tem como premissas estruturantes a defesa de condições, relações, processos e vínculos de trabalho, seguros, dignos e humanizados, transversalizados por ações de formação, qualificação e distribuição de ofertas de educação na saúde, além de contribuir para que a saúde digital possibilite a potencialização da gestão, pela melhoria da qualidade técnica e eficiência da assistência e pelo fortalecimento das atividades de disseminação de informações, armazenamento e troca de dados clínicos/terapêuticos e de favorecimento da comunicação interprofissional. Além disso, o objetivo tem ações de capacitação de lideranças dos movimentos sociais de promoção de políticas de equidade, conselheiros de saúde, gestores e trabalhadores da saúde em gestão participativa e controle social no SUS; e de fortalecimento do processo de transparência pública.

Quadro 38 – Resultados PAS: Objetivo 7 - 2º Quadrimestre de 2025

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
1. Ampliar o número de novas funcionalidades disponibilizadas no app e site do Meu SUS Digital.	Número de novas funcionalidades disponibilizadas no app e site do Meu SUS Digital.	Unidade	42	38	20YN (0001) 20YN (0004)	DataSUS/Seidigi/MS Estados, DF e Municípios
2. Desenvolver e disseminar conjuntos de painéis digitais de dados, indicadores e informações estratégicas em saúde, com base em software livre, por meio da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE).	Número de conjuntos de painéis disponibilizados na Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE).	Unidade	36	28	8753	Demas/Seidigi/MS Estados, DF e Municípios
3. Ampliar o número de atendimentos de telessaúde realizados.	Número de atendimentos de telessaúde realizados.	Unidade	4.200.000	4.082.223 ⁵⁶	21CF (0000) 21CF (0001) 21CF (0002)	Desd/Seidigi/MS Estados, DF e Municípios

⁵⁶ Retifica-se o número de atendimentos de telessaúde realizados, informado no 1º RQPC/2025 de 3.334.245 para 3.355.522. Justifica-se a retificação face à revisão do quantitativo realizada pela área técnica.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
4. Ampliar o percentual de categorias profissionais com demografias ⁵⁷ concluídas.	Percentual de categorias profissionais com demografias concluídas.	Percentual	42,86%	28,57% ⁵⁸	20YD (000J)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
5. Ampliar o número de instrumentos de planejamento e dimensionamento da força de trabalho no âmbito do SUS validados.	Número de instrumentos validados.	Unidade	1	0 ⁵⁹	20YD (000J)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
6. Ampliar o percentual de Mesas Estaduais e Municipais de Negociação Permanente do SUS aderidas ao Sistema Nacional de Negociação Permanente do SUS (SiNNP-SUS).	Percentual de Mesas Estaduais e Municipais de Negociação Permanente do SUS aderidas ao SiNNP-SUS.	Percentual	50%	20%	20YD (000C)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
7. Ampliar o número de gestores/trabalhadores certificados na área da gestão do trabalho no âmbito do SUS.	Número de gestores/trabalhadores certificados.	Unidade	270	367	20YD (000J)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
8. Ampliar o percentual de estados que implantaram o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador do SUS (PNAIST/SUS).	Percentual de estados que implantaram o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador do SUS (PNAIST/SUS).	Percentual	50%	0 ⁶⁰	20YD (0006)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios

⁵⁷ A demografia é um campo do conhecimento que trata da produção e interpretação de informações diversas sobre a população, a partir de meios como gráficos, tabelas e relatórios diversos. Nesse caso, a demografia das profissões tem como objetivo retratar a dinâmica da formação (panorama de cursos e vagas, alunos ingressantes e egressos, projeções de oferta de profissionais) e do mercado de trabalho das categorias profissionais da área da saúde (como medicina, odontologia, enfermagem e farmácia), evidenciando o número de profissionais (geral e por especialidade), a concentração e dispersão geográfica dos profissionais, entre outros. Dessa forma, no período previsto, será produzido um estudo demográfico para cada uma das quatro categorias profissionais mencionadas. O monitoramento será realizado a partir da aferição das publicações institucionais que contarão, por sua vez, com relatórios e publicações intermediárias.

⁵⁸ A meta de ampliar o percentual de categorias profissionais com demografias concluídas, visa aprofundar o conhecimento sobre a força de trabalho em saúde, fornecendo dados essenciais para o planejamento e a formulação de políticas públicas eficazes, garantindo uma compreensão abrangente da dinâmica profissional em diversas áreas da saúde. No período de 2024 a 2027, localizou-se a meta de realizar sete demografias das profissões de saúde. Até agosto de 2025, duas demografias foram concluídas e publicadas: a Demografia Médica de 2023, utilizada como referência inicial para a meta, representando 14,29% do total em 2024; e a Demografia Médica de 2025, publicada em abril de 2025, que elevou o progresso acumulado para 28,57% da meta estabelecida. Ressalta-se que a meta de 7 demografias é cumulativa ao longo do período de 2024-2027.

⁵⁹ Planejamento da Força de Trabalho no SUS visa estimar oferta e demanda de profissionais com base em indicadores e perfis, conforme Portaria GM/MS n.º 3.225/2024. Instrumentos são validados pela Comissão de Planejamento e Dimensionamento (CPDFT-SUS), avaliados pelo Grupo de Trabalho de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (GT GTES) e deliberados na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Houve avanços, como estudos demográficos, participação do MEC e formação de subgrupos. A próxima etapa envolve a Oficina de Validação para o Plano Decenal 2026–2035.

⁶⁰ As articulações para a implantação do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador da Saúde do SUS (PNAIST/SUS) foram retomadas em janeiro de 2025, com o objetivo de promover a adesão dos entes federados. Entretanto, o programa ainda se encontra em fase de elaboração e validação preliminar. Atualmente, o PNAIST/SUS está em deliberação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em conformidade com a Portaria GM/MS n.º 3.115/2024. As reuniões com os entes federados estão suspensas, aguardando a aprovação do programa.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
9. Ampliar a instituição dos espaços colegiados para fortalecer a gestão e a regulação do trabalho em saúde.	Número de reuniões realizadas após a instituição dos espaços colegiados	Unidade	40	48 ⁶¹	20YD (000C)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
10. Fomentar a produção científica na área da gestão e regulação do trabalho na saúde.	Número de projetos de pesquisa financiados.	Unidade	3	0 ⁶²	20YD (000J)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
11. Ampliar o número de qualificações de trabalhadores, gestores, estudantes e usuários em temas da área da saúde prioritários para o SUS.	Número de trabalhadores, gestores, estudantes e usuários qualificados.	Unidade	1.063.000	888.675 ⁶³	20YD (0002) 20YD (0003) 20YD (0004)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
12. Ampliar o número de bolsas financiadas do Programa de Educação para o Trabalho na Saúde (PET-Saúde).	Número de bolsas financiadas pelo Programa de Educação para o Trabalho na Saúde (PET-Saúde).	Unidade	8.261	8.249 ⁶⁴	20YD (0003)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
13. Ampliar o número de projetos executados de Vivências no SUS.	Número de Projetos de Vivências no SUS executados.	Unidade	100	7	20YD (0003)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
14. Ampliar o número de bolsas de residência médica e de residência em área profissional da saúde financiadas pelo MS.	Número de bolsas de residência médica e residência em área profissional da saúde financiadas pelo MS.	Unidade	28.000	30.648	20YD (000I)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
15. Ampliar o percentual de preceptores e gestores de programas de residências em saúde qualificados.	Percentual de preceptores e gestores de programas de residências em saúde qualificados.	Percentual	100%	42,80%	20YD (000I)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
16. Ampliar o número de bolsas de incentivo à preceptoria de residência médica e de	Número de bolsas de incentivo à preceptoria de residência médica e de	Unidade	3.000	2.490	20YD (000I)	SGTES/MS

⁶¹ Retifica-se o número de espaços colegiados, informado no 1º RQPC/2025 de 34 para 41. Justifica-se a retificação face à revisão do quantitativo realizada pela área técnica.

⁶² A meta busca fomentar a produção científica na área de gestão e regulação do trabalho na saúde, por meio da implantação de um observatório, previsto na Meta 4 do TED n.º 140/2023, firmado com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com vigência até 07/06/2026. O relatório parcial do TED aponta 60% de cumprimento, com a entrega do levantamento de observatórios, o mapeamento da produção científica e o projeto técnico do Observatório de Trabalho e Educação na Saúde (ObservaTES). Apesar dos avanços na fase de concepção, a reativação da Rede Observatório permanece suspensa. Até agosto de 2025, as tratativas entre o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde (DEGERTS/SGTES) e a UFBA seguem pendentes de encaminhamentos formais, condicionadas à proposição de reuniões que viabilizem a apreciação e continuidade da iniciativa.

⁶³ Retifica-se o número de trabalhadores, gestores, estudantes e usuários qualificados, informado no 1º RQPC/2025 de 728.706 para 737.305. Justifica-se a retificação face à revisão do quantitativo realizada pela área técnica.

⁶⁴ Em 2024, o número de bolsas financiadas pelo O PET-Saúde foi de 8.261. No período de janeiro a agosto de 2025 foi de 8.249 bolsas financiadas. A redução deve-se à solicitação do projeto de Rondônia, intitulado "Análise das desigualdades em saúde entre trabalhadores/as de saúde: estratégias para promoção da equidade de gênero em Porto Velho, Rondônia", que requisitou a exclusão de 12 bolsas, em razão da insuficiência de inscritos nos processos seletivos e nas cartas-convite conduzidos pela Universidade Federal de Rondônia, o que impactou diretamente os dados do ciclo de 2025.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
residência em área profissional da saúde financiadas pelo MS.	residência em área profissional da saúde financiadas pelo MS.					Estados, DF e Municípios
17. Ampliar o número de estratégias visando a implantação do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde (SUS) para o enfrentamento às iniquidades em saúde.	Número de estratégias implantadas.	Unidade	61	49	20YD (000K)	SGTES/MS Estados, DF e Municípios
18. Implantar novos componentes no Sistema Nacional de Auditoria (SNA).	Número de novos componentes implantados no SNA.	Unidade	295	302	8708	DenaSUS/GM/MS Estados, DF e Municípios
19. Realizar auditorias de natureza operacional nas políticas e programas de saúde do Ministério da Saúde.	Número de auditorias de natureza operacional realizadas.	Unidade	2	0 ⁶⁵	8708	DenaSUS/GM/MS Estados, DF e Municípios
20. Aumentar o percentual de manifestações respondidas ao cidadão em até 30 dias do recebimento na Ouvidoria-Geral do SUS.	Percentual de manifestações respondidas ao cidadão em até 30 dias do recebimento.	Percentual	65%	61,25%	6182 (0002) 6182 (0003)	OuvSUS/GM/MS Estados, DF e Municípios
21. Ampliar o número de serviços de apoio à atenção da saúde da pessoa com câncer e da pessoa com deficiência beneficiados pelo PRONON e/ou PRONAS-PCD.	Número de serviços de apoio à atenção da saúde da pessoa com câncer e da pessoa com deficiência beneficiados pelo PRONON e/ou PRONAS-PCD ampliados.	Unidade	2.650	2.393	21EC	Decoop/SE/MS Estados, DF e Municípios
22. Aumentar o número de entes federados com Relatório de Gestão encaminhado para apreciação no Conselho de Saúde.	Número de entes federados com Relatório de Gestão encaminhado para apreciação no Conselho de Saúde.	Unidade	4.756	4.812	8287	Dgip/SE/MS Estados, DF, Municípios e Conselhos de Saúde
23. Ampliar o número de participantes nas iniciativas de educação permanente e/ou educação popular em saúde.	Número de participantes nas iniciativas de educação permanente e/ou educação popular em saúde.	Unidade	11.000	7.954	8287	Dgip/SE/MS Estados, DF, Municípios e Conselhos de Saúde

⁶⁵O DenaSUS vem atuando com reuniões semanais regulares. Nos meses de maio e junho de 2025, foi definido o objetivo provisório da auditoria: avaliar a eficácia do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), nos ciclos de 2023/2024. As matrizes de planejamento e de risco foram devidamente concluídas para subsidiar as etapas subsequentes da auditoria. O final da auditoria está previsto para dezembro de 2025.

Meta	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2025	Realizado 2025 (jan. a ago.)	Ação Orçamentária com PO	Responsáveis
24. Aumentar o número de alunos concluintes nas ações formativas para redução das desigualdades regionais e sociais em saúde.	Número de alunos concluintes nas ações formativas para redução das desigualdades regionais e sociais em saúde.	Unidade	29.576	42.691	20YD	Fiocruz Estados, DF e Municípios

Informações Adicionais

Este Objetivo possui 24 metas, sendo 14 monitoradas pela SGTES, três pela Seidigi, duas pelo Dgip, duas pelo DenaSUS, uma pela OuvSUS, uma pelo Decoop e uma pela Fiocruz. Em relação à evolução do alcance das metas, o quadro abaixo demonstra o desempenho da execução, divididos em cinco intervalos percentuais, considerando a previsão para o final do exercício de 2025 conforme a Programação Anual de Saúde (PAS). Ressalta-se que esse resultado reflete as políticas públicas executadas de forma ampla, ou seja, aquelas que envolvem os esforços de todas as esferas de gestão do SUS.

Faixa	% de Alcance das Metas da PAS 2025	
	Quantidade	%
Até 25%	5	20,83%
Acima de 25% até 50%	2	8,33%
Acima de 50% até 75%	2	8,33%
Acima de 75% até 100%	9	37,50%
Acima de 100%	6	25,00%
Total	24	100,00%

Consideram funcionalidades e aplicações de referência as disponibilizadas no âmbito das plataformas do Meu SUS Digital e refletidas nas plataformas SUS Digital Profissional e SUS Digital Gestor. A incorporação de **novas funcionalidades disponibilizadas nas plataformas SUS Digital** é um processo complexo que envolve vasta quantidade de etapas e atores.

Cabe destacar que a linha de base utilizada para o cálculo é de 30 e, considerando o resultado de janeiro de 2024 a agosto de 2025, foram lançadas oito novas funcionalidades no aplicativo e site do Meu SUS Digital, das quais seis estão disponibilizadas na plataforma do Meu SUS Digital e duas na plataforma do SUS Digital Profissional. Destas, seis foram implementadas em 2024 e duas em 2025, conforme a seguir:

a) Meu SUS Digital:

Funcionalidades disponibilizadas em 2024:

- "Dignidade Menstrual": operacionaliza digitalmente a política de distribuição gratuita de absorventes à população em condições de vulnerabilidade pelo Programa Farmácia Popular.
- "Novo Hemovida": relançamento de nova plataforma com atualizações e revisões.
- "Autodeclarações (raça/cor, nome social, endereço e telefone)": inclusão de campos no Meu SUS Digital para inclusão das informações pelo próprio usuário da plataforma (embora haja quatro tipos de informações específicas, configuradas como apenas uma funcionalidade).
- "International Patient Summary ou Sumário Internacional do Paciente (IPS)": permite, com o consentimento do usuário, o compartilhamento de dados básicos de saúde com profissionais de saúde de outros países, em contexto de atendimento, com base em modelo de informação e computacional nos padrões recomendados pela OMS.

Funcionalidades disponibilizadas de janeiro de 2025 a agosto de 2025:

- "Miniapp "Caderneta da Criança": permite o acompanhamento do calendário vacinal com os registros das vacinas, as que estão pendentes e as futuras.
- "Agora Tem Especialistas": Implementada em maio de 2025, a funcionalidade permite ao usuário acompanhar, em tempo real, o status dos seus atendimentos no programa Agora Tem Especialistas, da consulta ao tratamento, com base nos dados integrados da RNDS, vinculadas às Ofertas de Cuidado Integral (OCI), proporcionando transparência e continuidade do cuidado especializado.

b) SUS Digital Profissional:

Funcionalidades disponibilizadas em 2024:

- "Busca Ativa de Vacinas": permite a busca ativa por profissionais da APS de pacientes que estão com o calendário desatualizado.

- "Guia de Mudanças Climáticas": inclusão de conteúdo para profissionais de saúde que auxiliem no combate e prevenção de doenças com base em mudanças climáticas.

Assim, até o 2º quadrimestre de 2025, totalizaram-se 38 novas funcionalidades disponibilizadas nas plataformas SUS Digital.

A Sage é uma plataforma on-line, com **conjuntos de painéis digitais de dados** e informações estratégicas em saúde, dinâmicos e atualizados. Distribuídos em macrotemas e temas, esses conjuntos de painéis possibilitam o acompanhamento de ações de saúde pública (políticas, programas, planos, projetos, estratégias, etc.) e apoiam a elaboração de análises contextuais para a formulação, avaliação e correção de estratégias. A ferramenta é um instrumento essencial para o monitoramento e avaliação da gestão, como também para o acompanhamento para gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, cidadãos e movimentos sociais. Entre janeiro de 2024 e agosto de 2025, foram publicados 28 conjuntos de painéis no portal Sage, divididos em cinco macrotemas, conforme a seguir:

1. Estabelecimentos e Profissionais: apresenta o número de estabelecimentos e profissionais de saúde por tipo e categoria, a partir dos seguintes temas: Cnes Estabelecimentos e Cnes Profissionais (dois conjuntos de painéis) publicados em 2024.
2. Políticas, Programas, Projetos, Estratégias e Ações: apresenta intervenções em saúde com intenção de mudar determinada situação e seu resultado, a partir dos seguintes temas: Saúde Digital (dois conjuntos de painéis); Política Nacional de Saúde Bucal (dois conjuntos de painéis); Programa Nacional de Imunizações (três conjuntos de painéis); outras políticas, programas, projetos, estratégias e ações (11 conjuntos de painéis); totalizando 18 conjuntos de painéis publicados em 2024 e, somando-se ao Índice de Dependência Regional em Oncologia (um conjunto de painel) publicado em 2025, totalizaram-se 19 conjuntos de painéis. Destaca-se que, em julho, o painel referente ao Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), passou a se chamar Agora Tem Especialistas (ATE), o qual incorporou as informações dos dois programas.
3. Situação dos Instrumentos de Planejamento do SUS: apresenta informações sobre os Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde e sobre os Relatórios de Gestão, a partir dos seguintes temas: Instrumentos Municipais; Instrumentos Estaduais; Instrumentos por Região do Brasil; Instrumentos por UF; Documentos; e links para mais informações (um conjunto de painel) publicado em 2024.
4. Obras: apresenta informações financeiras e de execução das obras financiadas pelo governo federal, a partir dos seguintes temas: Academia da Saúde; Unidade Básica de Saúde (UBS); Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h); Visão geral das propostas no Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob); totalizando quatro conjuntos de painéis publicados em 2024 e, somando-se ao Novo PAC (um conjunto de painel) publicado em 2025, totalizaram-se cinco conjuntos de painéis.
5. Informações Orçamentárias: apresenta informações consolidadas dos dados de gastos públicos em saúde, permitindo o acompanhamento transparente da distribuição e execução do orçamento, a partir do seguinte tema: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (um conjunto de painel) publicado em 2025.

A **telessaúde** é uma estratégia de grande importância para o fortalecimento das políticas nacionais. Sua utilização amplia o acesso da população a cuidados especializados, reduz barreiras geográficas, facilita a fixação de profissionais em áreas remotas e contribui para a qualificação dos profissionais de saúde. Entre os fatores que favorecem a oferta de atendimentos à população, destacam-se a agilidade na emissão de laudos, o acesso rápido a profissionais de saúde especialistas, o aumento da capacidade da utilização dos serviços, a satisfação dos usuários e a cobertura de comunidades e regiões com escassez de especialistas.

A expansão da Rede Brasileira de Telessaúde representa um avanço significativo na ampliação dos serviços ofertados, especialmente no âmbito daqueles realizados por meio da Oferta Nacional de Telediagnóstico. Essa iniciativa é conduzida pela Seidigi em parceria com os Núcleos de Telessaúde da UFMG, UFG e UFSC, com foco no telediagnóstico e emissão de laudos de eletrocardiograma, retinografia e dermatologia, respectivamente.

No ano de 2024, registraram-se 2.526.196 atendimentos de telessaúde, somando-se ao resultado do período de janeiro a julho de 2025 (1.556.027), obtém-se o resultado cumulativo de 4.082.223 atendimentos realizados. Informa-se que os dados até julho de 2025 foram apurados em 31/8/2025.

Destaca-se que a Ação Estratégica SUS Digital – Telessaúde, no âmbito do Programa SUS Digital, inclui serviços de telediagnóstico, teleconsultoria síncrona e assíncrona, teleeducação, teletriagem, teleconsulta, telemonitoramento, teleinterconsulta, telerregulação e teleorientação. Estes serviços contemplam população indígena, população idosa, quilombolas, população ribeirinha, rural, dentre outras populações específicas.

Informa-se que a interação com os serviços de telessaúde é oportunizada por meio da organização dos fluxos dos modelos de cuidado preconizados pela gestão local dos municípios e estados, assim, o volume de atendimentos é dependente da indução local para o uso dos serviços. Esta pasta ministerial é um ente indutor das ações de telessaúde, não sendo responsável pelo planejamento e execução dos serviços de telessaúde nos territórios.

Atendimentos de Telessaúde Realizados					
AC	80.830	MA	12.059	RJ	2.905
AL	197	MG	1.392.446	RN	20.426
AM	31.203	MS	113.329	RO	833
AP	78	MT	184.242	RR	19.410
BA	485.024	PA	24.032	RS	67.193
CE	167.163	PB	1.511	SC	847.630
DF	9	PE	307.040	SE	193
ES	1.180	PI	23.765	SP	293
GO	157.707	PR	126.586	TO	14.939
Brasil: 4.082.223					

Data de apuração: 31/8/2025.

Fonte: Departamento de Saúde Digital e Inovação (Desd/Seidigi/MS).

O número de gestores e trabalhadores certificados na gestão do trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra a importância da qualificação para garantir a eficácia da gestão e a melhoria da qualidade da assistência à saúde. A Formação em Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho fortalece a autonomia local na aplicação de metodologias específicas, respondendo a demandas históricas e contando com acompanhamento técnico. O curso contempla módulos teóricos e práticos com acompanhamento de tutores e gestores, tendo seu encerramento com a entrega dos relatórios finais de intervenção. Paralelamente, a qualificação para a proteção social no trabalho, respaldada pelo Decreto n.º 12.122/2024 e pela Portaria GM/MS n.º 6.638/2025, ampliou a certificação na prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, com 367 profissionais certificados em 2025, superando em 35,93% a meta prevista para o ano (270). Tal resultado decorre da ampla adesão, do formato remoto, da articulação com parceiros e da divulgação direcionada, ampliando o impacto e promovendo ambientes laborais mais justos e seguros na saúde.

Os espaços colegiados desempenham papel fundamental na tomada de decisão coletiva na área da saúde, reunindo diversos atores — como representantes governamentais, conselhos profissionais, sindicatos e organizações da sociedade civil — e garantindo pluralidade na gestão e regulação do trabalho em saúde. Esses espaços podem ser consultivos, quando emitem opiniões, ou deliberativos, quando tomam decisões vinculantes. A instituição dos espaços colegiados para fortalecer a gestão e a regulação do trabalho em saúde é, portanto, essencial para promover decisões mais representativas e eficazes. O Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde (Degerts) monitora o funcionamento desses colegiados, acompanhando reuniões e deliberações. Os espaços colegiados instituídos são: Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS), Comissão para Discussão e Elaboração de Proposta de Carreira no SUS (CDEPCA), Comissão Gestora do Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e às Discriminações no Trabalho na Saúde (PEADTS), Comissão Nacional para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho no SUS (CPDFT-SUS), Grupo de Trabalho sobre Práticas Avançadas de Enfermagem (GT-PAE), Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS) e a Comissão Técnica para elaboração da proposta do Programa Nacional de Atenção

Integral à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do SUS (PNAIST). As reuniões são fundamentais para fortalecer esses processos, promovendo decisões mais eficazes e inclusivas ao integrar múltiplas perspectivas. Até agosto de 2025, foram realizadas 48 reuniões desses colegiados, distribuídas entre os diversos grupos, ultrapassando em 20% a meta prevista para o ano (40). Inicialmente, a meta previa a implementação de quatro espaços colegiados com quatro reuniões anuais cada, mas foram criados três novos colegiados — dois em 2024 e um em 2025 — o que aumentou o total de reuniões e impactou diretamente os resultados do monitoramento.

Qualificações de trabalhadores, gestores, estudantes e usuários em temas prioritários da área da saúde para o SUS têm sido ampliadas desde 2024, com certificações emitidas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), principalmente por meio da plataforma Educação a Distância da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e do Programa de Formação de Agentes Educadores Populares de Saúde (AgPopSUS). A formação de recursos humanos no SUS abrange qualificação, capacitação e educação permanente, visando alinhar as competências dos profissionais às demandas das comunidades. Até o final de 2024, foram registradas 509.364 qualificações, e de janeiro a agosto de 2025, 379.311, totalizando 888.675, que estão distribuídas da seguinte forma:

Número de Qualificações por UF							
AC	12.922		MG	88.779		RO	19.027
AL	12.200		MS	16.451		RR	3.677
AM	17.127		MT	15.956		RS	42.726
AP	3.314		PA	32.428		SC	19.477
BA	51.520		PB	19.631		SE	13.055
CE	43.219		PE	58.603		SP	111.872
DF	17.657		PI	15.943		TO	9.088
ES	23.391		PR	54.782		EX - Exterior	182
GO	28.821		RJ	56.592		Não Identificado	60.018
MA	26.182		RN	14.035		-	
Total: 888.675							

Data de apuração: 9/9/2025.
Fonte: Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges/SGTES/MS).

Na agenda estratégica de formação de especialistas, destacam-se os programas de financiamento de **bolsas de residência**: o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência Médica) e o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Pró-Residência em Área Profissional da Saúde). O Ministério da Saúde financia bolsas para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que possuam programas de residência devidamente credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Vale destacar que os editais para concessão de bolsas são publicados ao final de cada ano, com ingresso dos residentes no início do ano seguinte. Historicamente, existe a tendência de alta adesão no início do ano, seguida por uma redução gradual no número de bolsistas ao longo dos meses, o que pode ser atribuído a desligamentos ou conclusões dos programas de residência. Ressalta-se que, nos casos de afastamento temporário, o residente não recebe bolsa, embora sua matrícula permaneça ativa. Até agosto de 2025, foram registrados 30.648 residentes ativos com bolsas financiadas por ambos os programas, representando 109,46% da meta prevista para o ano.

Pró-Residência Médica					
AC	8	MA	77	RJ	2267
AL	282	MG	2487	RN	86
AM	149	MS	278	RO	50
AP	9	MT	209	RS	868
BA	518	PA	468	RR	-
CE	627	PB	474	SC	851
DF	287	PE	525	SE	171

Residência em Área Profissional de Saúde					
AC	-	MA	113	RJ	802
AL	69	MG	739	RN	76
AM	85	MS	287	RO	337
AP	-	MT	30	RS	611
BA	415	PA	368	RR	-
CE	1171	PB	337	SC	366
DF	538	PE	627	SE	13

Pró-Residência Médica					
ES	534	PI	82	SP	6420
GO	615	PR	1450	TO	90
Brasil: 19.882					

Data de apuração: 5/9/2025.
Fonte: Deges/SGTES/MS.

Residência em Área Profissional de Saúde					
ES	389	PI	197	SP	2206
GO	124	PR	677	TO	189
Brasil: 10.766					

O **Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do SUS** registrava, até maio de 2025, 56 estratégias, sendo 54 originárias de 24 projetos celebrados, além da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e de um módulo formativo da Educação a Distância da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). Cada projeto pode contemplar múltiplas estratégias e abranger mais de um eixo programático: formação e qualificação; enfrentamento às diversas formas de violência, preconceito e discriminação no trabalho em saúde; comunicação em saúde; e pesquisa em saúde. Em junho, esse número foi reduzido para 49 estratégias. Essa redução ocorreu devido ao cancelamento de três convênios por desistência das proponentes — dois da Escola de Saúde Pública do Ceará e um da Secretaria Municipal de São Cristóvão/SE — motivada por dificuldades nos processos licitatórios, o que diminuiu os projetos celebrados de 24 para 21. Assim, esses 21 projetos correspondem a 47 estratégias, que, somadas à pesquisa da FGV e ao módulo da UNA-SUS, totalizam 49 estratégias executadas até agosto de 2025.

O **Sistema Nacional de Auditoria (SNA)** atua em todos os níveis de governo. O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), enquanto órgão central do SNA, é responsável pela condução da atividade de auditoria no âmbito Federal e também por apoiar a implantação de componentes⁶⁶ nos demais níveis de governo: as secretarias de saúde das esferas estadual e municipal. Até agosto de 2025, foram implantados 302 componentes, sendo 287 em 2024 e 15 no período de janeiro a agosto de 2025, ultrapassando a meta estabelecida para 2025 em 2,37%. Demonstra-se a seguir 14 Secretarias Municipais de Saúde e um Departamento Municipal de Saúde que estão com componentes implantados:

2025	Secretarias Municipais de Saúde
Fevereiro	Cruz das Almas/BA Varginha/MG Atibaia/SP Limeira/SP São Manuel/SP Bastos/SP
Março	Ipatinga/MG
Abril	Camaragibe/PE
Maio	Presidente Jânio Quadros/BA Colatina/ES
Julho	Olímpia/SP Manicoré/AM Catu/BA
Agosto	Itirapina/SP

2025	Departamento Municipal de Saúde
Julho	Pariquera-Açu/SP

As implantações foram realizadas em decorrência das atividades de cooperações técnicas entre o DenaSUS e os entes. De janeiro a agosto de 2025, foram realizadas 37 atividades, as quais visaram apoio à implantação e implementação de componentes, bem como o fortalecimento do SNA. Além disso, o DenaSUS

⁶⁶ Os componentes são unidades de auditoria interna do SUS localizadas em cada nível de governo, sob a supervisão da respectiva direção do SUS e integram o Sistema Nacional de Auditoria (SNA).

disponibiliza um formulário que visa registrar os pedidos de componentes ou entes que necessitam de apoio com assuntos relacionados ao SNA, como a implantação de novos componentes.

O **Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon)** e o **Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas-PCD)** possuem um papel essencial na ampliação do acesso a tratamentos oncológicos e à reabilitação para pessoas com deficiência, ou seja, são como instrumentos estratégicos de fortalecimento da saúde especializada no Brasil. Até agosto de 2025, houve 2.393 instituições participantes, sendo 507 do Pronon e 1.886 do Pronas-PCD.

O Ministério da Saúde adotou uma estratégia nacional estruturada em três eixos:

1. Simplificação dos processos de adesão, eliminando entraves administrativos.
2. Intensificação da comunicação institucional, com foco nos incentivos fiscais disponíveis.
3. Fortalecimento de parcerias institucionais, priorizando qualificação técnica das organizações e articulação com políticas públicas.

Assim, houve iniciativas de modernização do processo de credenciamento dos programas, permitindo que ocorra tanto por requerimento prévio quanto por submissão dos projetos. Além disso, foram realizadas capacitações nos estados de Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão e Rio Grande do Sul, alcançando 170 representantes de organizações da sociedade civil.

Essas iniciativas buscam ampliar o número de instituições habilitadas, além de potencializar a oferta de serviços no SUS, alinhadas à Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) e à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD).

O **Relatório de Gestão** é um importante instrumento de planejamento, previsto em lei, por meio do qual é feita avaliação do alcance de metas estabelecidas na Programação Anual de Saúde, que por sua vez operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde, instrumento central do planejamento no SUS. Para auxiliar os entes federados na elaboração desses relatórios para posterior encaminhamento aos respectivos conselhos de saúde, foram realizados, entre janeiro e agosto de 2025, 95 eventos relacionados ao planejamento em saúde no SUS, como: reuniões com áreas técnicas do Ministério da Saúde e com os técnicos dos Serviços de Articulação Interfederativa e Participativa (Seinp), vinculadas às Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde (Sems), ciclos de debates, treinamentos, seminários e oficinas, além de reuniões com secretarias de saúde, órgãos de controle, cooperações técnicas, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e conselhos de saúde. Informa-se que, de janeiro a agosto de 2025, 4.812 entes federados encaminharam o relatório de gestão para apreciação no conselho de saúde, representando 101,18% da meta prevista para o ano. Desse total, 23 referem-se às unidades federativas (AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e TO) e 4.789 eram municípios. Registra-se que se consideram 5.568 municípios. Não estão considerados nesse total Brasília e Fernando de Noronha que, embora possuam códigos no IBGE característicos de municípios, não se configuram como tal.

Três fatores foram determinantes para o resultado desta meta:

1) atuação dos técnicos dos Serviços de Articulação Interfederativa e Participativa (Seinp), vinculadas às Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde (SEMS), junto aos gestores, técnicos e conselheiros de saúde em seus respectivos estados.

2) processos formativos ofertados pelo Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa (Dgip/SE) aos gestores, técnicos e conselheiros de saúde sobre elaboração de plano de saúde, nos quais foram feitas referências aos demais instrumentos de planejamento, quais sejam, programação anual de saúde e relatório de gestão.

3) determinações judiciais para que o repasse de recursos de emendas parlamentares esteja vinculado a metas descritas no plano de saúde; anualizadas na programação anual de saúde e com a devida prestação de contas no relatório de gestão.

Quantidade de Relatórios de Gestão Encaminhados aos Conselhos de Saúde					
AC	18	MA	135	RJ	86
AL	97	MG	741	RN	153
AM	56	MS	71	RO	53
AP	8	MT	115	RR	13
BA	281	PA	114	RS	496
CE	158	PB	192	SC	259
DF	1	PE	157	SE	62
ES	75	PI	188	SP	564
GO	234	PR	358	TO	127
Brasil: 4.812					

Data de apuração: 31/8/2025.

Fonte: Dgip/SE/MS.

A **ampliação do número de participantes nas iniciativas de educação permanente e/ou educação popular em saúde** contribui para o fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e a retomada da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Essa expansão mobiliza os atores do SUS, incluindo conselheiros de saúde, gestores, trabalhadores da saúde, integrantes de movimentos sociais e populares, agentes de saúde, lideranças comunitárias e usuários do SUS, em torno de uma agenda de gestão compartilhada, que subsidia os processos de planejamento, gestão e avaliação da Política. Até agosto de 2025, diversas iniciativas foram realizadas em duas temáticas. A primeira, focada na Participação e Educação Popular em Saúde, enfatizou a defesa do SUS, o direito à saúde e o cuidado integral, contando com 3.684 participações, sendo 792 em 2024 e 2.892 no período de janeiro a agosto de 2025. A segunda temática abordou estratégias e dispositivos de Educação Permanente, visando o fortalecimento da gestão interfederativa e participativa, o apoio institucional da gestão federal do SUS e o planejamento ascendente em saúde, registrando 4.270 participações, sendo 2.030 em 2024 e 2.240 no período de janeiro a agosto de 2025. O total geral acumulado até agosto de 2025 foi de 7.954 participações.

A **redução de desigualdades regionais e sociais em saúde** está entre as ações prioritárias da gestão. Com vistas a auxiliar nessa tarefa, algumas ações formativas vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até agosto de 2025, 42.691 alunos concluíram cursos de qualificação nessa temática, sendo 25.510 em 2024 e 17.181 no período de janeiro a agosto de 2025. Informa-se que 42.443 foram certificados em cursos no formato autoinstrucional, sendo 23.778 com ênfase no enfrentamento das desigualdades sociais e doenças infecciosas e negligenciadas e 18.665 em letramento digital e transformação digital. Destacam-se, além disso, 190 mestres formados pelo curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família e 58 mestres formados pelo Programa Educacional em Vigilância em Saúde das Fronteiras (VigiFronteiras). Ainda, cabe destacar que a meta foi superada em 44,34% do esperado para o ano (29.576). Tal execução reflete o avanço contínuo na execução das ações formativas voltadas à promoção da equidade em saúde. Destaca-se o elevado número de concluintes nos cursos autoinstrucionais, que superam largamente as metas acumuladas e demonstram o impacto positivo das estratégias de engajamento e da ampla divulgação das ofertas, além da manutenção das metas dos programas de formação stricto sensu. A atuação coordenada entre Ministério da Saúde, Fiocruz e parceiros institucionais tem sido essencial para garantir não apenas o alcance quantitativo, mas também a qualidade, a capilaridade e a relevância das formações ofertadas, que contribuem fundamentalmente para o avanço contínuo da equidade em saúde no Brasil.

Número de Alunos Concluintes nas Ações Formativas para Redução das Desigualdades Regionais e Sociais em Saúde					
AC	281	MA	1.082	RJ	5.798
AL	603	MG	3.973	RN	547
AM	800	MS	667	RO	521
AP	207	MT	504	RR	248
BA	2.980	PA	1.410	RS	1.607

Número de Alunos Concluintes nas Ações Formativas para Redução das Desigualdades Regionais e Sociais em Saúde							
CE	2.219		PB	772		SC	1.211
DF	1.694		PE	2.259		SE	1.015
ES	1.300		PI	797		SP	5.688
GO	1.204		PR	1.878		TO	403
EX – Exterior: 1.023							
Total: 42.691							

Data de apuração: 1º/9/2025.
Fonte: Fiocruz.

ANEXO

Anexo I – Atividades de Auditoria Interna do SUS – 2º Quadrimestre de 2025

Dentre as competências do DenaSUS, destacam-se a execução das atividades de auditoria interna, com o objetivo de avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos federais, no âmbito do SUS, bem como as atividades de cooperação técnica, com o objetivo de integrar os componentes do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA), sendo o DenaSUS coordenador do Sistema.

Auditoria Interna

As atividades de auditoria interna incluem auditorias, inspeções, visitas técnicas, monitoramentos e procedimentos de análise informatizada, tendo como objetivo avaliar a regularidade, a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações e serviços de saúde. A seguir, apresentamos uma visão geral das Atividades de Auditoria Interna Encerradas até o 2º quadrimestre de 2025 – Por tipo de Atividade.

Quadro 39 – Atividades Encerradas até o 2º Quadrimestre de 2025 – Por Atividade

Atividade	Total
Auditoria	61
Monitoramento	01
Visita Técnica	31
Total Geral	93

OBS.: Informações acumuladas de janeiro a agosto de 2025.

Fonte: Sisaud/SUS. Dados extraídos em 1º/9/2025.

Ao realizar as atividades programadas, é essencial definir o foco principal da ação, denominado objeto. Este pode abranger a avaliação de programas, políticas, sistemas, componentes de financiamento, dentre outros, no âmbito do SUS. A seguir, apresentamos uma visão geral dos objetos avaliados pelo DenaSUS, até o 2º quadrimestre de 2025, categorizados por componentes de financiamento.

Quadro 40 – Atividades Encerradas até o 2º Quadrimestre de 2025 – Por Objeto

Objeto	Total
Atenção Básica	07
Gestão	02
Média e Alta Complexidade	78
Fora de Bloco de Financiamento	06
Total Geral	93

OBS.: Informações acumuladas de janeiro a agosto de 2025.

Fonte: Sisaud/SUS. Dados extraídos em 1º/9/2025.

As atividades de auditoria realizadas, em sua maioria, envolvem a avaliação da conformidade na execução de determinada política, programa ou ação, que consiste em verificar se o objeto auditado está em consonância com os critérios estabelecidos em normas gerais que regem a Administração Pública, bem como em procedimentos operacionais específicos do rol de normativos do SUS, que abrange portarias, resoluções, políticas e diretrizes. Em síntese, objetiva demonstrar se um determinado objeto está em conformidade com o seu referencial normativo. A seguir, apresentamos uma visão geral das conformidades identificadas pelo DenaSUS até o 2º quadrimestre de 2025.

Quadro 41 – Classificação das Constatações das Atividades de Auditoria – até o 2º Quadrimestre de 2025

Classificação das Constatações	Conformidade		
	Conforme	Não Conforme	Total Geral
Assistência Farmacêutica	2	5	7
Assistência Farmacêutica - Componente Especializado	2	1	3
Armazenamento/Controle de estoques/Validade	2	1	3

Classificação das Constatatóes	Conformidade		
	Conforme	Não Conforme	Total Geral
Assistência Farmacêutica - Medicamentos estratégicos		1	1
Dispensação		1	1
Assistência Farmacêutica Básica		3	3
Armazenamento/Controle de estoques/Validade		1	1
Documentação/Cadastro		1	1
Financiamento		1	1
Assistência Média e Alta Complexidade	103	290	393
Assistência Ambulatorial	13	65	78
Acesso/Atendimento à Demanda		1	1
Capacidade Instalada/Cadastro	3	11	14
Documentação/Prontuários	2	14	16
Estrutura Física Instalações/Conservação		2	2
Faturamento/Produção/Cobranças SUS	5	28	33
Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas	1	3	4
Recursos Humanos	2		2
Recursos Materiais/equipamentos		1	1
Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas		5	5
Assistência Hospitalar	19	69	88
Acesso/Atendimento à Demanda		3	3
Capacidade Instalada/Cadastro	1	1	2
Contratualização		9	9
Documentação/Prontuários	4	7	11
Faturamento/Produção/Cobranças SUS	13	43	56
Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas	1	6	7
Assistência Hospitalar/Ambulatorial	71	156	227
Acesso/Atendimento à Demanda	6	14	20
Contrato	1	1	2
Documentação/Prontuários	19	27	46
Estrutura Física Instalações/Conservação	2		2
Faturamento/Produção/Cobranças SUS	28	71	99
Normas/Rotinas/Protocolos/Comissões Internas	14	43	57
Satisfação do Usuário	1		1
Atenção Básica	6	16	22
ESF – PACS/PSF	2	2	4
Capacitação	1	1	2
Carga Horária		1	1
Composição Equipes	1		1
Processo de Trabalho	3	14	17
Monitoramento/Acompanhamento/Avaliação	1	8	9
Outras Atividades (Visitas/Rotinas/Acolhimento)	1	5	6
Registros/Cadastro	1	1	2
Unidades Básicas de Saúde	1		1
Estrutura Física	1		1
Atenção Primária	6	45	51
Saúde Mental	6	45	51
Atendimento e Continuidade do Cuidado	2	18	20
Capacitação		4	4
Gestão	4	17	21
Informação		6	6
Controle Social	4	15	19

Classificação das Constatatóes	Conformidade		
	Conforme	Não Conforme	Total Geral
Conselho de Saúde	4	14	18
CIST	2	9	11
Fiscalização de Recursos Financeiros	1	5	6
Recursos Financeiros	1		1
Ouvidoria/Central de Atendimento ao Usuário		1	1
Documentação/Registros		1	1
Controles Internos	16	36	52
Estrutura	1	1	2
Área Física	1	1	2
Processo	15	35	50
Controle de estoques/Validade	1		1
Documentação/Registros	14	35	49
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde		1	1
Educação em Saúde		1	1
Formação/desenvolvimento de RH voltada às necessidades do SUS		1	1
Gestão Municipal	1	1	2
Assistência de Atenção Básica	1	1	2
Programação/Orçamento/Pagamento	1	1	2
Humanização da atenção e gestão da saúde	1	3	4
Direitos e deveres dos usuários	1	3	4
Acesso dos usuários às informações sobre saúde	1	3	4
Programas Estratégicos	2	3	5
Estrutura	1	3	4
Capacidade Instalada		1	1
Estrutura Física		2	2
Recursos Humanos	1		1
Processo	1		1
Rotinas/Atividades	1		1
Recursos Financeiros	7	60	67
Contrato		11	11
Contrato de Empresa		8	8
Pagamento		3	3
Convênios	5	35	40
Comprovação de despesas	3	19	22
Formalização	2	10	12
Plano de Trabalho		1	1
Prestação de Contas		5	5
Execução Orçamentária	1	1	2
Comprovação de despesas	1		1
Prestação de Contas		1	1
Fundo a Fundo	1	9	10
Comprovação da Despesa		6	6
Execução		1	1
Movimentação Financeira	1		1
Plano de Aplicação		2	2
Licitação		4	4
Procedimento		4	4
Rede Cegonha – Contrato de Gestão		5	5
Comissão/Comitê de Acompanhamento/Monitoramento de Contratos		5	5

Classificação das Constatatóes	Conformidade		
	Conforme	Não Conforme	Total Geral
Constituição e Funcionamento		5	5
Rede Cegonha - Gestão	1	5	6
Vigilância e indicadores	1	5	6
Indicadores acompanhados	1	5	6
Regionalização, Planejamento e Programação	6	20	26
Estrutura Organizacional		1	1
Organograma/Estrutura Organizacional		1	1
Instrumentos de Planejamento - PPA		2	2
Sistemática de Elaboração/Conteúdo		2	2
Instrumentos de Planejamento - PS		4	4
Sistemática de Elaboração/Conteúdo		4	4
Instrumentos de Planejamento - RAG		2	2
Sistemática de Elaboração/Conteúdo		2	2
Plano de Saúde	1	5	6
Programação Anual de Saúde	1	1	2
Sistemática de Elaboração/Conteúdo		4	4
Relatório de Gestão	5	6	11
Aprovação pelo Conselho	1		1
Sistemática de Elaboração/Conteúdo	4	6	10
Regulação	2	30	32
Centrais de Regulação	1		1
Atendimento à Demanda/Lista de espera	1		1
Controle e Avaliação	1	30	31
Alimentação de Sistemas Informatizados		2	2
Atividades/Programação/Supervisão/Revisão		18	18
Cadastro		6	6
Contratualização		2	2
Controle Média Complexidade		1	1
Estruturação/Fundamentação Legal		1	1
Rotinas de Trabalho	1		1
Saúde do Trabalhador	34	98	132
Ações	19	31	50
Acesso	1	4	5
Diagnóstico	4	5	9
Registros	7	11	18
Utilização dos Protocolos	5	4	9
Vigilância em saúde	2	7	9
Estrutura Física	2	12	14
Instalações	2	12	14
Estruturação	4	10	14
Habilitação da unidade do CEREST	1	5	6
Rede Sentinela de Unidades de Saúde	3	5	8
Plano de Ações de Saúde do Trabalhador		4	4
Submetido ao Conselho		4	4
Produção de Informação	8	21	29
Base de dados	5	18	23
Sistemas de informação	3	3	6
Recursos Humanos	1	17	18
Composição da equipe	1	8	9
Qualificação da equipe		9	9

Classificação das Constatções	Conformidade		
	Conforme	Não Conforme	Total Geral
Recursos Materiais		1	1
Recursos de Informática		1	1
Regionalização		2	2
Municípios de Abrangência		2	2
Vigilância em Saúde	3	3	6
Vigilância Sanitária	3	3	6
Atividades desenvolvidas/Rotinas de Trabalho	3	2	5
Documentação/Registros		1	1
Total Geral	194	636	830

OBS.: Informações acumuladas de janeiro a agosto de 2025.

Fonte: Sisaud/SUS. Dados extraídos em 1º/9/2025.

Ao término da auditoria, é emitido um relatório final da atividade, em que são relatadas as conformidades e as não conformidades identificadas, relacionadas, respectivamente, à correta execução e inexecução ou execução deficiente de ações e serviços, relacionados às Políticas e Programas geridos pelo MS.

Neste relatório, são apresentadas as principais não conformidades, que, quando constatadas, o DenaSUS emite recomendações ao auditado, para que sejam corrigidas as falhas identificadas. Os relatórios também são encaminhados às áreas finalísticas do MS, para adoção de medidas de gestão, a partir dos achados da auditoria, assim como, em casos mais graves, solicitar a devolução dos recursos envolvidos ou até a instauração de tomada de contas especial.

Na Secretaria de Saúde Indígena (SESAI/MS), foi realizada uma auditoria com o objetivo de verificar a gestão e execução do Convênio n.º 882.477/2019, celebrado com a Missão Evangélica Caiuá, para atender o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) em Parintins/AM, onde foram identificadas falhas em todas as fases do convênio, bem como a inexistência de sistemática de controle interno para monitorar e avaliar as ações executadas.

Ainda, foram concluídas outras duas auditorias, nos municípios de Aracaju/SE e Porto Velho/RO, com o objetivo de avaliar, no âmbito da Atenção Primária, as ações de acolhimento e continuidade do cuidado, capacitação dos profissionais, registro de informações de saúde, gestão e estrutura de acesso à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Política Nacional de Saúde Mental, em que foram identificadas falhas em todas as ações, em especial, no acolhimento e continuidade do cuidado à saúde mental dos pacientes.

Outrossim, no 2º quadrimestre, foram realizadas 12 auditorias com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, relacionados ao valor das Emendas de Relatoria para incremento do Teto MAC repassado. A produção inserida nos sistemas de informação, SIA/SUS e SIH/SUS, foi comparada à média histórica lançada pelo ente. As principais não conformidades identificadas foram: incompatibilidade entre a capacidade instalada e a produção ambulatorial registrada no SIA/SUS; recebimento indevido de recursos repassados decorrentes de Emendas Parlamentares, haja vista a produção não comprovada inserida, abruptamente, no SIA/SUS; e ausência de monitoramento e análise pela gestão municipal da produção informada nos sistemas SIA/SUS e SIH/SUS, pelos estabelecimentos de saúde sob sua gestão.

Também, foram realizadas oito auditorias nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), com a finalidade de verificar a gestão dos Centros e o funcionamento dos serviços oferecidos. As auditorias identificaram 98 não conformidades, entre elas: ausência de requisitos de habilitação e de projeto de implantação; falta de rede sentinela, mapeamento territorial e protocolos clínicos; instrumentos de gestão incompletos; falhas nos registros de informações nos sistemas oficiais; insuficiência e baixa qualificação da equipe; ausência de planejamento orçamentário; infraestrutura inadequada; ineficiência da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador; e fragilidades no controle social e na fiscalização dos recursos federais pelos Conselhos de Saúde.

Por fim, foram realizadas 20 auditorias com o objetivo de verificar os procedimentos relacionados ao tratamento em oncologia, em especial quanto à correta cobrança desses procedimentos, por parte dos entes responsáveis. Como resultado, foram registradas 75 conformidades e 191 não conformidades.

Entre as principais não conformidades identificadas, destacam-se: inconsistência ou ausência de comprovação da realização de procedimentos, como internações com quimioterapia de administração contínua, cirurgias de reconstrução mamária com retalho miocutâneo e cirurgias de ressecção de tumor de partes moles; além do descumprimento dos prazos legais para realização das cirurgias oncológicas — de até 30 dias após o término da quimioterapia prévia, e de no máximo 60 dias antes da quimioterapia profilática.

Cooperação Técnica no SNA

Cabe ao DenaSUS, como coordenador do SNA, promover ações e estratégias para integrar os componentes⁶⁷ do sistema, alinhando a compreensão do papel da auditoria do SUS, tanto no planejamento das atividades, quanto no desenvolvimento dos seus técnicos e colaboradores. Para tanto, são realizadas as atividades de cooperação técnica voltadas à implantação, implementação e desenvolvimento dos componentes, em conformidade com os padrões e normas da auditoria interna governamental.

Atualmente, o SNA conta com um total de 287 componentes, estando presentes em todos os estados da federação. Esse total inclui 24 componentes estaduais e 263 componentes municipais. A seguir, apresentamos uma visão geral das atividades de cooperação técnica encerradas até o 2º quadrimestre de 2025.

Quadro 42 – Atividades de Cooperação Técnica Encerradas até o 2º Quadrimestre de 2025 – Por tipo de Atividade

Atividade	Total
Apoio à implantação do componente	20
Apoio à implementação do componente	14
Interação e integração com os componentes	5
Interação com os Gestores e Conselhos de Saúde	3
Interação demais órgãos controle público interno/externo	3
Total Geral	45

OBS.: Informações acumuladas de janeiro a agosto de 2025.

Fonte: Sisaud/SUS. Dados extraídos em 1º/9/2025.

⁶⁷ Os componentes são unidades de auditoria interna do SUS localizadas em cada nível de governo, sob a supervisão da respectiva direção do SUS e integram o Sistema Nacional de Auditoria (SNA).